

目录

第一章 天生依赖.....	1
阴谋.....	1
历史的劣根.....	1
男权造成的依赖性.....	3
依赖信条.....	5
女性权威.....	10
命名.....	12
感情痛苦及生理效应.....	15
治疗即康复.....	17
第二章 女性智慧模式.....	20
能量系统.....	20
身体的意志.....	22
女性智力体现.....	26
观念即身体.....	29
生理机能.....	33
治疗.....	34
第三章 女性内省.....	44
倾听你的身体与它的需求.....	44
走出过去的阴影.....	47
了解潜意识的途径.....	49
直觉和直觉的引导.....	49
内在引导系统的工作方式.....	50
了解我们不愿做的事.....	52
第四章 女性能量.....	57
物质、能量连续体.....	57
怎样医治能量流失.....	58
地球的能量.....	61

能量中心	62
第一能量中心：家庭创伤如何存储于体内	66
第二能量中心：象征性的创造空间	68
第三能量中心：自我意识和个人力量	70
原型与前三个能量中心	71
羞耻心与前三个能量中心	73
第四能量中心	73
怎样治疗下部能量中心的创伤	76
其他能量中心问题	76
第五章 月经周期	79
女性智慧的剖析	79
女性生理循环的本质	79
卵泡和黄体阶段	80
通过月经周期进行治疗	84
我们的文化遗产	85
当你成了妻子	87
月经周期、避孕药和女性的直觉	88
痛经	92
治疗	93
营养治疗	94
药物治疗	96
精神治疗	97
女人们的故事	97
经期前综合征	99
诊断	100
经期前综合征的症状	100
月经周期（9）	104
月经周期（10）	110
经期前综合征和相互依赖	112

不规律的经期	113
什么是规律的经期	114
子宫壁过度生长（子宫内膜增生，囊肿和腺瘤增生）	115
治 疗	115
功能性子宫出血	116
传统疗法	117
严重的经期(经血过多)	121
治 疗	122
康复我们的月经期：为女儿做准备	124
通过月经周期创造健康	128
第六章 子 宫	129
能量解剖	131
慢性盆腔疼痛	133
子宫内膜异位	134
症 状	135
诊 断	136
常见的疑问	136
神经内分泌免疫的联系	139
治 疗	140
子宫肌瘤	145
症 状	145
常见的疑问	147
治 疗	151
治疗子宫肌瘤的计划	160
第七章 卵 巢	167
解 剖	168
卵巢囊肿	173
症状功能性卵巢囊肿	173
多囊肿卵巢	176

无月经症中身体与大脑的联系	176
治 疗	177
卵巢癌	186
“金铐”综合征	187
可能的帮助	188
诊 断	190
卵巢癌家族病史	191
做其他骨盆手术时把卵巢切除	191
常规治疗	193
关心你的子宫、卵巢和骨盆空间	193

一手情感资源请添加微信：kc58567 微信：tushu959

第一章 天生依赖

如果人们在精神观念中对某种社会秩序的否定已经日益成为一种社会风气，那么这个社会就会像即将爆发的火山一样发出巨大的轰隆声。总有一天，新的文明将在旧文明的断裂处诞生。

——丹尼斯·白瑞德、克里斯托弗·兰根特

阴谋

观念驱动身体。我们的身体由许多动力系统组成，这些动力系统又分别为个人的兴趣嗜好、人际关系、遗传、文化环境以及上述因素与行为的交互作用所影响。我们从来不曾认真地思考过我们身体内部的这些系统之间是如何相互作用的，更遑论个体与个体之间的相互作用了。尽管我已经进行了 20 多年的探索，但很显然，女性已从文化传统中潜移默化地接受并同化了许多观念和偏见，除非女性自身能够对这些观念和偏见进行批判性的反思并试图改变之，否则情况很难有所改观。因此，要重新激活我们的身体智慧以及我们与生俱来的能量，首先必须澄清我们在思考、检视自身身体的方式上所受的社会影响。

历史的劣根

最近 5000 年来，西方文明一直奠基于男权神话之上。换言之，男性、父亲居于权威地位。詹米克·怀沃特曾经说：“人类的所有信念与行为均源于隐匿的神话。”如果我们认可这一命题的话，那么，显而易见，我们的文化所尊奉的神话就是“父亲统治一切”。女性对自身身体，甚至自身生理系统的观点，都受到男权规则的支配，尽管男权规则只是诸多社会组织系统之中的一个。

惟其如此，假如不能首先改变自己，我们就不可能在我们的文化之中建立另外一种社会组织。我曾经无数次地在产房里看到这样的情形：刚刚分娩的产妇仅仅因为生下的不是一个男孩而歉意地看着她的丈夫，说：“亲爱的，对不起。”经历了九月怀胎的辛劳以及分娩的痛苦，却仅仅因为生下的不是男孩便要自责、道歉，这实在匪夷所思。然而在第二个女儿出生时，我还是非常震惊地听到了自己向丈夫道歉的声音。尽管我没有大声地说出来，但这些话语却清晰地响彻于我的脑海之中——完全是不由自主地。正是从那一刻起，我真切地感受到了对女性的拒斥意识是多么的古老并且根深蒂固，而这种拒斥不仅来自于异性，而且也来自于女性自身。

我们的文化传统传输给女孩子们的信息是：她们需要为自己的身体、自己的生命乃至自己的性别道歉。你难道没有注意到女性是多么频繁地在向别人道歉吗？不久前的一天，我在街上行走时，看到一个奔跑过来的男人撞到了在路边行走的一位女人身上，并且撞掉了她的挎包，然而诚惶诚恐地向对方道歉的却是那位女人。在许多女性身上，都不同程度地存在着因为自己是女性而产生的歉疚感，正如安娜·威尔逊·莎弗所说：“由于生而为女人的原罪不会因工作而获得解救。”从某种程度上来说，不管你获得多少学位，也不管你获得多少奖励，你都永远不会被解救。如果我们从呱呱落地之日起就必须为我们的存在而致歉的话，那么我们可以说，正是这个社会医疗系统抑制了我们这个“第二阶层”的身体智慧。直言之，正是男性中心主义在宣扬这样一些观念：女人的身体是卑贱的，女性必须被控制。

我们的文化习惯于否认虽藏不露却无处不在的问题。在我的医疗实践中我第一次发现，对女性的歧视也是一种或隐或现的流行病。我还发现了女性歧视是怎样在女性身体内为这种流行病搭建舞台的。请看下面一组材料：按照格劳瑞·白吉曼博士的估计，差不多 38% 的美国妇女在孩提时遭受过性骚扰。由于众所周知的原因，性骚扰的统计数字极不准确，大约只有 20% 的个案会得到有关部门的注意，因此上述比例肯定还应该更高。一个美国妇女在一生中三分之一的时间里有过被强奸的危险，大约 50% 的已婚妇女在婚后至少遭受过一次殴打。李·迪

克斯泰因博士的研究表明，试图自杀的黑人妇女中有二分之一，白人妇女中有四分之一是因为不堪忍受丈夫的辱骂和殴打。世界观察组织成员洛里·海斯的研究指出：世界上因营养不良而死亡的女性儿童数量是男性儿童的四倍，其中的原因是食物被优先提供给了后者。依照联合国妇女状况的报告，妇女负担了全球三分之一的工作量，却只能获得全球工资的十分之一，她们所拥有的财富则少于全球财富的 11%。全美大学联合会曾就性别偏见在校园里做过一次调查，结果表明，男生在课堂上引起老师注意的次数是女生的五倍，被老师提问的次数则是女生的八倍。

男权造成的依赖性

对西方文明影响深远的基督教创世学说通过夏娃传递了这样一个信息：女人的身体以及女人的性欲是人类堕落的罪恶之源。千百年以来，女性仅仅因为她们的性别而不得不为无数的罪行承担罪责，并为此而遭受鞭打、辱骂、火柱之刑以及道义的谴责。我们似乎不应忘记，即使是在急剧变化的本世纪，女性也只是到了 1920 年才赢得选举权的！

1953 年，西蒙·波伏娃在她的《第二性》一书中写道：“男人从上帝那里受益无穷，因为上帝认可他们写就的礼仪规范。自从男人开始了对女人的统治以来，最值得大书特书的是君临一切的上帝亲自将象征权威的祭袍穿在了男人身上。不论是对犹太人，还是基督徒来说，男人都是神圣权力的掌管者；正是对上帝的畏惧压抑了被蹂躏的女性的反叛冲动。”对西方社会的许多传统来说，男性即统治者的观念可谓根深蒂固。

当今社会的父权体制要求女性——即社会的第二阶层——要么乖乖放弃她们的希望和梦想，要么转而去迎合男性和家庭的需求。这样一种社会体制，阻碍或者否定了女性自我表达与自我实现的要求，而这势必会带给女性以情感上的巨大痛苦。为了逃避这种痛苦，女性大都沉溺于物质享受，并且衍生出了各种各样

的享乐行为，而这又反过来使得女性自身陷入了永无止境的被指责的恶性循环之中。不管是被别人指责，还是自我指责，都是一种病态。而即使我们病了，我们还是只能求助于这样一个贬斥我们身体的男权医疗体系。我们中间的许多人没有得到妥善的治疗，或者至少没有得到男性在同样病症中所得到的治疗。正是由于医疗机构不能提供诊断与治疗，我们的病情往往日趋严重，并且产生了慢性的健康问题，这种恶性循环是当今医疗业的典型特征。而越来越多的女性则发现，试图使自己变得“像男子一样”同样是在拿自己的身体冒险。

安娜·威尔逊·莎弗写道：“任何东西都有可能成为瘾品，不管它是某种特定的物质（例如酒类），还是一个过程（例如工作）。这是因为瘾品的目的或作用是在我们自身和我们对感觉的警觉之间安放一服缓冲剂。瘾品使我们麻醉，使我们与所感知的事物脱离联系。”而真正的行之有效的策略则是：当我们意识到了情感上的痛苦并试图去缓解这种痛苦时，我们能迅速地与我们的情感建立联系。感情是我们内在的引导系统。要改变现状，首要的一步就是要与我们内在的痛苦建立联系。很显然，这需要一种新的治疗态度和一种新的智慧。

要理解对女性来说最为重要的主要症状，最重要的是要搞清楚男权主义与依赖体制之间的关联。“男权”这个词，常常是被用来谴责男人的，但是很遗憾，这种谴责恰恰变成了人们维护那些对其带来了伤害的体制的行之有效的行为。尽管男性和女性总在相互指责，但不管是男人、女人，还是整个社会都无从取得进步。我们要求取得进步，就必须将指责置于身后。不论男人还是女人实际上都在强化着我们的依赖行为和依赖性。通过将男权制度命名为“依赖体制”，莎弗戏剧化地深化了我们对社会问题的了解。她使我们看到：现行社会的运作方式无论对男性还是女性都是有害的，而无论男性还是女性又都不遗余力地在维系着这个制度。我非常感谢她敏锐的洞察力，正是在她的启发之下我才写出了这本书。将男权制度称作“依赖体制”同时指出这种体制伤害男性与女性的不同方法，这无疑是在强调女权主义的重要意义及其光明前景。莎弗的这些分析对医疗思想产生了深远的影响，而我本人真正接纳这些思想是在退休以后。在《威廉姆斯妇科学》这本权威著作的 1980 年版的索引中，我发现了这样一个条目：“《男权主义》，男

性，内容丰富，1~1102 页。”“1~1102”指的是全书的篇幅。究竟是哪个匿名的编辑或编者插入了这样一个建议性的条目呢？我们也许永远不得而知。

我非常赞同索尼亚·约翰逊对女权主义的定义，因为其中包括了发展的思想：“女权主义是古已有之的一种思想。在古代文化和哲学的深层，是一种贴着‘女性’标签的男权制，因为这对整个人类来说是必要的。女权主义和男权主义最重要的区别在于：女权主义倡导普遍平等，非暴力地解决问题，与自然的和谐，等等。”

依赖信条

你应该试着反思一下你是怎样参与到这个依赖体制中来的。只有当你认清了自己在这个相互作用的体制中所扮演的角色，你个人的健康以及作为一个社会整体的女性健康才能得以改善。看看下面所描述的这些关于女性的文化态度是否也束缚了你自己。这将有助于你对自己身体和健康问题的认识。

信条一：疾病是敌人

依赖体制是这样一个社会，它要么是在准备战争，要么是在恢复战争创伤。这种社会把破坏与暴力的价值置于发展与和平之上。如果我们承认一个社会在某个事物上的投资是评价该事物价值的一个标准的话，那么我们只要看一看我们社会在防卫方面的投资就不难发现我们的社会更关心什么。事实上，这个社会每分钟内花在武器上的资金可以为 2000 名营养不良的儿童提供一年的食物。而一辆军用坦克的价格可以建造能供 30,000 名学生上课的教室。

与此相应，医疗机构在描述我们的身体时，不是心平气和地将它看作一个与健康息息相关的自然系统，而是把它视为一个军事地带。军事化的隐喻在西方医疗用语中极为流行。疾病，一个肿瘤，就是一个“敌人”，必须不惜一切代价加

以消灭。一种病情很少被视为一种信号而引起人们的注意。一种即使是用以保持身体平衡的免疫系统，也要用军事化的术语加以描述：该系统是用来杀灭淋巴细胞的。最近，在我们中心举行的一次病毒会议上，一位无线电专家如是说：“我们向该地区（此处指骨盆）发射的炮弹没有能够杜绝病情的发生。”

我认为，现代医学在治疗过程中对药物和手术的偏爱乃是富有侵略性的男权制的一部分，或者说是一种近似于吸毒的方法，而这种方法又引发新的疾病。与药品、化学疗法与放射治疗这些“重武器”相比，那种自然的、无毒的治疗被认为是低效的。曾被反复研究，并被证明疗效显著的非药物治疗法、自然疗法，则完全被忽视了；提供全面护理的治疗则遭到了否定；成效卓著的研究同样得不到重视。被弃之不顾的一个经典例子是——这样的例子还有很多——对祈祷之作用的研究。这种研究确实有双重的盲目性：不论是医生、护士还是病人都不知道是在向谁祈祷。但同样是在做冠状动脉治疗的一组病人当中，那些被祈祷者所祈祷的病人很少丧失信心，很少需要做心脏起搏和人口呼吸，也很少被感染，很少使用利尿剂，而那些不被祈祷的病人情况则要糟糕得多。

如果一种药物有如此奇效而不被使用，那一定会被认为是不道德的。正因为祈祷有上述诸多好处，且没有任何副作用，所以一位真正的科学家对此孜孜不倦并试图做更深入的研究。然而伯尼·西格尔博士在医院休息室的公报栏中贴出自己的成果后仅几个小时，他的一位同事居然在第一页上赫然写下了“狗屎”两个字。

在依赖体制看来，身体比心智卑贱，因而身体要受理性统治。这种体制经常教导我们不要太在意疲劳、饥饿、不适以及治疗和营养的需要。它还引导我们把身体看作一个敌人，尤其当身体传递出一些我们不太愿意聆听的信息时，更是如此。这种文化经常会把身体这个信使连同它所携带的书信一起杀死。但无论如何，我们的身体仍是我们拥有的最好的健康系统——假如我们知道如何聆听身体传达的信息的话。

信条二：医学万能

医疗系统向来被认为是健康的保障，一旦我们对身体和健康有了怀疑，我们总习惯于向医生求助。我们已经被灌输了一个医学神话——医生比我们更了解我们的身体，应当由专家来主持治疗。当我询问对方身体出了什么毛病时，女性们有时竟会如是回答：“应该是你来告诉我——你是医生！”对此我已不感到奇怪。对某些女性来说，医生就像丈夫、神父一样，是高高在上的权威。其实任何一个女性比别的任何一个人更了解自己。女性对自己的身体与自己的判断总是持一种矛盾心态，这往往会变成一种心理影响。比如，最近，一位妇女就对我说：“我不相信医生，也不喜欢吃药，尽管如此，我还是要去看医生，还是要被送去接受检查。我向一个又一个医生请教，而他们毫无例外要么给我药，要么为我做手术，这实在让人忍无可忍。”更有甚者，她们干脆拒绝别的选择，而坚信只有药物与手术最为可靠。总之，绝大多数女性已经被训练得只会向外部世界寻求答案。毕竟，我们生活在这样一个社会里：在所谓的专家面前，个体的意见总是被怀疑、被蔑视。在这样的一个社会中，如果没有坚实的外在的帮助，要想改善并维持健康，是很难被尊重、被鼓励的，甚至于根本就不被承认。

作为一名医生，我也曾经被训练成一个专制的、无所不知的专家。反之，就病人来说，则习惯于认为医生乃是健康行为的典范。比如，我的病人在耽误了一次巴氏涂片检查后，通常会认为我要向她们大发雷霆，而事实上，我本人就很少做这样的检查！加利福尼亚大学的一份调查报告表明，50%的医生自己没有私人医生——而这恰恰是所有的医生都会送给病人的建议。20%的医生不进行身体锻炼，7%的医生承认自己饮酒过度，50%的女医生甚至不进行每月一次的乳房自我检查！然而人们居然会普遍地将自己的身体交由这些恰恰是非健康生活之样板的人去掌管！

医学只关注病理，科学家很少对健康者进行研究。如果一个顽症或绝症患者在经过严格的医学检查并被宣判无法救治之后，居然完全康复了，那么，专家们不是去研究这些病人何以康复，而是去反思自己的诊断在哪里出了毛病。在卫生

学校时，我曾护理过病人与死者，我学习了有可能出错的各种情况。我学习了预防各种事故的办法及应急措施。作为一名妇产科医生，我被告知，任何一个医疗过程，任何一次分娩，都是需要“慎重起见的诊断”，一不小心，就有可能酿成灾难。医生们从来不曾怀疑过这种训练的合理性。事实上，医生们带进产房的恐惧和紧张会加重产妇的焦虑，并使体内的激素分泌失调，如果这种情况得不到缓解，那么过重的心理压力最终会使难产和剖腹产的比例大幅上升。

我们的文化及其医疗体系笃信技术和实验可以拯救我们，没有什么事情不可以被控制、被量化，只要尽可能多地进行实验，我们就可以获得更多的数据，从而使我们有能力进一步改善健康状况，根治疾病，并且生活得越来越幸福。我们还相信只要不吝惜“金钱”，就可以买回我们想要的一切答案。于是，我们又一次忽视或者说怀疑了我们的内在引导系统以及我们自身的恢复能力。

如果医生对某种病理不太有把握，他就会进行大量的实验。他们被告知，对没有把握的病情进行处置是不允许的。对医生来说，从实验中获得的信息、数据越多，他们的诊断就越有信心，尽管有些时候他们对信息、数据的信任本身就尚待证明。而就病人而言，同样，如果医生不能给出确切的诊断，他们就会忧心忡忡。他们希望对病情有一个准确无误的了解。比如，一个生殖器疱疹患者希望知道这样一些问题：“我是如何染上这种病的？”“我怎样才能知道我没有传染给别人？”事实上这些问题根本就不可能有绝对准确的答案。

信条三：女人的身体本身就是不正常的

正因为是在依赖体制下，一切以男性为标准，因此许多女性在观念深处都相信自己身体的某些地方一定“出了差错”。她们相信自己身体的许多方面必须被控制，她们相信自己的体味和体形惹人讨厌。社会观念迫使女性相信自己的身体在根本上是不洁的——因此需要在监视下不断地“净化”，以免“犯罪”。女性体内的脂肪天生要比男性的多，随着最近几十年中营养状况的改善，今天的女性也比她们的母辈和祖母辈更高大一些。按照我们的文化观念，标准的女性体重应该比

美国妇女平均体重轻 17%。难怪在厌食症患者中，女性是男性的十倍，而且这个比例还在上升。

对女性身体的这种污蔑使得许多女人对自己的身体及其发育过程既恐惧又厌恶。比如许多女人从来没有触摸过自己的乳房，她们也不想知道自己乳房的触觉反应，因为她们担心会有某种东西被发现。她们大概认为触摸乳房是一种罪孽，在她们看来，这无异于手淫，因为乳房是男人表达性欲的地方——在这里，我们再一次看到，女人已经完全地把自己的身体献给了男人。

医务工作者和女性自身都把原本是正常的生理现象，如月经、更年期、生育等看做是需要治疗的对象。从很小的时候起，女性就深信自己的身体内潜藏着许多行将爆发的事故，这种信念使得女性把自己的未来与自己的身体紧密地联系在一起。我们的身体实际上从我们出生之后不久就被“医学化”了！

我们的文化对所有的自然现象都充满恐惧：出生、死亡、病愈，甚至活着。几乎每天我们都被教以恐惧。我大女儿七岁的一天，她和她的爸爸到我们家的后园里去砍树枝，突然，她大哭着跑到了屋里，手指上滴着血，原来她被草叶划破了手指。我非常冷静地用凉水洗净了她的手指，发现只是划破了一点皮。她抬起头，看着我，嘴里念着我教给她的一句非常有意义的格言：“在你害怕之前，你并没有受伤。”

由于我们的文化崇尚科学，认为科学乃是最“客观的”，因此我们也都认为凡贴着“科学”标签的事物都必定是真的。我们笃信科学能够帮助我们，但是从根本上来说，科学乃是一种文化结构，正如近年来它自身所表现出来的那样，其中充斥着依赖体制的所有偏见。事实上根本就没有哪个事物是绝对客观的数据。我们相信这个研究结果而否定另外一个，这完全取决于我们的文化偏见。而且所有的人都概莫能外。“所有的人都拥有自己神圣的不可侵犯的偏见。”在一次医学会议上，一位与会者曾这样说，“人类的大脑是一个独一无二的器官，它的功能就是对所有的新观念产生抗体”。

许多关于女性的常规医疗尤其缺乏科学根据，只是偏见的产物。至于这些偏见，则完全有违于身体与生俱来之智慧以及完善自身的力量。这些程序有很多源于代代相传的有关女人的情感判断。分娩经常要做的外阴切开手术（切除阴道与直肠之间的细胞组织，这样毫无根据的做法被认为是给胎儿的脑袋提供更大的空间？就是一个例子。最近的研究已表明，外阴切开手术增大出血量，加剧疼痛，并且还要冒骨盆被长期损害的危害。对此一些助产士们已经议论了许多年，然而临床中这种手术仍然在运用，其原则仅仅是因为医生们确信这样做可以“保护”盆骨不受损伤。只是最近几年，产科医生们才开始对这种例行程序的合理性产生了质疑，因为研究结果表明这种手术只有坏处，却没有任何好处。

女性权威

如果说真正的科学是以观察、实验、不断地调整思维过程、不断地纠正错误观念为基础，并且通过可以为经验证明的新发现而求得发展的话，那么要确立女性的内在引导机制，也须如此。首先，我已经发现了一种巨大的力量，那就是我们已经认识到了没有哪种科学研究可以准确地解释女性所特有的身体运作方式及其原因。归根结蒂，只有将我们的内在引导系统与我们的情感联结起来才是唯一可靠的出路。因为我们每个人的成长过程都有独特性，这种独特性从前不曾有过，以后也不会再有。科学必须坦言，它也有许多未知事物，并将这些事物交付给神秘、奇迹以及自然之智慧。

父亲曾经说过：“感受就是事实，必须多加注意。”然而当我开始接受科学训练不久，我就发现那些既不能被逻辑、理性解释，也不能被五种感官度量的感觉、直觉、精神以及许多生活体验，人们要么视而不见，要么置之不理。依赖体制非常害怕人们的情感反应，因为情感反应超出了这一体制的范围。反之，依赖体制非常注重对情感的控制。女性的身体由许多循环组成，这些循环的潮起潮落完全依据着自然的节奏，这在女性情感及其对调节的需求等方面体现得最为明显。然而我们的社会却千方百计地要限制我们的所知所感。

在依赖体制中，人们的行为大都带有防卫性、否定性，而女性尤其明显。比如，当我给一位孕妇做检查时，发现她的血糖指数升高了，这位孕妇马上对她的饮食习惯产生了怀疑。像许多孕妇一样，她矢口否认自己吃过什么不恰当的食物，而且根本没有吃过甜食——因为她为自己在不知不觉中“吸收”了甜食而深感羞愧，然而实际上任何一个孕妇都有一种想吃甜食的强烈冲动。显然，她已经进入了防御状态，并且认为她的身体因为血糖含量增多而背叛了她。为了教导她如何使她自己及胎儿获得更好的营养以及如何选择健康的食品，我不得不首先消除她的防卫心理，其实她为此所花的时间与精力如果用在保持身体健康上，效果将会更好。

由于文化熏陶而形成的这些习以为常的行为给我们的身体和精神带来了巨大的情感、生理影响。这些习惯使我们与自身的内在引导系统以及情感失去了联系。这使得我们始终处于痛苦之中，而这种痛苦反过来又延长了上述联系中断的时间。为了摆脱痛苦，我们需要付出很多的能量，为此我们常常会求助于那些使我们上瘾的东西，比如毒品，因为毒品可以使我们不必直面不幸与痛苦。

几乎每个人都知道酗酒和吸毒对身体有害无益。我丈夫是一位整形外科医生，他处理的急诊病例有 50% 都源于酗酒。诚如我们医院的一位外科医生所说：“假如没有人抽烟喝酒的话，我将会失业！”然而，的确有很多人不明白，许多不加节制的行为，如劳动过度、暴饮暴食等，对生命来说同样是巨大的、甚至是致命的损害，因为这些行为压制、否定了我们的生命感受。

过度的性行为不但会给许多妇科病埋下隐患，而且会直接传染许多性病，如湿疣、疱疹、宫颈癌等。我曾经碰到这样一个病人，她丈夫曾因酗酒过度而中毒，后来虽然康复了，但她却不得不因此而忍受阴道炎的长期折磨。除此之外我实在找不出什么别的原因。最后，她终于认识到她丈夫“多年来都把每天与她性交作为治疗自己的手段”。“我把自己的身体看做是他的工具——他可以随心所欲地使用，他用性交代替了酒，而我始终认为这是妻子应尽的义务。”

我的经验使我相信，健康状况的改善和卫生教育对于减少医疗费用根本于事无补，除非全社会认识到了对某些东西的迷恋和依赖的危害性有多大以及它带给个人的痛苦是多么深重。惟其如此，我们才可以真正地治好我们的疾病，获得健康。我认识的所有肥胖妇女都非常清楚自己“应该”吃什么。她们根本不需要更多的营养学知识。她们需要做的第一件事情是去感受过度节食带来的痛苦。而只有当她们能自己掌管自己的身体，由自己的内在引导系统来引导自己——从根本上相信自己的智慧时，这一切才会发生。

命名

要使你的生活、你的健康有一个全新的改变，首先要学会去命名你目前的经验，并且让自己完全地、充满激情地、全身心地体会这些经验。80年代的时候，我开始对自己的好人主义进行命名，这是非常关键的一步。在这之前，当我还没有与自己的内在引导系统建立联系时，我总是通过别人来确证自己并且告诉自己这样做没错，我按照别人的暗示去做、去感受、去观看，并且总是用别人的标准来审视自己。我相信，假如有人需要我，而我却对他说了“不”，那么我将不再被别人倚重，也不再讨人喜爱。

最后终于明白，我之所以乐于帮助所有有求于我的人，同意别人的所有观点，对所有的人都说“是”，是因为我笃信这样一个信条：只要我对别人说“是”，我就会赢得别人的喜爱。其实这对双方都无裨益，因为当我把自己置于某人的救助者的位置时，我就替代了他们自己本身具有的更强大的力量，也替代了他们的内在引导系统，换言之，我让他们切断了与自身力量之间的关联。我的行为实际上给他们带来的恰恰是伤害。现在我已经对这种行为有了清楚的认识，并把它命名为“沉溺于对他人的依赖”。现在假如有人向我求助，我会稍等一会儿，分析一下我的处境，听听我的内在引导系统的意见，然后再做出反应。

在我们这样一个依附社会中，最典型的性格莫过于依赖性。依赖性是这样一

种状态，由于你不能照顾自己，那么你设想别人或某个外在的事物会来照顾你。莎弗写道：“具有依赖性特征的人总是依靠别人来满足自己的情感、心理、智力及精神需求。”许多世纪以来，女人依靠男人来满足自己的经济需要。（这并不是说她们被提供了足够的选择，因为女人被看做是男人的财产。）而男人则依靠女人来满足自己的感情需要。我的一个病人曾谈起她以前的一次婚姻：“我们曾经达成协议，他来挣钱，我提供感情。”克莱瑞恩·宾克勒·伊斯泰恩指出，女性之所以没有能够更多地挖掘其本能，是因为她们花费了太多的时间向战争中的男人求助——有人是在真正的战场上，有人则是在法制化的美国。

依赖关系引发的一个问题是它妨碍两性之间真正的亲密。真正的亲密应该是双方的参与，而不是某一个人独断的需求。我父母曾经警告我：“如果一个男人对你说‘我需要你’，千万别理他。”这是一个非常好的建议。

对日常生活中的依赖性进行命名可以使我们摆脱一个文化囚笼，这个文化囚笼影响了几乎每一个女性——我指的是这样一个定义：所谓“好”女人，就是要去满足任何一个人的要求，而丝毫不考虑自己。当你的理智要去命名一种经验时，首先要明白你的身体对这一经验的感受。是的，让你自己的身体去感受它。否则，你的行为——还有你的健康——都不会有什么变化。一旦我们用我们的身体和感情有意识地命名了某种经验，并且将其内化到了意识深处，这种经验就不可能再对我们发生无意识的影响了。只有到了这时，我们才可以开始审视我们究竟怎样影响并延缓了我们自己的一系列问题。对影响我们的事物进行合理的命名是摆脱其影响的开始。许多时候情况得不到改善，除非我们能真正感受到事情是多么糟糕（或曾经是多么糟糕）。这有助于释放长期以来被压制、束缚、否定、忽视的情感和生理能量。当我能够不借助判断而准确感受自己时，我们便开始释放自己的能量了，只有到了这个时候我们才开始了向希望之所的迈进。表 1 可以帮助你对你依赖性格进行命名。

我的一位病人长期患有阴道疱疹，这使她痛苦不堪，所有的常规药物都不起作用，她甚至尝试了改变饮食习惯，结果仍然无济于事。为了医治这随时都会复

发的顽症她花费了三年时间，最后，得出这样一个结论：“也许我应该停顿下来，说出我所受的伤害。当我还是小孩子的时候发生的事情，我还没有能力把这件事告诉我母亲。”正是从她向我袒露真情的那一刻起，她的病情有了好转。她告诉我，她的父亲多年来一直强迫与她发生性行为，而她母亲从来也不相信她。慢慢地，她揭开了自己的伤口，并且命名它们，而康复也就开始了。还是出于对自己真诚的关心，她才能对过去的痛苦有一个清楚的认识，而由于她对自己对父母都有了清醒判断，这种痛苦本身变得不那么重要了。随着这一切的进行，她的病情慢慢地减轻了。她开始了一种创造性的生活，她成了一名佳作迭出的作家，她的疾病再也没有犯过。

把我们的社会命名为“依赖体制”，把身处其中的我们自己的行为命名为依赖行为，这对于我自己的健康以及我的病人的健康都有极大的推进作用。一般来说，如果有足够多的人能够认识到这个体制在生活中是如何发生作用的，然后对它进行命名并对自己的行为做相应的调整，那么这种依赖体制将无以为继。一套依赖体制和这个体制中的任何一个个体都是按照同一种性格特征进行运作的。因此，依赖行为和依赖体制可以互相参照。我在我自己身上、在我的病人身上、在我的工作间、在我的职业中都可以看到依赖体制的特征。一个人在多大程度上注意到了自己身上的依赖性特征，然后命名它，改变它，那么他就在多大程度上提高了自己的健康水平。如果每一个个体都这么做的话，作为一个整体的社会就可以变得更趋健康。

假如我没有创造出这样一种生活，我的家人、同事以及所有我所爱的人都生活其中并且持有同样的观点的话，那么我肯定会像一般人那样，用一种我自己称作好人主义——而社会则称之为好人(或者好医生、好母亲、好护士、好妻子、好姐姐)的东西来约束我的个人要求。而现在，我周围已经聚集了许多业务上的同事和朋友，他们也都持一种平衡的生活信念。我们处理事务的态度是，每人按照自己的感受以及自己的生活各负其责——如果有必要，则给予或接受支持。这意味着只有当我有破坏性的行为时，才会引起同事们的注意——比如，当我已经准备停当要外出度假时却违心地说，我随时愿意被召回(假设没有意外发生的话)。

创造健康生活的一部分是允许别人按照自己的理解立身行事。没有人能替别人创造健康。我业已认识到自己不可能给别人以答案——任何一个人也都不能。只有个体自己能够在适当的时候走近她的内在引导系统。许多年以来，我一直在为别人寻求各种各样的答案，却从来没有考虑过自己，从今以后，我再也不会去灌输任何东西给任何人了。

许多女性的工作和家庭都还不足以给她们的健康以完全的支持。但是假如有足够多的人能够对我们自身做一个深刻的评价，能够命名我们的依附行为，并且执著地追求一种全面的、富有生机的生活，那么我们的工作和环境就可以改变。思想和意识对我们的个人生活有着深远的影响。

感情痛苦及生理效应

我们的情感、思想对我们有着深刻的影响，因为它们通过免疫系统、内分泌系统以及中枢神经系统和我们的身体联系在一起。所有的情绪，包括那些受压抑而未表达出来的，对我们的生理都有影响。未经宣泄的情绪就像是放在我们身体内的一颗嘀嗒作响的定时炸弹——它们是潜伏的疾病。

一种压抑女性的文化从一开始就为健康问题搭建了舞台，因为女性生活的许多方面都影响到健康状况。数以百万计的女性患有慢性的骨盆疼痛、阴道包囊、阴道湿疣、子宫内膜异位以及宫颈发育异常(用巴氏涂片试验可以观察到的细胞病变)——所有发病的器官都是女性独有的。这些状况正是我们的身体借以向我们言说的语言。通过这些状况，我们的身体告诉我们，我们需要从深层的、经常是无意识的创伤开始治疗——这方面我们做得还远远不够。我们的身体还告诉我们，从某种意义上说，我们被玷污了。

一个 41 岁的行政职员曾经因为患有难以忍受的阵发性皮肤炽热前来就医，她服用了超过常量三倍的雌性激素仍不能解除其病症。阵发性皮肤炽热病不仅与

雌性激素的减少有关，它还与神经性内分泌有关，一旦压力增大，病症就会加重。当一个女人感受沉重的压力时，她的阵发性皮肤炽热症就会自觉不自觉地延长并且加重。这位病人两年前曾做过一次严重的子宫内膜异位手术，这次手术使她患上了难以忍受的骨盆疼痛症。最后她不得不做了子宫切除手术并切除了卵巢。现在她看起来已经复原了，不必再受病痛折磨了。为了向我讲述下面的这件事情，她用了整整两年时间来鼓起自己的勇气。6岁时，在一家糖果店的地下室里，她被店主强暴了。当时她感觉自己完全惊呆了，连话也说不出。她说：“我完全麻木了。那家伙让我千万不要告诉别人，否则他就不喜欢我了。我羞愧得无地自容。”即使在她告诉我的时候，她依然觉得自己做了一件错事，她觉得自己很坏。后来她告诉我，当她离开我的办公室的时候，她仍然坚信，既然我已知道了事情的真相，那么我将不再喜欢她。

因为这个流氓的暴行，我的这位病人从孩子时候起就开始了患病的历史。成年以后，她的痛苦越来越严重，直至她被迫做了子宫切除手术。应该说这次手术对她来说是一次解脱，因为她后来对我说，从此以后，她开始了她内在的生命旅程，并且有了进一步的康复。身体常常把我们的注意力吸引到“罪恶的一幕”上来，从而帮助我们对其治疗。

在经过了对“女性与生俱来的原罪”，以及由此而生的情感批判之后，这位病人进入了高等学府，并获得了工商管理硕士学位，之后，她在两个工作中都连续取得成功。她通过不停地工作、奋斗，获得更多的学位，以此来“证明自己”，并且摆脱困扰已久的情感痛苦以及认为自己是卑贱的、坏的这样一种观念。她的许多信念都源自依赖体制并且在这一体制中被强化，她至今还不曾为她的经历流过一滴眼泪，我相信一旦她能在感情上解脱出来，她将大获裨益。

我非常赞同病人的这一说法：她的生理疾病是由精神创伤引起的。我并不是说童年的性暴力“直接导致”了子宫内膜异位或者慢性骨盆疼痛。我想要说的是，像我的许多病人一样，童年的性暴力在她的身体心理中留下了难以抚平的阴影。对她来说，要治疗这一创伤，唯一的办法是返回到这一体验之中，然后摆脱这一

体验，并将它永远地从生命体验中驱逐出去。

只有借助于自身对身体的感受，我们才可以理解我们的内在引导系统。然而我们却常常寄希望于学校告诉我们什么最值得学习，寄希望于政府来管理我们的事务，寄希望于医生能使我们对各种各样的病菌具有免疫力。我们深信，只要我们遵循这些原则，我们就可以万事大吉。一位新近患了阴道癌的病人说：“我简直不明白这一切是如何发生的。我每年都做检查，每年都做巴氏涂片试验，结果还是得了癌症。”像这位病人一样，我们中的许多人相信各种各样的检查本身就可以避免人们生病。

我那位上一年级的小女儿在学校的第一天就被告知，学生上厕所不应该超过一定的次数。我特地找这位老师谈了一次。我告诉这位老师，我经常在公共卫生间看到一些成年妇女因为便秘或泌尿系统问题而苦恼，而个中原因正在于她们小时候从家庭和学校中接受的这样或那样的规矩使她们不能正确地判断其生理需要。我说我不希望这样的事情发生在我女儿身上。我让我女儿参与了这次谈话，以便她能在需要的时候勇敢地走向卫生间。

治疗即康复

在依赖体制之下，我们不可能为自己创造一个新世界。假如我们不能清楚地认识到在日常生活中我们是如何与伤害我们的这一体制合谋的话，我们就永远面临着不能从永恒的罪孽中挣脱出来的危险，而我们也就等于永远是在谴责那些“置身事外”为我们解决问题的人。正像那些饱受虐待的妇女有一天终于认识到了假如她们安于现状就只有死路一条于是奋而脱离了这个体制一样，我们中的每个人也都必须时时处处认识到我们实际上正在与我们的压迫者合谋。

我有一位朋友，她在 50 年代时加入了天主教，而谈到为自己的身体而忏悔这一事件的影响时，她说：“我记得是在 7 岁的时候，我就不得不去做忏悔。我

要检讨自己是否有犯罪的意识和不洁的意识。我经常感觉到自己正在遭受可怕的、戒律的惩罚。这些戒律既不能言说，也无法言说——比如关于性好奇、手淫——但谁又可以对此进行言说呢？难道女孩子永远不可以对此进行言说吗？我是这一戒律的唯一囚犯吗？在忏悔过程中，这些戒律写在塑料卡片上用以引导那些犯了戒律的人，使他们意识到自己有‘不洁的思想和行为’。然而即使有这些明晰的戒律，我还是不愿意向坐在告解室炉火后面，浑身散发着烟草味和酒气，虽然朦朦胧胧，却和我一样有着血肉之躯的人忏悔。假如你不彻底地忏悔，那么你将被禁止领取圣餐，而假如你忏悔了，那么你又会因为你的灵魂深处的罪孽而被罚入地狱。(这似乎使你无所适从。)这是我平生第一次遇到两难的道德处境。

“于是我下意识地想要设计一个办法逃脱出来。当我 11 岁行成人礼时，马上就要领圣餐了，我突然昏倒在人群之中。我被搀出了教堂，我记得那是在教堂入口的台阶上，我重又可以自由地呼吸，聆听鸟鸣、感受阳光了，类似的情况延续了一年多的时间。我实在无法忍受教堂对人的折磨。我遭到了人们的嘲笑，我自己也不明白自己的身体到底出了什么毛病——冷汗、耳鸣、眼前一片漆黑。(后来我再也没有经历过这样的痛苦。)毋庸置疑，是那些苛刻而矛盾的戒律在无意识中击倒了我。”

许多女性也曾无意识之中被我们文化中的一些矛盾的道德要求所击倒。许多人已经开始认识到了这一点。只有意识到我们的病症并非特例，而是压制女性的文化体制之中的普遍现象时，我们才能尽快医治那些因太多地照顾他人而得的疾病，如骨盆疼痛、经前期综合征、慢性疲劳综合征等等。要恢复健康并且学会在每一天的生活中都保持健康，一个不可缺少的工作是要命名我们的体验——不管这种体验是多么的痛苦——只有这样，我们才能懂得，生活的动力就在我们的体内，而和过去的一切无关。

拥有一名私人医生或保健护士，由他来负责你的心理 / 身体检查诚然是很有帮助的，但最重要的是，我们应该清楚，我们的身体及其症候是我们的内在引导系统的一部分。假如我们已经认识到我们的观念和行为所维系的医疗体制并不能

帮助我们创造健康的话，我们大可不必对它过分依赖。如果我们坚持认为我们的疾病与症状，如子宫内膜异位、子宫肌瘤、经前期综合征都“仅仅与生理有关”而和生活的其他部分毫不相干的话，那么我们的治疗实际上就仍然是在参与并维系这个依赖体制。

另一方面，一旦我们学会了聆听我们的身体语言，我们就可以为医疗实验、医疗技术的决策提供更多的信息，这非常有助于我们的私人保健医生的诊断。我们必须像信任实验室教授一样信任我们自己以及我们自己的经验。曾经有这样一位病人，她的经期特别异常，只要一“陷入爱河”，马上就来月经。她最后终于相信，尽管她有时会闭经几个月，但并不需要做太多的激素检测。相反，她对月经的含义以及月经和情感的关系非常感兴趣。和这样一位女性一起工作，对我和其他医生来说都非常愉悦。医生和病人都认识到，其中既有我们非常熟悉的领域，有被我们视而不见的领域，也有神秘的未知领域。

阅读本书时，请你切记，我们每个人都面临着多种选择——每个人都有自己的内在引导系统，都可以获得精神的帮助，这些帮助会使我们尽可能的健康、欢乐和完整。从依赖体制中逃脱出来意味着要在一个对此持否定态度的文化中，学会完全按照内在要求进行生活。在这一征程中，我们的身体及身体的症状是我们最有力的同盟军，因为没有什么东西能如此迅捷地引起我们的注意。我们的身体是一个奇妙的晴雨表，我们过去的生活状况，我们对自己的关心程度都会一点不漏地被显示出来。

《巨变》一书的作者吉玛尼·格林在接受采访时曾说：“没有人知道真正的女人会是什么样子。在你还不知道女人之所以为女人时，你怎么可以评价女人呢？”而我却曾经见过真正的女人，而且我正在一天天地努力使自己变成一个真正的女人。我已经开始懂得了真正的女人的含义。而这已经对我的身体产生了良好的影响。不妨对自己做一次全面的、全新的思考，尤其不要忘记你女性身体的特有的智慧。你是如何感觉的，你对你的骨骼知道多少？我们的身体和感受乃是通达最后目标的通衢大道——没有比认识到这一点更振奋人心的了。

第二章 女性智慧模式

最后我发现意识和身体不可分割。意识并不仅仅局限于大脑，同样，精神也不应该凌驾于身体之上。如果我们知道基因是生存于肽之中的话，那么完全可以说，身体是心灵的外化。

——康达斯·帕特博士

(国家精神病研究所前首席脑生化专家)

精神和肉体由免疫系统、内分泌系统和中枢神经系统紧密地联系在一起。今天，精神、肉体的研究进一步证实了古代医疗传统的一个信念：身体和精神是一个整体。没有哪种疾病不同时既是精神的，情感的，又是生理的。

能量系统

人类由能量组成并由能量维系。我们的身体是一个不断更新能量、交换能量的动力场，而不是一个静态的生理结构。人体是一个全息结构，其中的每一部分都包含着整体的信息。借助于量子物理学，我们已经知道物质和能量——也可以称作精神——在亚原子的层次上是可以相互交换的。我所知道的一个最好的描述是：密度最高的精神是物质，密度最小的物质则是精神。我们可以把我们的身体看做是精神能量的实体化，心智活动以及日常的思想都是该能量的一部分。有充分的证据表明，它们可以对物质、对我们的身体产生影响。

因为情绪和思想会在身体内产生一种生化反应，所以心理因素以及感情因素对我们的身体有很大影响。只有把我们看做是一个与周围的能量永远处在相互交换状态之中的能量体系，我们才可以准确地理解身心一体的含义。皮肤并非我们

的界限。

尽管我们看不见这些用以组成并维持我们生命的能量，但毋庸置疑，它是我们至关重要的一个组成部分。它是生命的推动力，使我们的心脏跳动，使我们的肺进行呼吸，即使睡觉的时候，也是如此。每一个有过陪伴垂危病人经验的人都可以告诉你：就在人死的那一瞬间，发生了某种变化，肉身虽在，而那个真正的人却已离我们而去。

在个体内部，各个不同的能量场交互作用。不同个体之间，个体与世界之间也都互相交换能量。其存在业已被证明的能量交换对于人一生的成长及健康发展都至关重要。比如，迈阿密大学对早产儿的一项研究发现，那些经常被抚摸的婴儿的体重增长速度比不经常被抚摸的婴儿快 49%(两组婴儿被喂以同样数量的食物)。到第八个月的时候，这些经常被抚摸的婴儿比起刚出生时，身体长长了许多，脑袋也大了许多，而且很少出现神经系统方面的问题。那些很少被抚摸、搂抱的孩子，尽管也被喂养得很好，也得到了很好的照顾，却经常要面临死亡的威胁，因此给他们的诊断往往是：难以成活。

即使是一些偶发事故，一些在我们看来“不可思议”的事情，也被证明是和情绪有关系的。心理状况(或者能量场)是真正的“罪魁祸首”。一些研究结果表明，易于发生事故的个人都是有某种个性特征的，如冲动、仇恨、富有攻击性、无依无靠、压抑、悲伤、孤独、不可化解的忧郁等。当他们对别人感到气愤时，他们却倾向于对自己进行惩罚。用能量系统的语言来说，这种情况意味着，特定个体的能量场在与外在环境进行交换时，所运用的方式增加了事故发生的可能性。

很显然，人类的交互作用对健康影响很大。这种影响可以是积极的，也可以是消极的，一切取决于参与交换的个体的心理状况。从我们把我们自身理解为一个可以影响自身体验的能量场的那一刻起，我们就已经触及了潜伏在我们身体内部可用以治疗疾病、保持身体健康的最隐秘的力量。

信念影响身体，并且实实在在地构造着身体。我们从父母，从我们赖以生长的环境中继承了许多观念。流行病学专家雷纳德·萨冈博士曾主持过一项科学研究，专门对这一问题进行了探讨，结果表明，社会地位、教育程度、生活能力、与家庭和社团的亲密程度是决定个体生活定向的关键因素。在所有这些因素中，教育又是最重要的因素。对健康人所做的一个关于所有传染病指数的调查很清楚地表明，健康的决定因素并不是免疫能力、食物、饮用水源以及抗生素。事实上，早在盘尼西林和抗生素普遍使用之前，在本世纪初期，由传染病引发的死亡率就大幅度下降了。不论我们的背景如何，也不论我们过去的健康状况怎样，希望、自尊以及教育都是日常生活中保持健康的最重要的因素。所有的疾病都是受情绪影响造成的。詹尼·阿切特伯格博士曾经指出，癌症完全可以用心理学的方法，通过一些可变的心理因素——比如希望——进行诊断，这比医疗检测的效果要好得多。我们永远都拥有一种内在的能量，它能使我们在治疗疾病、保持身体健康方面接受更全面的教育。

我的一个病人曾对我说：“就在今天来你办公室的路上，我突然茅塞顿开。小的时候，为了引起妈妈的注意，唯一的办法就是生病。所以我多次骨折，后来又患了癌症，刚才又做了腹部布氏涂片试验，现在我终于认识到我再也用不着为了引起谁的注意而生病了。”她又补充说，当她在汽车中豁然开朗的那一刻，太阳冲破了云雾，使她的心绪更加光辉灿烂。

身体的意志

医学界现在已经开始把病人视为一个不断新陈代谢的生物体。我们已经懂得，身体就像一条信息和能量之河，它的各个部分之间都相互进行动力交换。比如，放射性同位素的研究已经表明，红血球每 28 天更新一次，而人体内的全部细胞则每六个月更新一次。正因为这种不停的新陈代谢，我们才得以每天都能保持健康。

尽管我们每天都要接受数百万种刺激的围攻，但我们的中枢神经系统和感觉器官却只选择并吸收那些有助于加强我们习得观念的刺激。一位曾获诺贝尔奖的专家强调了上述观念的重要性。科学家将小猫放在一个特定的环境中进行饲养，不管是小猫的圈舍，还是供小猫活动的房间，其墙壁都被饰以水平线。小猫长大后，被放归到正常的环境中，这时它只要看到垂直的事物，就会扑上去。反之亦然。如果小猫生活的环境中只有垂直的线条，那么长大后，只要看到是水平的事物，它就会猛扑上去。同样的实验也可以应用于人类。比如，从小饱受虐待的女孩长大后有受虐的倾向，她们对受虐形成了条件反射，因而已经不能适应充满爱心的人和环境。成年人的神经系统总是不断地强化着童年时所接受的信条，除非我们有意识地去改变童年的经历对我们造成的影响。成年人的许多疾病在童年时就已经埋下了种子，以后，我们的思想观念又不断地重复童年的经验，这无异于是在为疾病的种子施肥灌溉。

身心一体的科学，或曰精神神经免疫学，可以帮助我们解释生活环境对身体的影响。精神神经免疫学及相关研究表明，体内的激素反应，神经反应以及人体周围和人体内部微弱的电磁场共同构成了一个重要的桥梁，这座桥梁把文化造成的伤害和女性特有的妇科疾病及其他问题联系到了一起，前者一般被认为是“心理的”和“情绪的”，而后者则一般都被认为是“生理的”。

比如，许多遭受过性虐待的女性，常常把自己和身体看做是两回事。有些人甚至只用脖子以上的那部分身体去体验自己。我的一个病人，长期患有月经不调，她说：“我从不愿意去考虑任何有关下肢的问题。我仇恨我的下肢，我宁愿自己根本就没有下肢。”这番话对于了解她本人至关重要，它实际上已经表明了治疗所必需的第一步。她的月经不调不停地把她的注意力引向亟须治疗的那部分“不属于她的”身体。我的一位助手有时会让病人们画出自己的肖像。她告诉我说，其中一位慢性骨盆疼痛患者只画出了腰以上的部分。我的那位助手告诉这位妇女，也许她的骨盆正希望引起她的注意呢，而她竟然不理不睬！

身心一体的科学有助于解释何以情绪的、心理的创伤会转化为生理创伤，并

且有助于对这些创伤的治疗。所有的痛苦、对痛苦的所有调理以及所有的康复事件都同时是生理的、心理的、情绪的和精神的。

直到不久之前，科学家们仍然认为，神经的信息传输是一种线性传输。就像电线一样，在一个神经系统内，信息从一根神经传到另一根神经。但是我们已经懂得，身体的各个器官可以通过一种叫做神经肽的化学导体直接与大脑进行信息交换，反之亦然。神经肽在神经细胞之间传输信息。当我们的思想、情绪释发出信息时，神经肽中的接受细胞就负责将这些信息接受过来。过去人们一直认为，神经肽的接受区只限于大脑和神经组织。但是现在已经发现，神经肽的接受区遍布全身。康达思·帕特博士及其他研究者已经在内分泌系统、免疫系统以及神经系统的细胞中发现了一种由化学材料构成的脑神经系统，其作用就是接受神经肽信息。不仅如此，在其身体器官如肾和肠中间，都发现了这种被称作脑化学材料的信息接受区域。这种脑化学物是思想、情绪直接影响身体的途径之一。

不仅身体器官中没有专门区域用以接受经由神经肽传输的思想和情绪信息，而且这些器官本身以及免疫系统本身就可以扮演相同的角色。也就是说，我们的全身都可以感受，都可以表达情绪——我们的全身都可以“思考”、“感觉”。比如，白细胞不仅可以产生一种类似吗啡的止痛物质，而且可以接受这些止痛物质的反馈信息。这使得我们可以不借助药物而消除疼痛。研究结果已初步证明，子宫、卵巢以及乳腺组织也像大脑及其他器官一样，可以产生并能接受产生思想和情绪的神经化学物质，比如，激素就可以传输情绪和观念。同样，免疫系统也具有信息传输细胞，也可以接受神经肽的信息。卵巢和子宫可以分泌雌性激素和孕激素，这些激素都可以传递信息，并影响人的情绪和思想。这些器官，也都有特定的区域，用以接受大脑和免疫系统的信息。由此不难理解，当我们心情不佳时，我们的女性器官也会感到难过，而其机能也会受到影响。

我们的思想、情绪、心智直接与免疫系统、神经系统和内分泌系统以及其他器官进行信息交换。尽管传统上认为这些系统是相当独立的，并且一直对之进行分别的研究，但实质上，它们都不过是同一个系统的不同部门！当大脑进行思考

时，假如子宫、卵巢、白细胞以及心脏同时产生出与大脑一样的化学物质，那么又该把身体的哪一部分称为心灵呢？答案是：心灵无处不在。

已有的关于“心灵”的观念必须作相应的调整。心灵不再仅仅是与大脑、智力有关的思想观念；它存在于身体的每一个细胞之中。我们的每一个思想观念、每一种情绪都具有生物化学的意义，我的一个同事曾说“心灵就是细胞之间的空间”。因此，当你的子宫——即你的心灵的一部分——因痛苦和失血过多，开口向你说话时，难道你不应该仔细聆听吗？

我曾经问一位经血过多的已婚妇女，生活过得怎么样。这位妇女 35 岁，是一位律师。她勃然大怒，说：“我认为这是一个医学问题。”在她看来，这是个纯粹的生理问题，与生活中的其他所有重大事件都没有关系。我非常耐心地向她解释道，我要问的完全是同一个问题，我还告诉她，所有的症状都是“生理的”。她慢慢平静了下来，向我吐露了隐情：近来她有了婚外情，并且因此而感到罪孽深重。她还非常担心自己染上了性病。不正常的排气在婚外情之后不久就开始了。她讲述的这段经历使我得以给了她更妥善更有效的药物治疗。而她最后也终于明白，自己不应该将身体与生活分割开来。

另外一位病人因为慢性肌肉紧张引起的肩膀疼痛而来进行生物反馈治疗。在她试着放松肩膀上的肌肉时，她发现，只要她一想到某些特定的事情，肌肉的紧张度就会增加。其中的一件事情就是小时候挨打的经历。另外一件则是她丈夫身体不好，这给她带来了很多麻烦。反之，要是她想起了生活中高兴的一些事情，她的肌肉紧张就会减轻。她最后终于明白了，是她的担心、她的观念影响了她的身体。通过生物反馈治疗，她懂得了，肌肉组织也有感觉、思想和记忆，所有这些，都是身体智慧的组成部分。

精神和灵魂遍及我们的全身，它们远非理智可以把握。我们的内在引导系统首先通过感觉和身体智慧——而不是理智的思考与我们见面。假如我们仅凭智力去寻找内在引导系统——好像它存在于我们自身以及我们最深层的知识之外——

——那么，我们必将迷路，而我们的内在引导系统也将缄默不语。智力是一个很好的仆人，它服务于我们的直觉、内导系统、灵魂、上帝以及更高的力量——我们指的是那种能够使生命生机勃勃的精神能量。我们必须清楚地认识到：智力远远不能解释我们自己，通过遍及全身的心灵，我们完全可以找到我们的向导，惟其如此，我们才可以说是真正具有了内在的治疗能力。正如威廉·詹姆斯所说：“推动世界的力量潜藏于下意识的心灵之中。”

女性智力体现

女性可以同时通过身体和大脑去认识事物，其中的一个原因是女性的大脑原本如此：一旦两个大脑半球中的信息和身体内的信息有了联系，那么这些信息将很容易被我们获得。

我所受的学校教育告诉我，不要相信自己的思考，因为它不符合教育赖以奠基的二元论。比如，在多项选择题目中，我总是能够找出几乎每一个选项都正确的理由。我总是想得太多，总是能够看到所有事物之间的相互联系。老师在讲评我的错误时，经常对我说：“你考虑得太复杂。其实答案非常明显。”但对我来说，答案却总是不明显。既然我已经懂得了我的思想、情绪以及肉体之间的紧密联系，我将开始全面地发展我的智力。令人吃惊的一个事实是，有许多女人相信自己非常愚蠢。其实她们都具有很高的智慧，只不过她们的智慧被歪曲了而已。林达·麦卡福博士曾说过：“女性常常把她们的智力理解为被强加于自己头脑中的男性智力结构。”

我知道，我的说话和思考既有赖于两个脑半球的参与，又有赖于身体智慧的参与，这使得我永远是在用一种多极的、螺旋形的方法说话、思考。简·霍斯通曾描述过多极思维的形成过程：许多世纪以来，妇女们站立在她们的洞穴之中，一只手搅动着锅里的粥，一只手赶开身旁的孩子，同时用脚将毛茸茸的猛犸踢出门外。我们总是要同时注意不止一件事情——要仔细考虑行动所带来的后果——

当然不仅仅是带给我们自身的后果，而是带给全家甚至整个部落的后果。正因为总是要同时关注几件不同的事情，所以在长期的发展过程中，女性形成了与男性截然不同的大脑结构与思维模式。

对许多女性来说，连接左右半脑的部分即胼胝体，要比男性为厚。换言之，女性和男性的大脑是用不同方式“焊接的”。男性一般用左半脑思考问题、交流思想，他们的思维通常是线性的，分立的。这种思维喜欢“就事论事”。而女性正好相反，当她们表达思想时，要比男性使用更多的脑域。她们同时使用左右两个半脑。因为右半脑与身体的联系比左半脑更密切，所以当女性在说话和思考时，可以比男性更好地运用身体的智慧。

这并不是说，男性的大脑天生就缺乏这种能力，只不过若干世纪以来，他们这种能力没有被挖掘出来。就过去的 5000 年来说，西方社会普遍认为，左半脑的线性思维是一种高级的思维方式，而女性在言谈和思考时所使用的身体化方式则是低级的，“有待进化的”。《大脑的性别》一书的作者指出：“一般说来，男性直接将出现在大脑中的事物说出来，而女性在言谈时，则要调动许多信息。总之，女性大脑中的信息交换要比男性繁忙得多，也复杂得多。”遗憾的是，我们非但没有发展这种身体化的思维方式，相反却拒斥并贬低了这样一种能力。

在与社会语言学家德勃拉·塔纳的谈话中，罗伯特·比利说：“言词与感觉存在于不同的脑叶中。”我必须强调指出，这一命题只适用于大多数“右撇子”男人，它忽略了女性(以及男性)大脑的复杂性和独特性。“这意味着，”比利继续说，“女性能够比男性更迅速地将二者联系起来。女性有一条通往此地的高速公路。而且，正如米切尔·迈德指出的那样，男性只有一条崎岖不平的乡间公路，因此每掌握一个词汇，对你来说都非常幸运。”

每当我尽可能详尽地解释某件事情时，我丈夫总会对我说：“你能不能说得简短一些？你到底想要说什么？”这些话语中传达出来的是男人那种刻板的思维方法。不论我在思考或是言谈，我都想让我的语言把我大脑中和身体中的事物尽

可能丰富地表达出来。我非常喜欢玩味语言，常常流连其中，当我想要谈论一个事物时，我常常先要花一点时间搞清楚我对它的感受，在讲话之前，我要让我的整个身体和全部智慧共同形成我的思想。将自己的观念和思想说出去或者写下来有助于我更好地了解我自己。

相反，我丈夫说话总是尽可能地简短。他和大多数男人一样只关心主题、结果和解决方法。而且在他看来，任何事物都只有一个主题、一个结果、一种解决办法，除此以外都没有谈论的必要。大多数男人认为通往结论的过程是乏味而且没有价值的。乔治·凯勒博士和我一样，也是研究整体医学的，他说：“男人讲话不需要动词；女人讲话不需要名词。”他还用量子物理学来打比方——这门科学认为事物的粒子和波是完全不同的两个方面——凯勒发现：“男人说的是粒子语言，女人说的是波语言。”

多元的、形体化的思维使得大多数女人到杂货店时，即使不带清单也能记住要买的所有东西，包括临时想起来的一些必需品。我在做手术时，常常会想起这样一些事情：我的孩子们现在正在干什么？该买一些纸巾了，回家时应该买些面包。所有这些事情同时出现在我的脑海中。这叫做交互思维。我丈夫则正相反，他只能同时在脑海中思考一到两个问题，处理一到两件工作。我一次就可以买回来的东西，他常需要三次才能买齐。

男性和女性在思维方式上的区别经常出现在我的办公室。当我向一位男子解释他妻子的病情时，我经常告诉他：“注意，当我向你介绍你妻子的情况时，我可能会前后循环。我可能一会儿说说这儿，一会儿说说那儿。”我用手指画了个圆，“你可能会不耐烦，你可能会认为我所说的事情风马牛不相及。但实际上它们全都是有关联的。耐心点——我最后会回到最重要的问题上来，并且会让你看到它们之间的密切关系。”

在关于男性和女性思维方式的区别这一问题上，我和别的一些科学家的意见是矛盾的。但不管我们相信哪一种观点，我都坚信，女性要获得真正的健康，就

必须清楚地认识到她们想要得到的智慧的真正含义是什么，她们还必须认识到，这种智慧遍及她们的整个存在——身体、心灵以及精神。

观念即身体

思想乃是身体智慧的一部分。如果长久地持有并不断地重复一种思想，就会使之转变成一种信念。信念又会转变为生物机能。信念是一种能量巨大的驱动力，它为个体的生命和健康创造出生理基础。假如我们不能克服我们的情感创伤，那么也将会引发生理上的疾患，因为压抑的情绪会对我们的免疫系统和内分泌系统发生作用，并产生一种生物化学反应。比如许多疾病，如类风湿性关节炎、多发性硬化、某些甲状腺疾病以及红斑狼疮等，都被称为自体免疫疾病，也就是说，是自己的免疫系统攻击了我们的身体。如果没有从人体某处的深层获得破坏性的信息，免疫系统怎么会向自己赖以存在的母体的细胞发动进攻呢？精神上的压抑不仅会引发对自身具有破坏性的行为，而且会损害免疫系统功能。许多患有自体免疫系统疾病的女性情绪都比较低沉。比如，有研究表明，压力和孤独会激活隐伏的（不活跃的）疱疹病毒。同样的结论也适用于爱泼斯坦——巴尔病毒，这种病毒与慢性疲劳综合征有关。因此，尽管有超过 90% 的人被证明携带有爱泼斯坦——巴尔病毒，但真正患有该病的只是其中很少的一部分人，这应该是原因之一。同样由幽门细菌引起的胃溃疡患者以及躁动病患者，也是如此。情况尤其适用于女性，因为至少 80% 的自身免疫疾病患者是女性。甚至于子宫内膜异位、癫痫、提前绝经、不能生育以及慢性阴道炎等也都是自身免疫疾病。

个体信仰受文化背景的影响很大。公众普遍信奉的观念决定了社会的类型。就我们的社会而言，女性受到了太多的显而易见的压抑。有些研究已经表明，抑制免疫（抑制免疫系统的反应）的一种明显形式与心理紧张有着直接关系。如果情绪过度激动，那么身体就会分泌出内生性麻醉剂（一种类似吗啡的东西）和皮质类固醇（一种内肾上腺分泌的激素），它们会阻碍白细胞对癌症和传染病的免疫作用。与那些能够摆脱紧张感的人相比，常常有不幸感、失望感的人以及认为

自己的紧张处境无以改变的人的皮质胆固醇水平要高得多。他们的免疫能力受到的抑制也更重。那些常常感到自己有一种无可脱逃的紧张感的人事实上会产生出一种类似麻醉剂的东西（脑啡肽），它会使体内的细胞麻木（由紧张引起的感觉缺失），如果时间持续得很长的话，还会损坏这些细胞杀死癌细胞与病菌的能力。然而并非压力本身使免疫系统出了问题，而是压力无以解除这一观念——也就是说，任何人都无济于事——导致了免疫系统功能的损坏。

观念要比思想隐秘得多，而且我们很难改变它——认识到这一点非常重要。许多观念完全是无意识的，理智根本无以把握的。我从工作中——也从生活中——获知，我们中的许多人并不知道，破坏性的观念会损害我们的健康。这些观念不仅仅来自于理智——一般认为理智是可以控制的；它们还来自于身体的其他部分——这些部分存在于细胞组织之中，但过去一直不为人知。

珍妮是一个长着一头黑发的造型设计师，今年 45 岁。最近她来向我咨询。过去，她的月经一直是每 28 天来一次，但这几年出现了变化，大致是在 25 天至 34 天之间摇摆。她从来不曾有过月经不调，也从来没有过别的症状，因此她非常不安。在我看来，这完全正常，但别的医生却告诉她，月经周期的变化是癌症的预兆，并建议她去做子宫活组织检查。由于宫颈口太窄，活组织检查器放不进去，有人又建议她在麻醉后做扩张及搔刮手术。珍妮想听听另外的意见。

我告诉她不像是患了子宫癌，因此我建议她不要做扩张及搔刮手术。就算她非常担心并且一定要做，最后的结果也只能是证明她安然无恙。为了消除她的顾虑，我问起了她童年时代的病中体验，因为对女性来说，童年的病中体验对她的健康与疾病观念有着深远的影响。珍妮说：“我是独生女。母亲经常生病，她常年患有结肠病，我不得不照顾她。久而久之，我把自己身体内的一切变化都看做是一场灾难——就像发生在我母亲身上的一样。”

于是我问她：“如果你已经决定了要做扩张及搔刮检查，而且结果表明一切正常，那么这会不会减轻你的压力，使你不再联想到所谓的癌症呢？”她说恐怕

不会有什么效果，她仍会忧心忡忡。最后我们终于达成了共识：她对身体的基本观念以及她的过度敏感受童年经验影响很大，而所有这些都必须加以改变。而要改变她的童年经验，珍妮首先必须明白，她的恐惧并非全部存在于她的理智之中，而是主要存在于她的身体以及无意识之中。我总对珍妮以及有相同问题的女性说：“放宽心，你很好，没有任何问题，”我还告诉她们，“最重要的是头部。”这句话并没有充足的科学根据。珍妮的观念存在于她的大脑中，而她的大脑通于全身每一个器官。

要停止对癌症的幻想，珍妮还必须经历任何一个人都必须经历的一个治疗过程。为了向病人们解释这一过程，我运用了嗜酒者互诫协会的十二步骤法的前三个步骤。由于十二步骤法完全基于精神真理，我发现它可以运用于生活中的每个方面，而在所有这些方面，不论是我，还是我的病人，都在寻找指导。

第一个步骤是：“我们勇于承认自己无法抵御酒精的诱惑，我们的生活正变得一团糟。”你可以用你正沉溺其中或无法抵御的任何一种事物置换“酒精”这一词语。就珍妮来说，她必须承认，单靠理智，她无以改变自己的观念，也无以摆脱对癌症的幻想。她还必须承认，她的观念不但对健康无益，而且也是使其生活无法控制的原因之一。仅仅用理智来鞭策自己重新振作或者强迫自己改变观念，是几乎不可能的。

第二个步骤是：“我们认识到，有一种比我们自身更强大的力量可以使我们恢复健全的精神状态。”“比我们自身更强大的力量”就是我们的内在引导系统和身体智慧。“健全的精神状态”指的是内在的平静与安详。一旦我们认识到借助于一种比理智更强大的力量可以通向我们的内在引导系统，我们实际上就已经迈出了通向内在引导系统的第一步。

第三个步骤是：“我们决心改变自己的意志与生活，使其符合我们所理解的上帝的旨意。”（我将“上帝”置换为“内在引导系统或神圣的智慧”。）这个步骤完全超越了理智。认识到我们每人都有自己的内在引导系统，而且这个系统有能

力改变那些有害的观念。这是信念上的一个极大的飞跃，“决心”是一个至关重要的词语。对女性来说，要恢复健康，就必须下定决心。而且她必须乐于参加这种调理。当你发现你的理智对你的恐惧观念以及你的疾病无能为力时，参加“十二步骤治疗”集会，并且有步骤地进行操作将会很有帮助。

对珍妮以及情况类似的数以千计的女性来说，只要能够认识到她生存在恐惧与幻想中就不无裨益。我从来未遇见过这样一位女性，她从来不曾从家庭和文化中继承过任何有损健康的观念，但我们可以揭示我们身体的深层机制并使之转而支持我们的健康。我的许多病人在获知她们的疾病尽管是实实在在的生理疾病，但却往往伴随着无意识的观念并因之而加重之后，都成功地做到了这一点。向病人昭示这一切，并且帮助她们走向康复，这是一个持久的、激动人心而且能产生巨大效应的过程，同时也是创造健康生活的重要一环。它需要同情和耐心。

观念和记忆是身体中实实在在的生物结构。不妨把你的大脑想象为一座冰山。意识部分——一般认为可以控制的那部分——是浮出水面的一部分，但这一部分的体积只占整座冰山的 25%。所谓的无意识部分则占绝大部分——这 75% 的部分被淹没于水中。我们的个人历史被存贮在我们的身体、肌肉、器官及其他组织之中。这些信息与冰山的水下部分一样，一般是不会为冰山的水上部分，即以意识为特征的理智所认识的。细胞是我们存贮记忆的银行——尽管意识常常忽略它们、否定它们。

一次，我请一个服务生把行李搬到旅馆的房间里，这时他注意到了一瓶快要用完的中药止咳糖浆。他的脸“刷”地变白了，他抱着肚子说：“我想那该不会是一瓶蓖麻油吧，我记得小时候我妈妈经常给我这玩意儿，我只要一吃它肚子马上就疼。现在我只看了一眼，就已经感到肚子疼了！”这位男子的理智根本不能抵抗童年的痛苦在身体中留下的记忆。只要看到一个貌似熟悉的瓶子，他的身体就会有一种条件反射。

另外一次，我和一位妇女一起远足旅行，她告诉我，两周前，她不慎将防晒

油滴到了眼里，在防晒油的刺激下，她的眼睛流了整整一天泪。几天之后，她甚至只是在别人使用同一种防晒油时闻到了那种气味，她的眼睛马上又开始流泪了。她的生物记忆的符码已经存贮到了眼睛之中，她的理智对此完全束手无策。

生理机能

在一生的任何一段时间内，我们的健康状况都折射着我们有生以来所接受的所有观念。我们的整个社会的运作有赖于许多共同的观念，而这些观念有时恰恰是有害的。(我在办公室里经常听见的一个例子是：“完了，我现在已经 30 岁了(或 40 岁，50 岁了)，我也该生点病了。”所有生物的生理反应都依据于他们理解现象的方式，迪派克·查普拉博士是意识研究与药物研究方面的权威，他曾经做过一个试验。将苍蝇放到一个盖了盖子的容器中。过一段时间以后，将盖子移开，这时他发现除了少数几个勇敢的先驱者以外，大多数苍蝇并不试图出去。对于大多数苍蝇来说，它们的身体大脑已经达成了共识：它们被困在了容器之中。同样，在一个鱼缸中放入一块玻璃挡板，将两群鱼分开，过足够长一段时间后，即使将挡板拿走，两群鱼也不会游入对方的区域。

因此，我们可以断言，童年时代的事件为我们关于自身的观念、我们的经验以及我们的健康搭建了一个舞台。对妇女来说，要改变她的现实以及她的健康状况，首先要改变她对“什么是可行的”这一问题的看法。

我在工作中的无数经历已证明：我们拥有可以改变我们既有的、破坏性的、无意识的思维模式的能力。这种能力在一个有关年龄增长观念之影响力的实验中亦得到了验证。爱伦·兰格博士在一个精神病患者收养中心对一组 70 多岁的女性志愿者做了一个为期五天的实验。实验要求她们设想自己生活在 1959 年的现实中，兰格博士告诉她们：“我不会时时提醒你们‘要做得像 1959 年那样’，而是要你们完全变成 1959 年的人。”她们穿着那个年代的衣服，看着 1959 年的电视节目，读着 1959 年的报纸，并且谈论着 1959 年的话题。她们还找出了当时的

照片，布置在该中心的墙壁上。兰格博士考察了通常认为会随年龄增长而下降的许多参数(但并不必然如此)，比如体力、感觉能力、认识能力、味觉以及听力。这些指数都是老年医学专家们经常引证的生理指标。在五天的实验期内，有许多指数有了明显的提高。连续拍摄的照片表明了人们好像年轻了五岁，她们的听力和记忆力也有了提高。正因为他们在精神气质上改变了自己的年龄，所以她们在生理上也同样改变了自己的年龄！兰格写道：“我们在近来人类生活中司空见惯的所谓有规律的‘不可违拗的’年龄周期，其实不过是这样一种假设的产物：人会不断地变老。如果我们没有被强迫去接受这样一种压抑性的精神气质，我们将会极大的机会去重新安排我们的老年生活，使之充满活力并指向一个特定的目标。”

如果我们真的有能力改变年龄增长带给我们的影响，那么将给我们的健康带来什么样的影响呢？绝对不要轻视上述资料所展示的幸福内涵。它向我们昭示：如果我们能够从我们的文化囚牢中解脱出来，生活将为我们提供许许多多在过去被认为是绝不可能的机会。但是，在到达彼岸之前，我们首先必须认识到我们正试图进入的这些纵横交错的区域，一旦看到了这些区域，我们就可以开辟出新的航线。

治疗

自由与命运互相为对方提供意义；而一旦获得了意义，命运之眼睛将陡然变得炯炯有神，洞穿一切——此时的它是如此优雅而仁慈。

无兄弟，不把妹，更多一手情感课程请添加微信：kc58567 微信：sm99878
——马丁·布伯

调理不同于治疗。调理是一个自然的过程，每个人都具有自我调理的能力。治疗则往往要借助于医生来完成，它通常是指一种外在的处理。药品和手术是缓解和消除病症的最常用的手段。这种外部处理并不能保证在准确的部位去除引发

病症的真正因素。调理要比治疗深入得多，它大都发生在身体内部。它能够使致病的机体失调重新趋于平衡。调理的关键在于它将个人生活中许多隐匿的内容与其疾病联系了起来。尽管治疗行为以及生理机能的康复有助于调理，但二者绝不等同。一个人可以被调理得非常好，却不能免于疾病致死。这一点至关重要，但是却往往被依据于整体医学而进行治疗所忽略：调理和死亡并不互相排斥。作为一个医生，我常常被教导要延长并保护生命。但是某些时候我们必须放弃上述教导。并把死亡看作一个自然过程中的一部分，这个过程远比我们认识到的要宏阔而神秘。帕特里克·雷斯是负责研究病人的梦及其身体症状的。她说：“调理的深层含义是‘整体观’，换言之，将生命中所有缺失的部分填满。有时候这也许意味着以一种更全面的方式去直面死亡。毋庸讳言，调理使我们有可能更深刻更全面地理解生命。”

尽管我们所有人的身体都受我们的思考、情感以及彼此之间的交流所影响，但每个人的身体语言都是独一无二的。不管生活中发生了什么事情，女人都必须有能力在情感和生理两方面去改造这种体验带给她的所有影响，并且改造这种体验本身。这有赖于调理。除了病人可以完全地知道一种病症所隐含的信息外，没有哪种简单的公式可以破译这种信息。有时候，女性的身体会用慢性阴道炎请求她中止某种亲密关系；有时候，经期前的头痛可能是必须戒除咖啡因的警告。而对别的女性来说，这些症状则意味着完全不同的含义。每个女性都必须要用纯粹感受性的，非判断性的方式去“接受”这些症状，只有这样，她才可以去理解她自己的身体所特有的语言。

比如，直到现在，我们还不能完全理解何以有的妇女在被丈夫抛弃之后，其情绪、精神、生理会受到那么大的伤害。有的女性会因为诅咒这一特定的创伤而认为人生就是不幸，而另外一些女性在遭遇同样的不幸后，却能很快地摆脱阴影并开始富有创造性的生活。有人认为，童年的痛苦经验以及创伤性的情境是一种刺激物，一个人最主要的个人气质却由此而生。童年时遭受的性虐待、乱伦、失去父母以及其他创伤不可避免地会潜移默化地转变为成年时的心理阴影。这些创伤在我们的肉体、心理身体以及情绪身体上造成的影响主要取决于我们对这些创

伤的阐释。

一般说来，就像饮食、遗传、婚外情以及运气欠佳一样，情绪因素也都会对妇科疾病产生影响。我发现，大多数患有阴道赘疣、疮疹或卵巢包囊症的女性都经历过或仍在经历情绪和心理上的挫折或坎坷。在这些病症的治疗过程中，诸如遭受性虐待的经历、堕胎带来的心理阴影、婚恋生活中的矛盾冲突之类的因素经常会凸显出来。这些矛盾冲突在被平息之前一直存在于我们的身体能量场中。这些矛盾冲突乃是身体正在等待我们引起注意以便得到调理的机会。

对此，莫德·居里博士——我的一个妇产科同事，通过一个患有严重的子宫内膜异位和骨盆疼痛的名叫琼的女性非常形象地做了说明。居里博士用了一种非常规范的手段对琼进行了“治疗”：切除了全部子宫及两个卵巢和两根输卵管。然而手术后，琼又开始背疼。她的情绪非常消沉，而且出现了抑制不住的潮热，以至于很多时候不得不求助于激素药物。尽管她的骨盆疼痛被“治好”了，但在许多方面她甚至觉得比过去更糟糕了。正因为她用治疗取代了调理，所以她只不过是把一组病症替换成了另一组不同的病症罢了。尽管手术切除了她的子宫和卵巢，但并没有平息存在于体内能量场的情感冲突，而后者才是其致病的真正原因。

居里博士发现，琼在六岁时曾被人强暴，16岁时妈妈又不幸去世，她不得不独自生活。即使是遭遇了这么多的创伤，她却从来没有机会宣泄一下自己的情绪。居里博士写道：“这个病人给我上了非常好的一课。尽管我从来没有否定过思想观念和情感对生理健康的影响，但我始终认为这种影响只是相对的。这些病人的情况使我懂得，在治疗任何一个病人时，都必须要把身心方面的问题联系在一起考虑，不管在该项治疗中有多么严格的程序规范。

“我曾经确信我已经治好了这位妇女，并且为这六个星期的工作深感自豪。然而一年之后，我们两人都发现，尽管她的确已经被手术‘治好’了，但她并没有得到调理。

“回想起她第一次来就诊时的情形——我还记忆犹新。以后的一系列进程中有很多很多非常明显的迹象，然而我都没有能够看到。第一次来就诊时，即使已经坐到了检查台上，她还不肯脱下她的连裤袜。不仅是脱下衣服接受检查这件事费了很大周折，甚至于不肯将自己的身体置放于检查台上。好不容易使她躺在了检查台上，我又发现很难将窥器放到她的阴道中，因为她太紧张了，以至于肌肉一直都在颤抖。从那以后，我的病人——包括任何一位病人——都使我愈来愈看到一幅更宏阔的画面。我承认，即使认识不到身心之间的联系，你也可以‘治好’许多病人，但我更知道，你只能‘调理好’很少的几个。”

我的一个病人曾经做过腹部巴氏涂片试验。她已经获知，仅仅切除宫颈上的畸变细胞（即“治好”）并不能使失调的生理机能重新获得平衡，而这才是致病的真正原因。于是她开始在每天早上记日记，以获取有助于调理疾病的一切信息。她完全依照这些症状的引导立身行事。这种内在的调理坚持了几周以后，她改变了一个在她看来至关重要的观念。这个观念就是，她向来认为宫颈细胞畸变是对性行为的惩罚。在发现并命名了这一观念以后，她开始有计划地进行常规的药物治疗，以使“调理”和“治疗”相得益彰。在去做激光治疗的路上，她感到自己从有关自身以及性行为的观念中超脱了出来，这使她感受到一段情感的波浪，她甚至感动得流下了眼泪。当她到诊所接受检查时，发现所有的病变迹象已经全部消除了，她也不需要再做手术了。她非常感谢她所接受的生理治疗，当然还有心理和情感方面的调理。

在我们的社会中，当一个心理学家承认女性有内在的调理能力时，他们似乎同时隐含着这样一层意思：女性自己引发了疾病。但事实上我们的疾病并不基于某个单一的原因或某种单一的影响。认为女性有意识地、理智地创造了疾病以及其他痛苦的生活情境，这种看法太过片面而具有极大的危害。只有当疾病发作时，我们才予以关注，而致病的原因我们却往往不得而知。认为我们应该为我们疾病而受到谴责，这无异于是在为我们童年时所受的伤害开脱罪责，而且这和调理的目的完全背道而驰。负罪感会使我们心存困惑并阻碍我们的调理。我们所说的“生病”并非指已经感受到疾病的痛苦，而是指潜在我们无意识之中的“疾病”。但

是一旦我们采用了调理疗法，我们的意识也可以对其产生影响。

然而，许多医生却把对疾病负责等同于对其进行责难。在依赖体制之中，我们总是把对某物负责等同于对其进行责难。相反，另外一些医生则认为，既然疾病并不是由病人引发的，那么他们的治疗也不能仅仅依靠自己。有一个私人医生或保健护士对你来说非常重要，他们的意见有助于你的调理。最近的研究材料表明医生对病人调理潜力的期盼会潜移默化地为病人所吸纳并对他们的康复产生影响。

当我们不再为我们的身体有负罪感，转而开始认可我们的身体并尊重它所传递出来的信息时，我们可以说已经从最深层开始了调理的过程。在一个不承认心灵和身体有密切联系的文化中，相信身体的智慧可以说是信念上的一次飞跃。所谓“身体的智慧”，我指的是我们必须要学会相信身体的症状乃是精神借以引起我们注意的唯一渠道。用外部的“治疗”来遮蔽身体症状会阻碍我们去调理身体中需要引起关注并加以改变的部分。

当我建议病人参与到自己的健康治疗中时，常常会碰到我所谓的“责难之墙”。比如，有一次，当我向一位妇女解释说，她的子宫肌瘤（一种良性纤维瘤）可能与她的性爱方式有关。她非常生气，以为我是在责备她。“你的意思是说是我引发了疾病？”她说。我告诉她，她必须要超越这种责备性的思维，必须要超越原因——结果的线性思维。要调理她的子宫肌瘤，首先需要她采用一种新的思维方式，即子宫肌瘤并非一个有待“医治”的敌人，而是她的内在引导系统的一个方面，为了使她的生命更加健康，它正试图引起她的注意。回应并受益于一种疾病乃是我们反抗依赖体制的一种有效途径。

要调理疾病，首先要明白我们用不着为自己的疾病负有太多的责任，正如疾病不需要我们负太多的责任一样。我所认识的许多非常健壮的人都不把自己的疾病甚至自己的生命看得很重，他们很少自责，很少认为是自己引发了疾病，他们也很少指责环境或其他事物。他们把自己的生命理解为时间长河中的一天，在特

定的时间以特定的方式铺展开来。一个年轻的女性非常生动地阐明了上述态度，她写道：“首先，我既不会因为患了病也不会因为深受其苦而自责，我只考虑如何回应体内的这点点滴滴混乱无序传到我生命中的信息。”

玛莎是我家的一位至交，她的故事为疾病和身体症状提供了非常好的例证。尽管她的故事在许多方面都显得有些离奇，但的确向我们证明了：只要我们对调理持一种应有的开放心态，我们的经验范围就将被极大地拓宽。

将近 60 岁的时候，玛莎不由自主地对一系列童年往事恢复了记忆。她尽可能地去重新体验童年时的苦痛。在差不多一周的空闲时间里，有那么几天，玛莎会有连续几小时不停地呜咽抽泣，以此来表达并减轻她的痛苦感受。这使得她清楚地记起了小时候被诡秘的父亲带到肮脏的酒吧里的种种细节。在那里，她经常看到父亲和陌生的女子接吻。她还回想起她母亲设法从监狱里保释她父亲，她被留在家里与一位阿姨共同度过的那几天。这位只有一只眼睛的阿姨，把她和妹妹关在一间蟑螂横行、只有天花板上悬挂着一只昏黄灯泡的屋子里，整天只能吃饼干。当玛莎回忆起诸如此类早在 55 年前就被掩埋在记忆深处的童年往事时，她终于可以长时间地大喊大叫并且放声恸哭了，就好像有一位值得信赖的朋友在陪伴着她一样。这种宣泄断断续续持续了好几天。最后，她说：“我认识到，我的童年生活没有任何欢乐可言，更糟的是我居然记住了这些事情。”

玛莎常年患有颈椎和肩周疼痛，据说这是由于“脊椎衰老引起的”。然而当她对童年生活有了一个明确的认识，并且宣泄出了郁结的情绪后，这些病全都好了，而且再也没有犯过。

有一年的春天，玛莎打电话给我，说她突然体验到了一种前所未有的死亡之恐惧。由于有了对自己的症状持信任态度的经验，她没有回避这种恐惧，也没有试图用药物去“治疗”这种恐惧，她决定停留在这种体验之中，看一看这种体验究竟要对她做何教导。

玛莎对死亡并不陌生，她曾经有两个至亲死亡，一个是她的孩子，一个是她的丈夫——两次死亡事件发生在同一年之中。至于自己对死亡的恐惧，她告诉我——则总是出现在晚上上床睡觉前和早上，而且伴有左腹上方的隐隐疼痛。一开始，她误认为这种疼痛是和为治疗牙齿感染而服用的盘尼西林有关。这种恐惧太可怕了，以至于有好长时间，她甚至不敢谈起这件事。

她的恐惧越来越深，而腹部疼痛也与日俱增。直觉告诉她，她应该从新英格兰驱车横跨整个国家，到新墨西哥的道斯城去，她的一个女儿住在那里。她希望独处，而驱车跨越这么长的距离是一个不错的选择。我从来没有听到过她如此忧心忡忡，但我并不担心。我相信正在发生着某件事情，并希望不久以后她会在合适的时候告诉我。几天以后她打来了电话，仍然是心惊胆战：“一切都发生在大草原上，”她说，“我已经开了 200 多里，现在我的情感和身体都承载着巨大的痛苦。我正驱车经过一个又一个牧场，到处都是牲畜，它们正踏着自己的粪便吃草。这使我联想到，其实我们也都生活在自己的粪便中，只不过我们会用散发着香味的卫生纸掩盖污秽罢了。我为世界的现状，为一切环境问题而感到悲哀。我想到了我们经常会有的一切恐惧。我发现自己像一个女英雄一样，在草原上跋涉。我‘看到’成千上万的妇女——包括各种种族、各种年龄的妇女正在草原中艰难地跋涉，她们用自己的劳动支撑起了世界。我为这些妇女、为她们无休无止的劳动感到恐惧、感到痛苦。”（由于正处于想象之中，她的肚子越来越疼，她不得不用腿顶住胸部。她感觉到有血涌到了嘴中，但当她吐到容器里后，却发现痰里并没有血丝）。

“接着幻觉出现了。我变成了一个海盗、一个女海盗，我有一柄硕大无比的长剑。我杀死一个即将分娩的妇女。我用这柄长剑将母亲和婴儿全都杀死了。一想到这里我就惊恐不安。我只能不停地飞奔，带着眼泪和创痛。想到我居然也可以干出这样的事情，我禁不住对男人产生了深深的同情，因为他们不过是要被训练成如此而已！肚子越来越痛，眼泪不停地流着，心情非常痛苦——这种情况延续了大约四个小时。穿越落基山脉的山口时，太阳出来了。我想一切都该过去了。但是恐惧仍未散去，就像一些虽然终究虚假却又非常逼真的梦魇一般。

“我必须在一个不是‘家’的环境中单独完成这些活动。我离开的那天是星期五，整个晚上，疼痛都出现在左边，而且有消退的迹象。但是到了星期六，当我继续前行时，我的左腹又感觉到了这种恐怖的痛感。这正是我（海盗）的长剑插入之所。

“到了道斯以后，我见到了玛丽，一个有着天才的直觉能力的女人。她阅读了一些材料，认为我没有必要走得更远了。女英雄的幻觉以及化为海盗杀死孕妇的幻觉已经帮助我减轻了对死亡的恐惧。

“我知道我需要对这件事情做一个总结。我需要对这件事情有一个完整的认识并结束它。也许那位妇女应该被杀死。这是我所做过的最坏的事情，我试图向上帝和我自己隐瞒它。我认识到的第二件事情是，每个人都干过同样的事情。我们全都杀过或谋杀过别人。我感到自己正在另外一段时间中死去。现在我正给自己以新生。我永远不可能再回到从前了，因为过去发生的事情太多了，我不再是从前的我了。

“我很少有精力充沛的时候。我经常感觉到筋疲力尽。这使我获得了对死亡的认识。环境、地球，以及我们为之工作的一切，都深存在我的体内。我想我现在已经将走出死亡阴影的绳索，成功地抛给了我的女儿，我可以继续前进了。”

玛莎认识到，完全理性地解释所发生的这一切，对于她的调理来说并非必不可少。她用不着为了调理自己，而去解释“海盗”幻觉，“海盗”体验究竟源自过去的哪一段经历或哪一件事物。最重要的是，她感受到了所有这一切体验都来自于她身体的深处。承认了凶杀行为后，她从精神重负中解脱了出来，获得了新生。她同时认识到，她必须改变自己的生活方式。她必须停止与朋友们一起浪费时间，这些朋友对她的生命毫无裨益。她们的友谊只不过是习惯使然，并不能促进相互之间的丰富和提高。

玛莎一个星期之后回来时，仍然心有余悸，有时还会做同样的梦，她希望自

己能够彻底解脱出来。她把所发生的一切事情都写了下来，然后在一个星光灿烂的夜晚来到后院，掘了一个洞，然后在洞中把上述记录烧成了灰烬。当她掩埋完这些灰烬站起来时，一切都结束了。在经历了几周的恐怖之后，她完全地解脱了。

大约三星期以后，她去俄亥俄州拜访她的叔叔和婶婶。她的叔叔罗伊告诉她，他感到自己去日无多，因此想要送给她一件东西。他将她带到后面的一个房间，然后爬到架子上，俯身递给她一个铜像。这座铜像正是腰悬长剑的海盗。

我们都惊异于这种偶然性。（“偶然性是上帝用以证明其神秘性的方法，”伯尔尼·西格尔博士说。）玛莎说：“我现在可以将这个雕像放到我的房间里了，它是我整个调理过程的一个象征。我知道，假如我不去体验这些记忆、梦魇或别的一些事情的话，我的肚痛将会恶化成一种致命的疾病。这是一定的。”

玛莎的故事深刻地告诉我们，按照传统观念去责难我们的疾病根本于事无补，而且非常褊狭。从某种神秘的意义上说，我们的理智并非发号施令者。我们的另外一个部分——我们更高的力量、灵魂，或者说内在的智慧，才是真正的发号施令者。“自我”的概念必须要扩展。研究结果已经证明了隔着相当距离的祈祷者对被调理者所产生的即时效力。时间和空间都不是绝对的。我们的行动完全为一种意识之外的力量所支配。我们可以敞开心扉，去学习我们的全部生活，我们的内在自我以及所有与我们相关的事物所教导给我们的东西。

除非我们能把身体的潜能发挥到极致，否则我们还不能说我们真正拥有了我们的身体。斯蒂芬·温德曾经说过，眼睛的失明使他比常人更加真切地体验到了围拥着他的爱。倘若他像常人一样有一个“健全”的身体，或许反倒不能做出创造性的工作。伊丽莎白·昆伯勒·罗斯指出，如果我们的身体患了疾病或功能失调，那么我们的精神和心理活动常常会超越正常的极致。她举例说，患白血病的孩子普遍比同年龄的孩子聪明。我由衷地相信这一点。决不要指望哪个逻辑的、理智的自我能够肩此重任，我们必须挣脱哲学传统的羁绊，到天空和大地中去实现我们的梦想。

以开放的心态去接受你的身体及其症状传递给你的信息和神谕，在妄下断语之前，请仔细聆听。你的所获必将使你的生命获得拯救。

一手情感资源请加微信：kc58567 微信：tushu959

第三章 女性内省

玛丽·卢被确诊为乳腺癌之后马上打电话给我，讨论如何选择治疗方案。我告诉她，她的康复过程包括在听取各方专家的意见之后由自己决定治疗方法。她后来写信给我：“当你确切告诉我在恢复过程中我必须学会自己对付癌症时，我记得自己当时非常害怕。我当时想这些都是生死抉择，与决定如何度周末是无论如何都不同的。然后，一个想法突然闪现，那就是我的灵魂这些年来一直处在危机之中。安最早提醒我与她一起参加有关我的健康会诊还是在 1981 年。那是在我被确诊为结肠溃疡之后，我担心会害了自己。我真的相信意志——身体——精神是相连的，为自己的癌症疗法进行选择，我感觉到这一次我真的有机会信任自己的内在引导系统。在这样深的层次上相信自己确实让我害怕，不过，几个月之后的现在，我非常感激，这‘玩意儿’还真有用，我的大部分调理过程都是靠了它。每次我依靠自己来进行恢复治疗的时候，它都鼓励我继续相信自己。”

心灵之声引导我们更真实、更充实地生活。玛丽学会了选择自己喜欢的医生来合作，选择最佳医疗方案，即使面对的是乳腺癌的考验。不仅如此，她认识到同时她仍然能够享受生活。之所以如此，是因为她无时无刻不是跟着自己的感觉走。每行一步，她都选择自己最为满意的决定。如果你的选择能令你的生活充实和实在，那么恢复健康便指日可待，不管你的身体状况如何。

内部引导系统的运作是通过我们的思想、情感、梦境和身体感觉来进行的。我们的身体是能量和信息的接受、传送站。生活同内部引导系统紧密相连意味着通过自我的各个方面来体验生活：意志、身体、情感和精神。我在书中提到的这个过程，意思都是倾听并运用内部引导系统在生活、行为、人际关系以及健康方面来进行有意识的改变。

倾听你的身体与它的需求

我们对人或物的“内在感觉”可以认为是准确的信息。这是因为太阳神经丛(一个能感觉到内心反应的身体部位)其实是一个原始大脑，也是一个直觉中心。身体这一部位可以告诉我们自己是否安全，听到的话是不是谎话。

每个人必须找到倾听身体需要的途径。我们可以从简单的事情开始。累了就休息。想上洗手间便去。如果书中的一段让你伤心，你尽可以哭。读不懂的地方由它去——它的内容可能让你难受。注意你的反应。阅读的时候注意你的呼吸：阅读材料时你的呼吸急促还是平缓？你的心在干什么？是心跳加速或心跳减慢？阅读有关子宫或月经的内容会勾起旧时记忆或身体感受吗？

我经常要求妇女注意每一刻的身体感受。为了调理好身体，我们必须重新进入身体，体验它。

我们必须赞扬我们的身体智慧。我们无需确切知晓体内发生了什么而引起我们的反应。你无需了解你为什么心跳加快或你为什么想哭。当你允许自己经历了这种感觉之后你就会明白。恢复过程是发生在生理和心理层面的有机过程。如果你感觉“不舒服”或“不平衡”，不要回避它，让它发展。体验这种感觉后，用一段时间来回想过去几个小时或几天发生的事情。如果你感觉不舒服或出现症状，回忆最近发生的事情，也许你会发现症状发生的直接原因。

以下是我的亲身体会。写这部书的过程中，有一天我醒来的时候眼前出现了幻觉，手和脸感觉麻木，这是周期性偏头痛的先兆。我在 12 岁的时候就有了此病，大约每月犯一两次，直到大学二年级，后来的 20 年里再没犯过。成人之后，我是典型的周期性偏头痛人，在学校和参加各项活动时对自己要求过严。压力经常使我们身体的电磁系统“短路”。

因此当重新有了这种令人熟悉的、令人恶心的感觉后，我立刻把它作为一个学习良机。我把冰袋放在脖子下面，躺下来，保持室内安静，努力使双手保持温暖。(我从一位生理反馈治疗专家处得知，完全放松并使双手温暖，周期性头痛

就可以消失。)这样做之后我免受了头痛之苦，它若是真的发作起来，一天的大部分时间我都会恶心乏力。一小时之后我又活动自如，但心情沮丧。我开始回想前三天发生的一切。

我试图在两天之内将几年不收拾的房间整理好。到周末的时候，我的脾气变坏，几乎没有时间吃饭或上洗手间，弯腰擦洗几个小时也不休息。上床睡觉时头痛难耐。次日早上起床时出现周期性偏头痛的症状。显然，我对休息、娱乐、补充消耗等身体需要置之不理的习惯依然没有改变。这一次我的身体不再对我听之任之。周期性偏头痛发生了。我把它当做一次警告。

这次经历总结成治疗原则是：如果信号第一次出现的时候你不去注意它，再次出现时它就会给你沉重的一击。

无论什么情感都能帮助我们体会并完全参与到我们自己的生活中来。若想了解内在引导系统，我们必须学会相信情感。这不简单，因为我们中的多数人已经习惯了被生活压得喘不过气来。我们总是想：“哦，痛苦的情感以后再去品尝，现在我必须完成那篇报告，或是做饭，或者别的事情。”这样拖延或不理睬使得我们身体反应越来越强烈，以此来引起我们的重视。下一次如果被感动得哭泣或大笑，记住停下手中的活儿，去感受那真实的情感。人们教导妇女去“认为”——而不是体验——我们必须永远乐观向上。其实悲伤或痛苦是生活的自然组成部分，它们是更伟大的导师。没有谁的生活离得开悲伤或痛苦。可是我们的文化却教导我们，痛苦是错误的，它必须被用药根除，被视而不见，或以一切代价来避免。然而，其代价是非常高昂的。

没有人告诉我们，处理痛苦的能力天生就有，我们的身体知道该怎样做。哭泣是身体排毒的一种方法。哭泣让我们在体内转移能量。有时候是重新分配能量，或是让我们以新的眼光来认识身体。当我们不让自己体验情感，而是通过跑步或镇静剂等自我麻醉的方式来“精神焕发”，我们实际上是在产生抑制眼泪的激素。眼泪里含有身体需要排出的毒素。高兴的泪水或伤心的泪水化学成分不同并且受

激素分泌的影响，它们的功能也不同。当我们充分释放情感的时候，我们的身体、思想和精神便得到了净化，得到了解放。在特定情况下采取何种措施，这种洞察力是只有在体验了对这种情况的感情反应，并且在需要的时候流泪之后才具有的。有意思的是，虽然幸福与痛苦之间有很深的联系，幸福之泪与痛苦之泪在物理和化学成分上截然不同。如果我们不能体验深刻的痛苦，我们也就无法享受无上的欢乐。虽然欢乐与痛苦表达了不同的情感，二者均为身体加工和“消化”感情的自然部分。

许多疾病都是由于情感被长年压抑而从未被体会和被承认。我的一位病人长期患有周期性偏头痛，她最近告诉我：“当神经科医生要用锂来为我治疗时，我觉得自己的头痛病可以说是无可救药了。我知道我无法承受那种药的副作用。于是我开始生理反馈疗法，学习放松自己。我的童年生活不堪回首，我只有接受痛苦。现在我意识到我不再头痛。我注意到只要我不注意照顾自己，头痛就会开始。如果我休息不好或睡眠不足，或是在家中不愉快，头痛就会发作。我知道头痛总是在向我表示些什么。”

走出过去的阴影

只有当我们让自己体会、表达并释放我们过去被压抑或试图忘却的情感时，恢复才会开始。我把它叫做情感剖腹术或排放术。我经常将这种深层次的过程比作治疗脓肿。任何一位外科医生都知道治疗脓肿就是把它切开，让脓排尽。手术之后，疼痛很快消失，新的健康的组织会在脓肿处长出。感情也是这样：如果我们不去体会和释放，感情也会越来越顽固，造成疼痛，耗尽你的能量。

孩子们释放感情迅速而自然，这种能力与生俱来。但是由于我们的文化对情感控制十分崇拜，我们很早就学会压抑情感的释放。当一位妇女因为恐慌症或不由自主的大哭来找我时，我知道她有一些情感的材料有待处理。对于那些没有经历过情感体验的旁观者来说，她也许是“不知所措”，“失去控制”。不过，她不

是“失去控制”，她只是听任体内自主进行的治疗过程。失去控制的只是理智——它让位于与生俱来的身体智慧。

通常在这种情况下医务工作者都会开些药。结果是这位妇女天生的恢复过程长时间受阻。即使不开药，我们中的大多数人在面对他人释放情感时都会感到别扭，因为那正是他们压抑的情感。因此他们赶紧去安慰那个开始哭泣或“失去控制”的人。这就打断了那个人情感体验的过程，同时也“保护”了安慰者，使他们免于体验自己的情感。双方的情感治疗进程都因此中断。

但是，如果一位妇女被鼓励去体验情感，真正地体会它，发出想发的声音，尽情地大哭大叫，完全沉浸于内心，她会发现自己的身体天生就会治愈过去的创伤。当我们直面情感而不是一味逃避，我们经常会体验沉寂多年、消耗着我们精力的痛苦经历。斯蒂芬·列文把这种经历称为“结束痛苦的痛苦”。

当我们让自己心情释放情感的时候，身体、思想和精神都会得到净化，从而获得了自由。敏锐的观察力形成之后，尘封多年的自我理解也就会再次降临。我目睹人们在经历内心体验之后会原谅自己和别人，因为他们最终不再为过去的痛苦经历所烦恼。多年来用理智无法解除的痛苦通过内心体验可以奏效。

内心体验的一个最动人的例子来自一位名叫卡洛尔的治疗不育的医生。卡洛尔非常痛苦，因为尽管动用了众多的最新技术，她还是无法帮助自己的女患者怀孕。虽然治疗不孕还不是一门专门的学科，她还是将参加治疗的夫妇的不孕看做是自己个人的失败。这使得她的职业感情充满了痛苦。

在我主持的一项集体治疗活动中，讨论转向了母亲这个话题，许多参加者都尽情地宣泄自己的情感。卡洛尔倒在地毯上放声大哭大叫，她不断重复：“我没有必要创造许多妈妈；我没必要创造许多妈妈。”喊完之后，她意识到她从未在情感上有过母亲。小时候她经常挨母亲的打。她之所以选择治疗不育为职业，部分原因是积郁在胸的童年苦痛：潜意识里，她试图通过“创造妈妈”来创造自己

情感上的母亲。认识到这一点后，她又精神抖擞地回到工作岗位上，不再为病人的不孕而自责了。

了解潜意识的途径

梦是内在引导机制的另一部分。科学证据显示，我们做梦时的大脑活动量同醒着的时候一样多。做梦的过程中，内在引导机制同大脑一起勾勒一幅图画，为健康平衡的将来规划我们的行为或目标。梦境也指引着我们努力的方向，指出哪些是有益的，哪些是无益的，以及哪里需要做出调整，怎样做出调整。

我的一位病人正在从慢性骨盆疼痛中恢复过来，她告诉我，由于得到了调理，她在梦中越来越有力量。她说每晚睡觉是为了看看自己还会什么，这真是很有趣。

另一位病人从乱伦中解脱了出来，她说：“我最近梦到一个四岁小女孩告诉我，有人伤害了她。我知道那是我——我需要在梦中听她的倾诉。”

还有一位一直受慢性阴道炎困扰的妇女转向梦中寻求启示，因为我们的物理疗法对她没有用。一星期后她回来说：“我做了个梦。什么都是黑色的，我听到一个声音说，‘蹬了拉里，你就什么问题都没有了’”。她最后在个人关系上采取了行动，情况开始变好。

注意梦境意味着每天早上起来的第一件事就是把它记录下来。睡觉之前再记住它。床边要准备好笔记本。

直觉和直觉的引导

直觉是对真理或事实的直接感悟，不依赖任何推理过程。直觉的最好例子就是你走进一间漆黑的屋子，不知为何你知道里面有人，虽然你什么都看不见，也没人事先告知。这种能力与生俱来，小时候我们的这种能力都非常强。可是大多数人受教育之后便丧失了这种直觉的能力，可以这样认为，在我们的社会文化之中，我们所受的教育越多，就越发不相信天生的直觉。我们的社会推崇的仅仅是逻辑的、理智的左脑思维，其他的认识方式均被视为原始和无知。

所以，我们的直觉能力受到怀疑，并且未被充分利用。但是任何时候我们都可以重新学习这种技能。因为它是非常自然的认知方式。虽然各种诱惑让我们脱离了自己的真实感觉，虽然我们当中的大多数人在大部分时间里疏远直觉，但是当我们开始注重内心体验，接受内在引导系统的指导时，我们就能自动地进入直觉。我们的社会承认即使是我们中的天才也只是运用了脑力的 25%，动用直觉则是比习惯上更多地运用我们的智力。

直觉引导是阅读我们自己(或别人的)能量场的能力。直觉引导历经了许多世纪，是许多古代治疗系统的一部分。每位传统的东亚巫医都采取这种方式进行治疗，魏加传统中的医士也是这样。直觉指引能够帮助我们在能量滞阻成为症状之前发现它们。我们可以以此为行动指南，并保持身体健康。

内在引导系统的工作方式

我的一位医学院的同学注意到，每当她违背自己意愿行事的时候就会背痛。现在她正在考虑写一篇研究论文。每当她想到此事以及牵涉到的同事，她就会脖子痛，胃里恶心。她所受的训练告诉她为了事业她必须发表这篇论文。但是她的内在引导系统正在通过身体感觉向她表明别的事情。她知道为了身体健康她必须在内在引导机制和社会要求之间进行选择。

做我们想做的事情，我们的身体就会运转得最好。如果我们知道上帝对我们

的要求，我们所做的是深入了解我们的天赋与才能——上帝的意愿就在那儿。从事自己喜爱的工作，这样的妇女身体就健康。如果一位妇女想要了解自己的天赋与才能，她可以回想一下 9 至 11 岁时的情形，也就是我们的文明为她彻底洗脑之前。那时她最爱干什么？想干什么？认为自己是誰？

另外一个了解个人禀赋与才能的方式是问问自己，如果生命只剩下半年，我们会做些什么。我们会继续目前的工作吗？会继续同现在的搭档共事吗？

我们总是向往满足、个人发展和自由。我们生来就知道哪些行为、事物、想法和感受同这些品质相连。我们必须学会相信自己，自然而然地踏上健康与满足之路。

许多人都受到这样的教导，那就是他们的需要不会得到满足，充满矛盾的生活比充满快乐的生活更高尚。我们还受到这样的教育，让我们有太多满足感或太多欢乐的东西是不可信的。这种信条在我们的身体上会有反映。一位杰出的催眠研究者注意到，这些信条引起消极作用比引起积极作用要容易两倍。不过当我们能够清晰地说出我们需要什么和为什么时，我们马上就能同心灵沟通。这是因为考虑我们的需要及其原因会让我们的身体舒服。这些想法和感受让我们兴奋并自动地激发我们，这反过来又让我们了解内心感受和精神能量，其结果是热情和欢乐。

我们的文化总是告诫我们，拥有自己的需求、梦想和欢乐是自私的。许多女孩，当她们体验到内在的力量时，别人就会告诉她，“你以为你是谁，是希巴女王？”当我们做了一件引以为傲的事情，或做了自己喜欢的事情，别人就会说：“别乐极生悲。”生活中的这种声音总是让我们裹足不前。当我们把自己的生活和兴趣放在首位的时候，我们总被斥责为自私。我们的成长过程就是不惜一切代价避免落下自私的名声。

总而言之，在我们的社会中，妇女要追求自己想追求的东西是很困难的。在

这种氛围中，人们认为女人的日常任务就是生儿育女、做饭做菜等等。即使养育孩子和家务确实是女人最想做的，她会发现这些工作得不到应有的尊重，而且报酬极低。不要指望她的外部环境会有所变化，她必须学会尊重自己的才赋和生命，正如她被教导去尊重和哺育别人的生命一样。正如我的一位朋友所说，“如果你想成为一名幸运儿，你必须选择自己！”

我认识的几乎每一位妇女都在社会的调教下认为将别人置于自己之前是正确的事。但是我们可以反其道而行之，给自己以关爱。当娜·约翰逊是我的一位搞研究的朋友，同时也是一位职业护士。她通过学习尊重身体的每一方面，竟从格里格氏病中解脱出来。患上该病几年之后，她无法控制呼吸、肌肉以及全身其他部分。呼吸困难让她感觉自己快要死了。这个时候她想在生命最后时刻给自己以无条件的关爱。那时候她形容自己是“坐在轮?上的一堆朽物”。她每天在镜子面前花上 15 分钟，选择自己身体不同部分进行关爱。她从双手开始，因为那时候手是她身体中唯一可以无条件欣赏的部分。一天又一天，她欣赏着自己身体的不同部分。她的整个身体也在她的欣赏之中一天一天变好。她还把这个过程中她形成的有深度的看法写成文章并发表在杂志上。她从小认为，为了对别人有用，为别人接受，成为一个受尊重的人，她必须牺牲自己的要求。她终于明白，通过自我牺牲来服务他人是死路一条，这差点要了她的命。虽然不带任何其他目的的服务他人可以增强健康，但是太多的妇女烘制饼干、煮咖啡、打扫卫生仅仅因为这是她们的任务，如果不做她们会有负罪感。被迫去服务他人会产生疲劳和厌倦。

了解我们不愿做的事

除了知道我们想做的事情，我们也要有知道不愿为的事情的能力。知道哪些是我们所不愿做的事情，这种能力也是与生俱来的。每个婴儿都知道哪些让他们感觉舒服，哪些不是，一直到六岁。孩子会自动亲近他们感觉好的事物而远离那些让他们感觉不舒服的东西。从一个刚刚学会说“不”的两岁孩子身上，我们可以看到这种能力的最真诚的显示。

对那些于我们无益的东西说“不”是内在引导系统的最重要部分。对那些让你精疲力竭的事情说“不”，对那些让你充满活力的东西说“是”，从来都不会晚。

朋友来电话求助，停顿下来问问自己，“现在我真的想马上就给予帮助，还是愿意做点别的？”

有人让你帮忙的时候注意你的身体。是不是有些感觉紧张？有没有内部的反应？你的身体在说：“是的，这很有趣，”或者说：“不，这样做会让你疲惫”吗？

如果一天下来感觉疲劳、易怒，问问自己这一天有哪些想法、行动或人耗尽了你的精力。

感觉好的日子里，问问自己哪些想法、行为、或人使自己精力充沛。

坚持做日记，注意并记下让你充满活力，精神焕发的事情，留意它们会使你的生活生机勃勃。

我的一位病人是社会工作者。她最初来找我是因为她患有经期前综合征和轻微的焦虑症。了解经历之后，我发现由于全身心照顾他人的需要而忽视了自己，她的生命已经透支。我告诉她必须学着去注意哪些事情使自己精力充沛，哪些对自己会造成消耗。然后，我又告诉她，为了摆脱病症，她每天至少抽出一个小时休息或做自己想做的事情，以此来给自己“充电”。她听从了我的建议，一个月后所有的症状都没了。她告诉我，她明白了她是如何消耗自己的。她说：“当我躺下或坐着记日记，我真的能感觉能量又回到了体内，明白了这对保持身心健康的重要性真是一次顿悟。”

我们的身体定期向我们传达信息，告诉我们哪些对健康有利，哪些有害。当我们做对自己不利的事情时只要想到它，我们的身体马上就有感觉。我的一位朋友一想到看望父母就会得痢疾和胃痉挛。整个童年时代她都遭受到了身体和精神上的虐待，这种虐待还持续到成人时期。她的身体知道看望父母对她无益，表现出的症状提醒她远离父母。她答应不看父母后，胃部症状马上消失。

为了每天增进健康，我们需要在疾病远未到来之时留意我们身体的感觉。思维不清、头晕、心悸、疼痛、头痛，以及背部、胃部和骨盆疼痛是常见而微妙的部分症状，这些症状向我们表明是该放弃我们不愿做的事情的时候了。以下是我生活中的一例。

80年代我有两个孩子，工作时间又长，同时还感到自己的工作不为同事所尊重。我的脸上总是出现大块斑点，这在青春期和其他时候是没有过的。我试着服用维生素，改变饮食结构，用各种各样的皮肤护理霜。一切都无济于事——直到我离开了原来的工作岗位。半年之后问题消失，并再未犯过。

显然，在那些年里，我的脸是健康的晴雨表。身体通过皮肤状况告诉我工作环境于己不利。我的皮肤记录的是不为同事所接受的敏感与愤怒。所有这些情感都埋在表面之下，虽然那时我还无法知道这些。一旦我面对内心深处的需要，离开对自己不利的境地，皮肤自然就变好了。生活爽快了，皮肤也亮丽起来。

负面情感的存在是让我们明白我们所选的道路无法达到自己的要求。我们的身体以及它的症状——感情——是我们的同盟军，它们能指明哪些对我们最有利，哪些不是，只要我们意识到这一点，我们就是自由的。每当你生气、头疼或有其他症状时，考虑一下这些身体反应想要传递给你什么信息。当我在消极情绪里越陷越深时，我马上就会明白自己与内在引导机制失去了联系，而且太过关注不想做的事情。我已学会了在情绪不好的时候停下来作些思考。如果坏情绪开始我就能发现，以下这套程序会帮助我的能量积极流动：

1. 我承认这种情绪的存在但不作评价。避免沉湎于消极情绪之中将其延后，但是我当然要充分感受它。我“与情感同住”。

2. 我承认出现这样的感觉是有原因的。

3. 我花上二三秒左右的时间找到产生负面情感的原因。例如，昨天我非常生气是因为工作人员没有及时将一条重要信息通知我，致使我未能及时回电话。

4. 找到负面情感的原因之后，我问自己什么是最想做的。我想的通常与感觉不好时所为相反。询问自己想干什么将我的注意力转移到积极的想法上，把精力放到我想做的事情上。

5. 然后我确认愿为之事。将意愿说出来意义很大，因为它可以目标明确，并将我们的创造力投入其中。因此，在第三步的例子中，我会说：“我想要及时接收电话传呼，这样就可以及时、有效地作出反应。”这句话反映了积极的、以自己目标为方向的能量流动。因为这句话里只有积极的能量，它有助于将自己的意愿带入我的体验。当我思考或谈论自己的意愿，消极情感便自然消失。

6. 最后，我坚信我能通过内在引导机制、意志力，我有力量完成自己的意愿。

采取以上过程并不意味着否定自我情感或将它们推开。不仅如此，此过程还有助于我承认它们，充分感受它们，运用它们来了解自己的意愿。我经常坐下来将自己在特定情形下的意愿逐条记在本子上。这就将我的想法同内在引导机制联系在一起，而且感觉很好。灵感随之而来，告诉我将如何行动。请注意，我是直到完全了解自己的意愿之后才计划处理某种情况的具体方法。原因是，目标明确的想法能产生共鸣，而共鸣又引起灵感。我提醒自己每当我反感某件事的时候，应反其道而行之，我的行为根据是我不做自己不愿做的事。例如，以前，我的丈

夫常在医院长时间工作，不愿按时回家吃饭。我却向窗外张望，焦急地等他回来，饭菜热了一遍又一遍，还不见人回来，我很生他的气，也替自己难过。我越是要他按时回家，我们之间就越有问题。有一次，我决定自己先吃，然后干自己的事情，自得其乐。以后每当他该在家而不在时我就这么做。最后，他开始自动按时回家，从那以后这不再成问题了。

不幸的是，我们被教导要害怕或否认消极的情感或认为那是不好的，而不是将它当做内在的引导。人们教育我们，能够控制自己和情感是值得称道的，是一种成就。肯尼迪被刺杀后，杰奎琳·肯尼迪头戴面纱，异常高贵地走在送葬队伍里，不流眼泪，没有表情。我的母亲认为杰奎琳激励着整个国家，是行为的楷模。虽然压力之下保持镇静和从容是值得钦佩的，但过度控制却不是好习惯，因为承认和释放情感是安全的，可帮助恢复健康。男人比女人更多地压抑情感，因为他们自小就受到“男孩不哭”的教育。我的一位朋友受到的教育是实在想哭的时候把头埋在枕头里，这样家里人就听不到了，流泪和大声地哭都是情感“消化系统”的一部分，也是保证能量在体内畅通的方法。

安·威尔逊·莎芙指出，依赖机制有“非生活”倾向。这种倾向鼓励我们“给情感盖上盖子”。小时候我们便学会了情感是不好的或可耻的，我们也学会了不相信心灵内在的引导系统或自己的身体。当我们被教化得对自己所感知的东西不以为然的时候，我们其实是在接受系统的训练，它让我们不去实现自己的内心愿望，或不敢说“不”。甚至宗教也告诫我们要压抑内心的欢乐和创造力，感觉良好即是罪过。正如马休·福克斯指出的那样，“我们的文明对称作高兴与欢乐的能量处理得不好。”我们需要知道，建立在内在引导系统上的生命的本质是无尽的欢乐！

我所遇到的每一个三个月大的婴儿的欢笑声都折射出我们与生俱来的真正欢乐的本质。阿什力·蒙太古指出大部分的成人只不过是“分裂的孩童”。幸运的是，内在引导系统是启示我们走向充实。与内在引导系统携起手来，不再将身体反馈给我们的信息视为坏的东西，我们就迈向了一个充满发展与快乐的生活。

第四章 女性能量

了解能量在女性身体中的作用有助于破译每个个体的独特语言。疾病在身体中的部位——它发生的地方——有心理及情感的意义。特定的身体部位同特定的精神和意识形态相联系。我们的想法、感情和行为同时反应或形成于大脑、脊柱、各种器官、血液、淋巴组织，以及围绕或穿透这些区域的电磁场之中。了解产生于体内又作用于体内的能量形态有助于了解体内能够产生出哪些积极的或消极的能量。

物质、能量连续体

体内能量系统处在不断的变化之中，潜在的病随时存在。例如，前期癌细胞会定期出现在我们体内，只有当我们的内部控制系统失控时它们才会形成癌症。精神和意志的能量有规律地在物质形式中进出，在能量与物质、分子和电波之间的连续统一体中碰撞。精神和意志的能量非常容易地在我们体内转化为物质形式。

当我们在生命特定的区域内有无法解决的长期感情压力时，这种压力会造成我们的能量场出现失衡，最终表现为生理病症。以下为发生过程：当我们为某人或某事所困扰时，我们的生命能量会从体内流失。当我们有所困扰时，我们体内的能量(即气)会被卷入一个消极的过程中，会从细胞中分流，细胞的活力会因此被降低。当我们在愤怒或恐惧的主宰下无法前行时，能量便流失了。虽然大部分医生不以能量流失作为疾病的开始，但非常有意思的是许多医学研究报告都赞成这种看法。例如，在一篇论文中，癌细胞被显示从邻近的正常组织中“窃取”能量。

无论如何，考虑到能量场和能量流失会帮助我们理解疾病并开始恢复治疗。例如，当我们对伤害自己的人一直耿耿于怀时，我们精神的一部分就被那个人占

据而无法参与到恢复过程来。当一个人遭受严重虐待时，东方的巫医认为他的一部分精神会因躲避虐待而逃走，他们传统的治疗方法叫“招”魂，在此过程中逃走的灵魂被召唤回来。许多在孩童时期遭受过虐待的妇女说她们在遭受虐待的过程中“离开自己的身体”。一些人记得自体的一部分确实游离到天花板上“观看”。游离出去的精神无法参与恢复过程。

多数情况下我们意识不到能量的流失。但是如果它们不被制止，结果会造成身体不适。身体症状能让我们将注意力集中至该部位，这样恢复的过程才会开始。我的一位绝经的病人因失眠和忧郁来就诊，她告诉我，孩提时期她遭受过性虐待，她从未意识此事，直到她就诊一个星期之后。她 40 岁时经历了一次痛苦的离婚，最近又同相处七年的情人分手。她说：“现在我意识到我在用一生的时间试图忘记曾遭受过性虐待。现在我知道它发生过，也意识到为什么无法同别人正常相处。我总是将别人推开。我曾经不知道与人相处时如何完全投入，我不知道如何是好。我现在为早年的生活感到难过，为花费了这么长的时间来记起过去并宣释过去而难过。不过，我心中的一个死结被打开了，我得到了解放，我非常轻松。”当她记起过去并将它从能量场中释放的时候，她的睡眠问题和忧郁症便消失了。

怎样医治能量流失

知道我们在何处“流失”能量有益于保持健康。每晚睡前的时间是做这件事的最佳时间。开始医治能量流失时，你只需留意哪些人或事让你忧虑、担心或困扰。什么样的想法、情感、事情，或人在不断涌上你的心头？有没有什么情感或念头让你牵肠挂肚？看看你最讨厌谁？找到这些之后，必须将你的精神唤回。运用你的意志力将困扰于过去或现在的种种不利情形之中的身体部分召唤回来。大声呼唤很有用处。简单地说，“精神，回到这儿来——我需要你”。游离出去的部分不习惯于这种召唤，但最终它们会有所反应并重新回复。

能量系统中的阻滞在本质上通常都是感情。将能量系统想象成涓涓细流是有

好处的。只要能量流动是健康的，而且你對自己感觉不错，生病几率就小。环境中的毒素、饮食中的脂肪以及过多的糖或酒精不会导致疾病，除非已经有其他因素阻碍了身体能量系统。环境的或饮食上的危险因素可以比作身体的能量之流中携带的碎石。碎石在能量之河中流动。当溪中之水被砍倒的大树或其他物体阻塞时，碎石聚集在大树的枝杈旁，越堆越多。时间一长，身体能量流中类似的沉积物会导致疾病。实际上，科学研究已将细胞间信息交流中断同细胞癌变联系起来。阻止细胞交流的任何物质障碍都有致癌的性质。例如，肥厚、粘连的组织只有在子宫周围和内部流动的能量已经在一定程度上被中断时才会形成纤维癌。

当我们无法充分体验孩童时期的情感时，我们的情感就停留在那个时期。我们的文明让我们将成人的理论知识同情感现实和需要分离开来。一个人可以拥有哈佛大学的博士头衔，而情感能力却可能像个两岁孩子。情感由于不被表达，不被承认，会被堵死在那儿。另一方面，被表达出来，被感受过的情感则能自由流通于能量系统之中，不会留下任何的后遗症。我们没有必要等到患上了癌症或其他疾病时才明白需要改变能量系统，开始创造健康。没有人能完全摆脱恐惧、愤怒和压力，它们是正常生活的一部分。只有当这些情绪变得严重，才会经常影响心理和情感的健康，我们才会生病，除非我们用健康的方法解决这些问题。当日常的无法消解的痛苦、愤怒和挫败感夺去了身体中最为重要的产生健康的能量，就必须将治疗和理解带入日常的思想、情感和行为中去。

下面之一点非常关键：一个妇女一生不遭受任何疾病的烦恼是完全可能的，即使她在儿童时期被虐待，殴打或忽视。儿童时期的问题并不当然带来能量紊乱和疾病。当一个妇女作为个体开始发展并将自己的身份和意志从家庭的和背景中分离出来时，才会有能量紊乱并导致疾病。这个时候她会意识到儿童时期的事情是不可接受的。但是她的意识来自于成熟的个人的视角，而不是孩子的。

一个妇女过去遭受的创伤并不一定会给她在生理或情感上造成潜在的伤害，但是如果她认为过去发生的事情是错误的，不应该发生，而且家人是故意地伤害了她，那些创伤才会构成伤害。她现在已将自己生活经历的矛盾模式引入情感和

心理形式，从而开始了有害的责难阶段。虽然在儿童时期可能被惊吓或虐待过，但早期的虐待并不一定会伤害她或她的身体，除非她开始相信她理应过另外的生活。这时她便从重新审视一段犯罪场面的个人角度出发，重新经历和评价那段早期经历。如果重新经历情感与痛苦时，她无法原谅和理解自己与他人，就会发生能量紊乱，导致疾病。

内心的冲突或义愤感所引起的生化反应需要两种主要能量：第一是当她开始记起来她确实在某种程度上被伤害；第二是当她认为那些事情是她的家人故意或有意识去做的。是这种心理状况而不是曾遭受的虐待会产生疾病。

我已学会了如何在自己体内识别义愤感造成的有害影响。长时间陷入这种能量的消耗会造成自我伤害。在这种状态中停留时间越长越想要寻找一个人来为我们所遭受过的虐待负责——不论这个人是某个男人，还是我们的母亲，或是政府、医生——我们身体的能量流失就越严重。

例如我们所说的乱伦，在某些文明中并不认为是一种罪过——它被认为是氏族内部的共享行为。在实施女性割礼的社会里，割礼通常定期由年长的妇女主持，部落传统认为没有接受割礼的女孩是“不法的”。在西方文化视角里，这是一种野蛮的行为。由于逐渐意识到割礼对女性生理、心理及精神上的影响，这个话题现在已经可以公开谈论，被重新评价。

乱伦和其他侵犯人权的行为在过去的 5000 年历史中常被视作正常之举。凯洛琳写道：“直到我们开始在部族范围内重新对个人进行界定时，以上行为才变成了犯罪。”我认为，这种集体的重新界定使我们人类从麻木状态中解脱出来。

早期的家庭生活显然对我们的性格和健康有着深刻的影响？例如在一篇颇有见地的论文中，作者指出一个人如果同父母不亲近，或父亲人情味不够，可能会较早丧失生活能力，或因自杀、过度紧张、冠状动脉疾病和癌症而死去。

地球的能量

传统东方哲学认为地球能量和人体能量之间有着深刻的互动关系，女性能量和地球的自然动力之间也具有密切联系。正确理解女性本质、女性生理周期，会给我们提供一个积极的、有效的恢复机会，使生活平和，健康。

根据东方传统的认识，女性身体与男性不同，区别在于地球能量在我们体内是向上、向内移动的。女性能量是“吸收性能量”，或是向心力能量。向心性女性能量是无法抵制的。它的力量巨大。在一个家庭里面，家人都会围绕在向心能量最强的人——通常是母亲——周围。如果她不在，家人都会有很强的反应。如果母亲不在身边，孩子们会在这一天结束的时候对母亲的离开产生抱怨。我的孩子们总想知道我在家中的哪个地方。如果我走出房间，孩子们一会儿就会叫：“妈，你在哪儿？”她们小的时候总要和我在一间房子里。我不能一个人洗澡，直到最大的孩子九岁。与此形成对比的是，小孩们对爸爸的离开倒是不以为然。女人的向心能量在下列情况下发生作用：为孩子哺乳，阴道接纳阴茎，发出化学信号帮助精子游向卵子。

米奇·库西是第一位将这种能量介绍给西方读者的长寿学教师。他指出，地球向心力从脚向上的传递在男女身上都有体现，正如上天的力量从天空进入头顶和人体(离心力)，不分男女都一样。有所区别的是各种能量显现的程度。在女性体内，一般来说，向上传递的地球能量，即向心力，出现得更多一些。别人告诉我印第安纳伐鹤妇女穿裙子的原因是因为裙子能在地面上形成比身体更大的圆圈，从而增加身体接受地球能量的机会。(见 P74 图 1)

向心能量是影响我们周围每个人的基本能量。因为妇女通常是家庭的中心，是家庭成员健康的精神寄托。因此，一个妇女的身体状况变好，她的整个家庭也会受益，为家庭的健康定下基调。家庭和社会的健康有赖于妇女的健康。创造健康相当程度上要依靠女性的能量及影响。一个妇女关爱的人的健康直接与她本人的身体状况相联系。因为女性的能量交流状况是我们需要关注的重要课题。

能量中心

向心的“内聚”能量是女性能量的特点之一。我们体内还有七个特殊的能量中心，情感——心理形式一般会影响女性身体和她们的能量中心，如果你听到这种说法后产生反感也不必感到惊讶。也不要因为往事导致现在生活的不健康而责备自己。只要意识到它们的存在，开始自身的恢复过程即可。每个女性能量：向心的或“退缩的”力量。通过双脚，地球的能量上升，然后，围绕着子宫、胸和扁桃腺旋转。一手资源微信 ipip885。

人，无论男女，都有相同的能量中心，受特定的情感和心理因素影响。这些能量中心联结神经、激素和情感。它们的位置同身体的神经、激素、免疫系统相平行，并在能量分析和生理分析之间形成联系。人体的能量系统是个全息场，它携带人体生长、发育和再生产的信息。全息场还负责基因过程的展开，将身体的分子转换成功能器官和组织。虽然正规的西方医学还未承认能量中心，但东方文明信奉它已有很长时间了。卡洛琳·密斯是一位国际知名的直觉医疗者，她研究疾病与体内能量的紊乱。我和她共事多年。是她让我最初了解能够导致身体能量中心健康或疾病的精神和情感形式。本次再版的时候，我根据蒙娜·舒尔茨博士的医学研究修改了有关影响特定能量中心区域的信息，她也是一位直觉医疗者和神经心理学家。

如果我们把能量中心看做是沟通情感的和生理意义上的身体的关键区域，我们会理解文化缺陷所带来的心理和情感后果，这些后果又会给我们带来相应的妇产科疾病或其他身体问题。无论你认为能量中心是真实存在的还是形而上学意义上的，它都有助于激活心理、身体的联系，从而有助于身体的康复。

人体的七个能量中心分别同特定的器官系统和特定的情感状态相联系。每个能量中心都会受个人信仰和感觉的影响，或被加强，或被削弱。换句话说，某种特定的情感实际上是针对特定的身体部位的(见本页图 2)。能量中心在不同的文献和文化传统里称呼有所不同，位置也不尽相同，这里所提的能量中心系统是将

我的临床观察同其他几位研究者的理论综合之后得出来的。了解能量中心后，你就会倾听自己的身体，相信对身体现状的直觉。我力图将每一能量中心的能量场形象化，这样就可以直观地发现它健康与否，是否需要关注。

虽然所有七个能量中心都很重要并相互关联，我将主要讨论那些同妇科、产科及乳房保健有直接联系的能量中心。某些文化传统认为上部能量中心比下部的“更为重要”或“神圣”，但我要强调这是典型的父权色彩的误读。如果我们认为下部中心“光彩”，都关注下部能量中心和需要，将它们视作整体的重要部分，而不是认为它们从属于“不好”的精神，我的星球和我们的个人生活就会变得欣欣向荣了。认为精神需求比生理需求更有价值其实是“精神回避”。观察这些能量中心的时候，注意哪些能量中心是你不愿多花费时间去观察的，并思考一下为什么。也许你想重新观察、了解它们，直到你感觉比较舒服。

在每个能量中心区域，都有与疾病相联系的两极。为了在某一区域保持健康或恢复健康，我们必须学会在每个区域两种极端情感表现之间寻求健康的平衡。我们的内部身体智慧通过每个情感中心把我们引向健康和平衡，方法是要求我们掌握全部情感表现的各种技巧。

还有一点：虽然有些研究者认为同责备、负罪、愤怒和失落相关的能量只对应具体的特定区域，通读有关身心相关的医疗文献告诉我们这种看法并不全面。这些能量同时影响身体各个区域，尽管它们往往只是在身体最虚弱的区域表现为疾病。与爱、希望和宽恕相关的增进健康的能量同样也是这样的。

女性的下部能量中心：

第一至第四能量中心

下面三个能量中心同现实生活相关联：人物，事件，记忆，经历，现实环境，过去和现在。这三个中心互相关联，互相影响。因此，虽然是单独讨论，大家也

必须了解它们是互相影响的。

第一能量中心区域受以下因素影响：对生活的安全感、信任与怀疑、独立与依赖、独来独往与投身团体的平衡，以及无畏与恐惧之间的平衡。第一区域事实上受我们对地球的感受和地球的一些过程之间的联系所左右。同第一能量中心互相作用的身体部位是脊柱、直肠、髋部关节、血液和免疫系统。我们的安全感通常形成于儿童时期，因为那时候我们对这个世界是否安全有自己的看法。因此，未被解决的家庭或现实生存问题，诸如住所、家庭、性身份、种族等等问题，都表现在第一区域。第一能量中心有问题的人通常都会这样说或这样想，“这儿没有人向着我”；“我很孤独”；“没人在乎我”；“我要饿死了”。

第二能量中心的健康分别同两个问题有关。第一是我们在生活中的动力，包括我们如何实现理想以及实际追求的目标。我们在追求理想的时候，是主动还是被动？是否受到约束？直接还是间接？我们是“主动出击”还是“消极等待？”最后，当我们追求理想时，是“毫无顾忌”还是充满顾虑，是否认为自己不配拥有自己想得到的东西？

另一个问题同人际关系有关。我们是否独立？是被别人需要还是需要别人？在与人相处时是索取得多还是奉献得多？我们界线明朗还是界线不清？我们是积极争取还是消极守候？我们保护他人，还是被别人保护？我们倾向于求异，还是求同？

盆腔和生殖器官同第二能量中心相关联，膀胱和盲肠也是。这一区域的健康受人际关系中的信任、控制、责难及负罪感等问题影响。如果我们用性、金钱、责难来左右人际关系中的力量对比，那么同第二中心相关联的这些器官便会受损。有第二能量中心问题的人通常会这样想或说：“我说的你听不进去”；“你从不来看我”；“他既不写信，也不打电话”；“没人会爱我”；“你从不在那儿等我”。

第三能量中心同一个人的自尊、自重和自我中心相关联。换句话说，在我们

现实的工作或成就中如何平衡自满与自卑。我们是过度负责或是不负责任？富有侵略性还是倾向于防守？我们是不是喜欢威胁别人？我们是倾向于扩张，还是感觉被困而想逃走？我们是完全按规则行事，还是经常打“擦边球”？最后，我们知道该怎样平衡自己的竞争力吗？知道该如何有风度地接受成功和失败吗？怎样对待收获和损失？所有这些问题都影响此区域的健康。女性的自我意识基于第一、第二能量中心中储存的情感、记忆和智慧。为了有良好的自我意识，女性必须在现实生活中有安全感(第一能量中心)，在互敬互助的基础上与人相处(第二能量中心)。同第三能量中心相关联的是膀胱、肝、胰、胃、小肠等器官。常见的有损此区域健康的观念是：“如果我不做，就没人做”；“我从来都不够好”；“可以，我自己来做”。

在早年生活中由于一些人物、事件、记忆和记忆产生的未经消解的压力会将能量从下部的三个能量中心带走。

对女性第一至第二能量中心产生影响的压力是：

生气

厌恶和拒绝

报复

由于害怕经济后果而不能放弃某种关系

以自己的身体为耻

因为家庭背景和丈夫的社会地位而感到羞耻

虐待儿童或在童年时期遭受虐待

有乱伦或被强奸的历史

为一次流产而自责，负疚无法受孕

无法发挥创造力

这些问题都潜在地影响“腰带”以下的器官，这是由于下部三个能量中心的共同作用造成的。现在我来详细讨论这些问题。

第一能量中心：家庭创伤如何存储于体内

第一能量中心的健康与个体的生长及早期生活有关。这包括核心家庭与大家族、种族、社会地位、教育程度、家庭遗传、家人期望值等，这些都是代代相传的。为了描绘与第一能量中心相关的问题，卡洛琳·密斯用了“部落”这个词。例如，我们很小就知道作为一个既定集体的成员意味着什么：史密斯家的或琼斯的家的，天主教徒或犹太人。另一个第一能量中心遗传是美国的第一和第二代移民的家族见解，即每代人都坚持这样的信条：要想有所成就，必须遭受磨炼，牺牲个人幸福。影响个人世界观形成的家庭创伤和社会、家庭信息与第一能量中心区域是相互联系的。

“部落”意志不同于个人意志。“部落”意志从根本上说是集体意志，它只寻求坚持群体的意志，努力让群体在世界中求得生存。部落意志关心的是忠诚而不是爱、和善与温柔。部落所言的“爱”实际是指明部落的义务，例如，一位家庭成员对另一位说，“如果你真的爱我，你就该多来看望家人和我。”部落意识，不是一种高层次、高度发展的意识，但是我们都在某种程度上分享它，许多妇女上了年纪后都承认她们可以听到体内的部落意志的声音。我的病人告诉我，“有时我听到我母亲的话从我的嘴里直接讲出来，我真是不敢相信。”有时我将部落意志称为“桶里的螃蟹”。如果桶里有许多螃蟹，而其中的一个想爬上桶沿逃走，

其他螃蟹把那只逃兵拉下来。妇女试图挣脱种种的约束时，她的家人也会这样做。家庭成员都想使她的努力落空——或至少开始时会这样。

不计其数的妇女在记起被虐待或乱伦的经历后将它们告诉父母，结果是她们的父母都对此矢口否认。潜意识里保持部落完整的动机使得许多父母否认曾冒犯过任何家庭成员。在某种程度上，家族记忆库里的记录事件与个人记忆大相径庭。

会导致疾病的第一能量中心问题。

同父母未了结的事情

乱伦

孩童时期被虐待或被忽视

孩童时期便形成的心理定势，诸如：

——“真蠢！”“没用的家伙。”“你是个坏女孩。”

——“天主教徒才能进天堂。”

——“身体可耻，必须隐藏起来。”

——“女孩就是为男人服务的。”

——“男人总是被首先考虑。”

——“女孩不应该野心勃勃，聪明过人。”

——“女人不能赚钱。她们必须嫁给钱。”

许多部落或家庭并不是有意要毒害女人。他们只是将部落智慧代代相传，即使这些智慧是限制性的和痛苦的。将以前的部落同今日的出现机能失调的家庭相提并论是可行的。

我的朋友卡拉在多种疾病治愈之后意识到，疾病的种子在儿童时期已种下。她的妈妈经常揍她，不是出于恶意或缺少爱，而是按照部落传统方式来爱孩子，让孩子成材。妈妈告诉卡拉打她就是爱她。每次在超市或其他地方看见别人打孩子，她便告诉卡拉很显然那人很爱孩子。卡拉的妈妈深深地认为生活艰巨，充满痛苦，要想有所成就，卡拉必须受苦。后来，每次有所成就之后，卡拉就得大病一场。现在卡拉意识到她可以用天赋和心理指引轻松地达到目标，她的生活不再是不断地生病和受苦。

第二能量中心：象征性的创造空间

第二能量中心同下列因素有关：日常现实生活的方方面面，同我们有关系的人，人际关系的能量。它还同我们所拥有的东西有关，金钱、各种关系和财物。由于我们自小就被教育要服务于部落，许多男男女女无意识地自动进入第二能量中心的角色。他们挑选符合自己第二能量中心的人作为伴侣。女人结婚是因为需要安全感、金钱、孩子、社会地位，以及害怕被抛弃。我们必须按相应的要求完成自己的使命，我们被定型为以满足部落需要为己任，并完全被第二能量中心产生的恐惧感所控制。

第二能量中心问题

人际关系创伤如何被存入体内。

害怕被抛弃

经济保障

社会地位

孩子

创造力

第二能量中心的主要器官是子宫和卵巢。

这个区域既是实际意义上的也是比喻意义上的创造空间，它能生育婴儿，创造出各种关系、事业、小说或其他富有创造性、艺术性的作品。这一区域能量流动不畅，就会产生纤维瘤等妇科病。

当我把子宫当做一个“潜在空间”的时候，我也在考虑妇女通常会在那里“储存”什么。子宫俗称“袋子”，作为拥有或曾经有过子宫的人，我们还把别人不愿承担的东西承担起来。已婚并有孩子的妇女经常会注意到孩子们把吃剩的食物，口香糖纸，以及其他不愿拿的垃圾都扔给她们，而不是她们的丈夫。我们也听说老妇人被称作“旧袋子”。怀孕、哺育、照顾小孩时，我好像也是一个扛着“很多袋子的妇人”。

妇女不仅负担着过多的有形的东西，同时还被要求为别人承担情感垃圾——通常是男人，但并不全是。一位有三个成年孩子的 60 岁病人同刚退休的丈夫住在一起。她告诉我她现在想圆自己多年的梦，比如旅行和写作。但丈夫对她所做的努力毫无兴趣。对于新近获得的自由他不知如何处置。病人说：“可是丈夫还是让我来背负他的阿尼玛——他的情绪，他的热情，他的快乐。当我不以为然，并表现出我自己的情感，他便闷闷不乐。”阿尼玛，是著名心理学家卡尔·荣

格造出来的词，指男人内心的女性倾向，当他不愿感受自己的情感并解决它时，他就将这种倾向投射到他生活中的女人身上。我们存储在身体的能量中心并无人愿意负担的东西到底是什么？当与无法解决的第二能量中心有关的人际关系、创造力，以及安全感等问题依然存在时，骨盆及背的下半部分极易患病。

许多第二能量中心问题是身体健康的隐患。克劳莉亚·巴赫曼博士的研究表明儿童时期遭受性虐待同饮食失调、肥胖、泌尿生殖系统细胞疼痛，滥用药物及其他自毁行为有关。罗伯特·雷特博士和其他人的研究发现以前的性虐待是骨盆疼痛的最大隐患。每当我遇到患有诸如纤维瘤等子宫疾病的妇女——40%的美国妇女患有此病——我就会让她思考她的人际关系、创造力和安全感。纤维瘤对这些方面有何启示？纤维瘤，子宫内膜异位，卵巢疾病，还有其他骨盆不适症都表明能量在盆腔受阻。在我们这个厌恶女人的社会里，40%的女人遭受过性虐待，1/3 被强奸，发生上述情况是不难想象的。

在一年一度的体检中，我在吉娜体内发现了一个小纤维瘤，她那年才 38 岁。我让她想想盆腔能量是否滞积，她后来告诉我：“回到家我就开始考虑这个问题。我意识到当我的兄弟死于车祸后，我对他的离去深感悲愤。我那时才 25 岁，确实无法承受这种悲愤。我将这份情感埋入盆腔。多少年来我再没想过这个问题。”三个月后的后续检查发现纤维瘤不见了，我相信通过第一次表达和体验她的悲愤，她改变了盆腔能量结构，将纤维瘤分解，将其由物质转化为能量。她对我说，“我有一种感觉，我今天到这儿之后，你会告诉我它不在了。我真的感觉它不在那儿了。”我遇见过其他女人在回忆起过去的遭遇并将痛苦尽情发泄之后纤维瘤变小或消失。

第三能量中心：自我意识和个人力量

女人的自我意识(第三能量中心)，是由安全感(第一能量中心)和人际关系质量(第二能量中心)共同形成。如果我们感觉安全并拥有良好的人际关系，这对我们

在现实生活中实现目标，完成任务很有利，这样我们就会实现自尊和自我价值。第三能量中心的强弱同我们在现实生活中自强、自信还是自卑有关，同我们承担责任的能力或是将责任推与他人有关，善于从成功或失败之中吸取经验教训有助于在这一区域创造健康。另一方面，好胜会削弱第三能量中心。它还受到好胜与消极之间的平衡的影响。

由于集体的和个人的历史，多数女人自视不高。多少世纪以来，女人除了服务与愉悦他人，在其他方面几乎就再也没有什么价值了。我们天生的创造愿望和在现实世界有所成就的愿望很早就被压制。因此，当女人成为自主的个体时，她们的家人通常不会支持她实现自我价值。

这是因为家人在潜意识中害怕家中女性成员为了满足个人要求和实现心中理想而抛弃家人。我们都承接了这样的观点，即女人只有在牺牲服务他人的能力的同时才能获得个人的充分发展。

除了要努力在个人兴趣和责任之间取得平衡，女人通常将自我意识纳入男性的圈子里。如果一个女人的伴侣非常成功，她也许会变得郁郁寡欢，因为她无法同他保持一致，或者由于害怕伴侣离她而去，她就不支持他进行不同于以往的、具有创造性的探索。另一方面，如果伴侣在现实世界中不成功，因而情绪低沉、易怒，这也会影响女性的第三能量中心。诸如此类的问题会导致第二能量中心的能量系统失衡，并引发饮食紊乱，或胃部、膀胱、小肠、肝和胰脏疾病。

无兄弟，不把妹，更多一手情感课程请添加微信：kc58567 微信：sm99878

原型与前三个能量中心

如果一位女人感觉是在被迫参与活动，她的身体，心理和精神会受到伤害。当她不明智地参与了自我伤害或被别人伤害的活动，她的行为在能量医学里被称为强奸原型。

原型指心理和情感模式，它们会在潜意识里影响我们，直到我们意识到它们的影响。原型是我们在潜意识里所共有的思想、形象和思考模式。虽然原型概念开始会显得比较模糊，但是这些潜意识里的思考和行为模式对我们的身体和情感有影响。

现在的女人总是考虑孩子的需求而放弃自己的需求，即使孩子们长大并有能力照顾自己了，她还是经常考虑他们吃饱了没有，高兴与否，问寒问暖，为他们着想，忽视并压抑自己的需要。这种受文化鼓励的担心行为是非常有害的一种原型模式。另一原型为英雄原型。一看到英雄这个词我们马上就会联想到强壮、勇敢。英雄是毫无惧色救援他人而忽略自身安全与需要的，因为他有“救助”别人的癖好。如果是无意识的，这种行为也会对健康不利。

当我们无意识参与到原型行为中，我们就会与内心深处的自我和内心需求失去联系。当一位女人不是按自己的意愿行事而是一味满足别人的需求，她会因情况不同而受到强奸原型、妓女原型，或母亲原型的影响。

强奸与妓女原型关系密切。当一位女人身不由己陷入性关系中，她是受到强奸原型的影响。如果她拒绝性带来的快乐，因为她认为那是她的性伴侣所需要的，那也照样是相同的原型在作怪。强奸原型发生在一个女人加入了对自己的损害的时候，例如由于伴侣的意见她不得不堕胎；厌恶伴侣，却由于经济或其他原因维持关系的女人不是出于个人原因，而是受妓女原型的影响。受这种原型支配的女人通常是自责或忍气吞声。因为害怕讲出去会被抛弃。当一位女人富有侵略性时，与第二能量中心有关的器官就有危险。当她侵害了孩子的生理和心理防线，她也就参与了强奸原型。每日的灌肠和用力擦洗外生殖器也使她成了强奸犯。女人运用感情武器，而男人加上了拳头。实施侵犯的女人要付出代价，那就是第二能量中心的女性器官能量失衡，以及第一、第二能量中心的器官出现问题。根据卡洛琳·密斯的研究，侵略性行为同前三个能量中心的器官癌变有关联。

理解并接受女人具有潜在进攻性这样的看法很重要。如果我们拒不承认问题

的存在，结果只能是使其永久存在。从父权影响中解脱出来并不意味着去指责男人，因为在我们的文化中所有人都是牺牲品，都是潜在的维护者。当我第一次接受卡洛琳·密斯的治疗时，她告诉我，我的身体记录了在 21 岁至 29 岁之间常遭强奸——这是我在医学院攻读和做住院实习医生的阶段。虽然我未遭真正意义的强奸，我的身体能量系统由于医学训练而在情感和心理上遭受“强奸”，那时我对此一无所知。密斯解释说我们的文明中的个体至少经历过一次心理或情感上的强奸。这就是为什么许多未曾遭受性虐待的女人也有慢性骨盆疼痛和其他第二能量中的问题。许多女人难以忍受工作中每天充斥着强奸或妓女原型的现实。

如果我们仅将女人作为受害者，我们就无法认识女人对自己和他人造成的伤害。如果你曾被女性虐待，或虐待过别人，你会理解这种观点的重大意义。

羞耻心与前三个能量中心

许多女人所面临的另一问题是羞耻心。耻辱同前三个女性中心及其相关的内部器官相关联，包括子宫和卵巢。羞耻心来自社会传统，传统认为女人低人一等。也可能来自家庭关系，例如与孩子不健康的关系或伴侣社会地位的不光彩。强奸带来的羞耻感，不管是生理的、情感的或心理的强奸，都会影响阴道区域。

研究证明了这些能量失衡机制。一份调查发现患内部癌症与患外部癌症的妇女有着不同的人格。认为自己的身体是否易受外部有形的或情感因素的渗透，决定她是否易患癌症。认为自己的身体易被外物渗透的女人患癌症的部位倾向于在身体内部——例如，卵巢或子宫。认为身体强壮、不受外部影响的女人易在外阴部患癌症。

第四能量中心

同第四能量中心相关联的身体器官分别是心脏、乳房、肺、肋骨、后背上部、肩膀。它同我们表达情感和参与平等关系的能力有关。当我们进行情感表达时，我们需要平衡愤怒和爱，欢乐与严肃。我们可以有时淡泊，另一些时候却可以在情感上放肆一次吗？我们可以充分体会痛苦和失落吗？在两人关系中，两人共处的时间与独处的时间都平衡吗？我们既可以养育别人，也允许别人养育我们吗？引起第四能量区域疾病的情感和心理问题包括不能给予自己或他人以爱，或不能从自己和他人那里得到爱，缺少宽容，没有消解痛苦或敌意的能力。

第二与第四能量中心有特殊的关系，子宫有时被称作“下部心脏”，胸部的的心脏有时被称作“上部心脏”。据说如果由于强奸、乱伦、虐待或羞耻致使下部心脏关闭，这个女人就无法真正开放上部心脏。在我们的文明中女人也倾向于关闭下部心脏，或她们的性和性需求，因为我们被告知“好”女孩不性感。我们也被告知，同我们的情感相接触没有坏处，这样我们就被卷入了第二、第四能量中心的矛盾中。另外，女人还被告知，如果我们取得经济上的成功，我们就会同别人疏远，也体会不到亲密关系。这是为什么现今许多成功女人发现有必要重新审视她们的情爱关系。

当女人不知如何运用她的爱（第四能量中心）和创造性的（第二能量中心）能量，能量失衡问题便会出现。女性所面临的主要矛盾在于我们之中的大多数人仍然认为：若要被爱、接受爱、保证有人需要我们，我们必须关心所爱的人的外在的现实的需求。但是这种依靠家庭义务和部落传统的爱的关系，在女性开始自我觉醒并意识到自己的行为时，便被认为是沉溺于对人际关系的依赖。同时第二、第四能量中心区域也会产生能量失衡问题。它们的出现是因为女人无意识地同时参与强奸原型与母亲原型。

萨莉是位 26 岁的服务员，患有早期宫颈癌和多重乳房囊肿。孩童时期，她与父亲在情感和身体上都很疏远。18 岁的时候，为了填补这种空虚，她拥有多个性伴侣，都是些她既不爱也不尊重的男孩。这种自我麻醉的行为模式扰乱了她第二能量中心区域的能量形式，导致极端痛苦的阴道疱疹不断发作。她还患有外

阴疣。

正如萨莉的冷漠的父亲一样，她的母亲对自己或女儿的生理和心理需求也都漠不关心。萨莉从来不关心自己的情感需求，因为没人演示过这种行为。萨莉及其母亲在第四能量中心的能量失衡同她们缺少自尊和自我爱护有关。母女都有胸部问题。萨莉的母亲已患有乳腺癌，萨莉的乳房组织中有两个良性肿块。

萨莉和她母亲在我们的文明里绝不是特例。我见过许多与她们一样的妇女。当女性忽略自己的内心需求，麻木不仁地做饭，洗涮，关照家人的物质需求，特别卖力地工作，把提供性当做尽义务或是出于负罪感，那么她在第二和第四能量区域更易于患病。为了减轻由于害怕被遗弃、担心自己不够好或关心自我意识带来的不安全感耗尽了她的情感能量。

为了证明这些有关能量系统失衡的理论，研究表明只在第二能量系统有病的女人与只在第四能量系统有病的女人人格模式是不同的。

患有恶性乳房肿瘤的女人同患有宫颈癌的女人有不同的人格模式。一项调查表明，50%的宫颈癌患者由于父亲死亡或早期被遗弃而失去父亲。与此形成对比的是乳腺癌患者的家中都有一位情感冷漠的父亲。另有研究证明更多的宫颈癌患者的行为表明第二能量中心的能量不平衡。她们结婚次数多，与自己既不爱慕又不敬重的人发生性关系几率高，过分关注体形和身材。她们还感觉在孩童时期遭到忽视。对乳癌患者的调查表明她们的行为模式同第四能量中心机能失衡有关，她们更倾向于维持一个无爱的婚姻，更有可能在儿童时期对年幼的弟妹承担责任，拒绝为自己进行医疗保健和自我保养的可能性更大。

卡洛琳·密斯和蒙娜·舒尔茨的研究成果进一步证实了以上的理论。总的来说，她们发现不同程度的愤怒影响腰带以下的身体部位的健康。无法宣泄的悲痛则同腰带以上的部位有关。有关情况在第五至第十章将有详述。

怎样治疗下部能量中心的创伤

下部能量中心创伤只有在被证实存在时才会被治疗。必须有人说，“是的，这确实在你身上发生过”。这样就证实了创伤的存在，之后恢复过程才能开始。我治疗女性的重要部分就是这个证实过程。作为医生，我代表着权威。当我或其他人证实一个女人的创伤时，她就可以以此作为疗伤的契机。但更为重要的是她本人承认创伤的存在以及治疗的必要。只要她还在否认，她便无法告诉自己事情的真相。她的秘密会被锁闭在细胞里，无法得到证实和治疗。

创伤的存在被证实之后，女性还必须调查这些创伤是如何影响她的生活的。这是命名阶段——在此阶段她意识到她的生活确实被其他人或事件伤害过。她不再否认。社会中的许多妇女现在正处于这个阶段。治疗和恢复女性能量系统的最后阶段需要宣泄创伤和控制生活。现在需要的是对自己和他人的宽恕。

其他能量中心问题

第五能量中心同交流、时间概念和意愿相关。当你将自己的思想与外部世界进行交流的时候，你是说得多还是听得多？你的表达能力与理解能力一样吗？就时间安排来说，你是往前赶还是往后拖？最后，你是喜欢按自己的意愿行事，还是随大流？与此能量中心相连的是咽喉、嘴、牙齿、牙床、甲状腺、气管和颈椎。该中心的能量失衡包括慢性咽炎、喉部和口腔溃疡、牙龈疾病、颈椎疼痛、甲状腺痛、宫颈疾病、扁桃体肿大、喉炎。有第五能量中心问题的女人通常不会为自己辩驳，没有主见，嗓音轻柔得让人难以听清。另一方面，个人意愿太强会引发诸如甲状腺肿大等疾病，以及不顾忌“更高意志”或“更高力量”而我行我素——例如，“我不在乎身体告诉我的信息，无论如何我要这样做”。

第六能量中心，有时也称作第三只眼，与观察力、思想和道德有关。观察外部世界时，我们是不是既能清晰地观察又能容忍歧义？是不是既能聚焦精确又能

聚焦模糊？是否知道何时须倾听何时无须倾听别人？是不是在积累知识的同时对所需学习的东西持开放态度？承认自己有无知之处吗？是否既承认左脑的理性与逻辑又承认右脑思维的非理性和非线性？我们的思维过程是严格的、繁杂的、反复的还是富有灵活性？是否有自我压抑倾向？是希望成为有责任感的模范公民，随时随地以严格的标准在评价自己及他人，还是有时候会自由一些，爱冒险，不受拘束？这个能量中心位于眼、耳、鼻，脑和松果腺之间。与此与心有关的疾病有视觉问题、脑肿瘤、血栓、神经紊乱、失明、失聪、突发性心绞痛，以及学习障碍。下面这些话同此区域能量丧失有关并危及健康：“我不管你感觉如何，告诉我你怎么想。”“做出决定还缺少足够信息”；“你难道不明白我知道自己在说什么？为什么还要同我争论”？“我很惊讶你会相信身心一体这种无稽之谈，你虽然还是一个受过教育的知识分子。”

第七能量中心与生活中的远大目标有关。它还同我们的态度、信仰、价值、良知、勇气和人道主义精神有关。我们目标感明确吗？承认作为个体的我们具有创造生活的能力，同时又承认宇宙中更高力量的作用吗？我们明白这样一个矛盾吗？即知道有些事件受我们左右，有些却不受我们控制；有些我们不喜欢的事却服务于一个终极目的而我们目前又无从知晓？这个能量中心位于头顶。它是我们赖以建立道德标准和良知的形而上的框架。

生命中任何危及生命的事件或重病都有可能开启这一区域的智慧，将你同宇宙观相联系，并了解身在其中的目的。有过死亡边缘经历的人通常会说它在各个层次改变了她们的生活，并让她们明确该怎样最好地度过余生。虽然所有危及生命的疾病都有第七能量中心的意义，那些与唤醒此区域智慧有特殊关系的疾病包括：瘫痪、影响肌肉和神经系统的多种疾病。患有基因疾病的人生下来就受到第七能量中心的挑战。

理解能量分析是恢复的真正关键，而不是仅仅为了遮掩症状，因为它提供了一个全面和整体的看法，让我们知道每个人是如何创造健康或产生疾病的。本章大部分内容对你可能是陌生的。多用点时间，以它自己的方式来理解它，健康将

会是水到渠成的事。

我们活在现在，身体就处于最佳健康状态。我们恢复并保持健康的力量就在现在，就在这一刻。如果我们是真正地存在着，我们会治愈几乎所有的病。但大多数人将能量消耗于过去的创伤，而剩下的能量又被消耗于对将来的担忧。如果现在无法得到大量的能量和精神，你无法治愈任何病。刘易斯·托马斯博士曾说过他逐渐认识到癌症是极端要求发展的生理隐喻。健康生长意味着调动你现在所能调动的所有身体部位——“现在”是治疗发生的唯一地方。一个人很少能一直真正地存在，在现在，在今天。生活在现在是一门技巧，它的取得是通过回顾、静思、大步将信仰带入自由和快乐——一次一小步，一天一次。

请留意你的感觉。记住许多疾病开始于受阻的情感。你记得什么?关于刚刚看完的上面的信息，你有什么要知道或做的吗?第十五章——“治疗步骤”会帮助你解决这个问题。

一手情感资源请添加微信：kc58567 微信：toshu329

第五章 月经周期

女性智慧的剖析

月经周期会是怎样的不同？如果，当你首次月经来潮，妈妈送你一束鲜花并带你一起去吃午餐，然后你们两个一起到珠宝商那里同父亲会面，你穿了耳眼儿，你得到了父亲赠送的第一对耳环，然后你和你的以及妈妈的朋友一起去纹了唇线，这可是你的第一次；然后你便走进了的确第一次，走进了女人的行列，去学习，作为女人的智慧，你的生活会是怎样的不同？

——朱迪斯·德瑞克《结石的周期》

通过把它与自然本性循环相协调，我们能够开发女人月经周期的智慧，并把它作为女性力量的源泉来庆贺。梦想、创造力及内分泌伴随着经期的不同阶段衰退或涌动，给我们提供了一个意义深远的机会去加深内心世界的体验。这对大多数女人而言是个渐进的过程，这个过程包括发掘我们的个人历史，然后，逐日地对这个周期进行不同的思索，以新的方式与之共存。

女性生理循环的本质

月经周期是我们最根本、最自然的生理循环。血液是我们同女性原型联结的纽带。自然界的宏观循环，像潮汐的涨落，四季的变化与单个女性生理上的月经周期相映照。每月一次卵子成熟，进而受孕或是经血的流逝反映着创造的过程，这不仅发生在自然界，也不自觉地体现在人类的努力上。在很多文化中，月经周期都被认为是神圣的。

即使在现代社会，尽管我们断绝了与自然的密切联系，排卵周期仍然受月亮

影响。研究表明，怀孕的高峰期或说排卵时间似乎发生在满月或满月前一天。在新月期间，排卵和怀孕率大为降低，而开始经期出血的女性数量增加。科学研究证明，月亮控制液体流动（不论对大海潮汐或是对个人的体液都是一样），影响无意识的大脑和人的梦境。月经周期、生育周期和分娩的时间选择是随着月亮对潮汐的支配的。诸如光线、月亮及潮汐等环境因素证实了女性的月经周期和生育活动是有规律性的。最近一项研究表明，在 2000 名经期不规律的女性当中，在她们排卵前后三天里，用睡觉时加放床灯的做法，使超过半数以上的人实现了形成 29 天的固定经期。

月经周期不仅控制着体液的流动，也支配了信息和创造力。我们在经期的不同时段里，对信息进行不同的接受和处理。我喜欢以这种方式来描述月经周期的智慧：从经期开始到排卵，我们孕育了一个卵，至少是象征性地准备好了生育，这是一个令社会尊重的任务。很多女性发现从经期开始到排卵，她们在外部世界的表现达到了一个顶峰。她们的能量流露并且上升，充满了热情和新的念头。到了经期一半时，我们很自然地更能接受别人和新的想法——更富想象力。对很多女人来说，这时候性的欲求也达到了顶峰，身体分泌的激素透入空气，使我们看上去更有性的魅力（我们的男权社会对此评价极高，我们只内在化地把它视为生理周期的“不错的”阶段）。有个患者是在餐馆工作的女侍，她的美艳常使许多过往的卡车司机忘了吃饭。她告诉我月经周期中途、排卵前后她得的小费最高。另外一个男人向我描述在这个时间段里，他的妻子简直“要命和令人震惊”。

卵泡和黄体阶段

经期本身反映了意识如何成为物质，思想如何创造现实。从严格的物理意义上来说，月经来潮到排卵（即所谓的卵泡阶段）这段时间，随着卵的发育和成长，在更深入的子宫壁上，免疫系统细胞的循环聚集（即所谓淋巴集合）也开始发展。从更为广大的思想和创造力的意义来说，月经期的前半段是开始新课题的极佳时间。我的一个研究者朋友告诉我，在这段时间里她最有精力按照想法去开展实验。

发生在经期中间的排卵现象，伴随着神经肽中促滤泡激素和促黄体激素的突然升高，与雌激素的升高相伴随，左半脑活动性（像流畅的口语表达）上升，同时右半脑活动性（像视觉空间能力，比如画立方体或看一幅地图）下降。排卵现象体现出精神和情感的创造力都达到了顶峰；就此而言，与排卵现象相伴随的 FSh-LH（促卵泡激素-促黄体激素）波动也许是生物学的基础。排卵在接下来的数星期为月经来潮作了准备，这时是估价和深思的时间，回顾一下这段时间里创造了什么，生命中哪些消极和困难的方面需要改变和调整。我的研究者朋友在笔记中提到，在这个周期的部分，她宁可做些无需从别人那儿获取大量信息的常规任务，或是就她那方面来说，开阔一下思路。

我们开创性的生物学与心理学上的周期与月相并行。近来有研究发现，生殖道的免疫系统同样是周期性的，在排卵时达到高峰，然后开始衰弱。古代有些文明，把女性月经来潮称之为“在她们的月亮上”。当女性在自然安排下生活在一起，她们的排卵时间趋向于在满月时发生，而月经来潮和身体反应则发生在月晦时。有科学证据表明，生物学的周期、梦境与情绪的韵律与月亮、潮汐及行星相适应。更明确地讲，月亮、潮汐与我们身体的电磁场相互作用，随后影响到了我们的心理过程。月亮本身也有周期，开始被一片黑暗覆盖，然后慢慢地，我们能再次看到它了，这是新月，然后月亮渐渐由亏转盈。同样，女人在每个月也经历一段黑暗期，这时生命力似乎暂时消失了（月经前和经期阶段）。如果我们的精力和情绪在每月当中有几次自然衰退，我们无需害怕或认为自己病了。在印度的多数地区，女人在行经期间可以放松或得到更多休息，这被认为是完全可以接受的。我已经开始看到各种与压力有关的疾病，从经期前综合征到骨质疏松症，这些都可以给我们很大的教训，那就是简单地去适应每月一次的身体状况才是明智的。德米特·乔治有张图表，月晦时，“在进化发展中，生命本身需要纯净、新生和改变自身，朝着作为本质天性的谐调方面作螺旋式的上升。”研究表明，大多数女人在新月时开始她们的月经期，并在凌晨四到六时之间来潮，这个时辰是一天中最黑暗的。包括我在内的许多女人注意到，在行经时的头一两天，我们感到一种强烈的欲望，要去组织好家庭或在空地上工作，清扫厕所——以及我们自身。对生理自然的清理也伴随着心理上的清理。

如果我们没有在排卵时造成生理上的受孕，我们就进入了周期的下半部分，黄体阶段——通过月经排卵。在这个阶段，我们很自然地从事外部活动退回到更为内在的方式。在黄体阶段，我们更多地转向内心，准备发展或产生一些东西，它们来自我们更为内在的世界。社会对此并不像在卵泡阶段那样热心。这样对我们判断月经前的精力、情感和内在情绪就是“不利的”，并且是“没有收益”的。

自从我们的文化总体来说只欣赏那些我们能进行理性理解的事物以来，许多女人主动利用每一个机会去阻碍这种社会倾向，她们在经期前或月经周期过程中，任由无意识的“月亮的”信息四处涌动。月亮的信息具有映射性和直觉性。它进入到我们的梦境、情感和内心渴望当中。它在黑暗的遮掩下悄悄而来。我们在月经周期的后半段时间习惯性地抵御它，它虽无选择，但却会以经期前综合征或绝经期的愚蠢行动重现自己，同样，如果你忽视我们的其他感情或生理征兆，也会导致疾病的产生。

黄体阶段，从排卵直到开始行经，是女人的内在意识与外部作用最和谐的时期。有研究表明女人在她们生理周期的月经前和行经阶段，做梦是相当频繁和活跃的。月经前，可见世界与不可见世界、有意识和无意识之间仅有一层之隔。我们有权使用部分的无意识自我，它在一个月当中的其他时间发挥作用较少。事实上，据实验显示，大脑右半球——联系直觉意识的部分——月经前变得非常活跃，而左半脑就不怎么活跃。很有意思的是，两个半脑之间的联系也会增加。因此，在月经前阶段，我们能更多地使用自身魔力——认识和转移更多的自身困难和痛苦的能力。在月经之前，我们能相当自然地去调谐生命中最有意义的部分。我们更容易哭泣——但我们的眼泪总为那些能给我们起好作用的事情而发。凯特瑞娜·德尔顿博士的许多研究证明，女人在月经前更加情绪化，更容易发泄愤怒，更容易感到头痛和疲劳，她们甚至会加剧当前的病症，比如像关节炎。如果我们与自身内在的一些部分不能保持接触，那么在此范围内，我们将忍受月经前的痛苦。多年的个人和临床经验告诉我，发生在月经前的痛苦和不舒适的问题总是真实的，必须加以妥善处理。

女人们需要相信月经前这些问题的重要性。在我们月经周期的前半部分，也就是我们所谓的“不错的”阶段，尽管生理器官和大脑也许并不会表露或涉及这些问题，可我们的内在智慧却无疑在要求引起注意。比如说，一位女士曾向我诉说，每当她到了月经前时，她就会为家里的房子、汽车和投资等都隶属于丈夫名下而感到焦虑。当她向丈夫提及此事，丈夫回答：“怎么了？难道你还不相信我吗？”我得说月经前进行确实的检查需要引起重视。有一位丈夫谈到妻子在月经周期卵泡阶段时说，她很了不起，总是表现得很愉快，把房间整理得井井有条，并且下厨做饭。但在排卵以后，她“情不自禁”，还谈到想回去念大学，并且还经常外出。我告诉他这些月经前发生的问题需要认真对待，并让他考虑妻子的需求是完全的个人发展。我向他指出妻子月经前的奇怪行为是她表达那些需要的方式。

贯穿于月经周期的女性心灵和卵巢机能之间有一种密切的关系。排卵前，我们友好而乐观；在排卵期间，我们很善于接纳别人；排卵以后(月经前)，我们则变得更加内在化和善于思考。30年代的一个令人震惊的研究成果能够支持我的观察。心理分析学家瑟雷斯·本纳代克研究了一批病人的心理疗法记录，同时她的同事波瑞斯·鲁宾斯坦博士研究这批女病人的卵巢激素周期。通过观看一位女士的情绪记录，本纳代克博士能以不可思议的准确性预言她什么时候开始月经期。作者写道：“通过两种各自独立处理的方法，我们高兴和惊讶地发现排卵的日期确实是一致的。”就是说，通过对心理分析的材料与生理学的发现两相比较，他们发现排卵之前，雌激素水平达到了最高点，女人们的情绪和行为直接朝向外部世界。然而，排卵过程中，女人们显得更加轻松和满足，更能接受别人的关心和爱。在排卵后和月经前的阶段，当黄体酮达到最高点，女人更多的可能是关注自身，更多地沉浸于内心直觉的活动。有意思的是，在那些有月经周期却不能排卵的女性当中，作者发现了情绪和行为的相似周期，除了排卵将会发生的时间里，这些女性失去的不仅仅是排卵机能，还失去了与之相伴随的各种情绪；就是说，她们不能够做到轻松、满足和接受别人的关心。关于疾病，我们继承了一般性的文化遗产和观念，还有对月经周期的特殊认识，女人开始意识到，月经前的阶段并不仅仅是生理的反应和更新，也是一种疾病或者说是祸因。事实上，通过实验

的证明，我们的文化所使用的观念是，认为子宫和卵巢影响了女性的月经周期。催眠状态下，在月经周期方面，如果一位女士被给予了积极的暗示，她将不大会在与月经期有关的症状中遭受痛苦。另一方面，一项研究发现，在对两组女性的测验中，一组被诱使相信处于月经期前，另一组则相反，结果前面一组表现出更多对身体的不利症状，如排汗不畅、痛经或急躁等。这些研究都是很好的例子，说明了我们的思想和观念能够影响我们的内分泌、生物化学反应及以后的经验。

通过月经周期进行治疗

一旦我们开始正确认识月经周期，把它看作内在引导系统的一部分，我们就能开始治疗不论是内分泌方面还是情绪方面的疾病。毫无疑问，很多女性在月经期前感受到更多的内心直觉，并更多地把个人病痛与世界的痛苦联系起来。尽管以后不一定去实践，还是有很多这样的女性把内在感受与她们自身的创造力联系起来，在月经期前获得最好的想法。在月经期前的阶段，我们需要时间去独处、休息、摆脱日常事物，但对很多女性来说，怎样利用这段时间成为新的想法和实践。我们的需求如潮汐般涨落，若不尊重它，结果就会是月经期前综合征。这个社会喜欢行动，所以我们经常不重视自己休息和补充的需要。月经周期提醒我们生命过程中有投入和放松的需要。当我们处于月经期前，感到虚弱，我们需要休息和照顾自己一两天。在美国土著的月亮小屋中，行经的妇女聚在一起，恢复身体，进行幻想，鼓励自己也鼓舞了别人。我想，现代女性如果在每个月里能够从日常事物中脱开三四天的时间，由别人带来饭食，那么，多数的月经期前令人不快的症状都会消失。

由亲身经验，我发现，我所需要的全部，仅是简单地和无需愧疚地向丈夫声明每月一次的休整需要。当我显示出对自己和自己的生理过程的尊重，他也同样表示出尊重，身体则会以舒适和感激的姿态作出反应。确实，当我注意到，在经期前一两天里，我对自身，对我的生命及写作等最具洞察力时，我对自己月经周期的看法与以往不同了。过了 30 岁，我才开始渴望自己的经期，并把它们作为

神圣的时刻来理解，这是我们的文化不曾做到的。月经期前，对我而言，能勾起我眼泪的事是最重要的，因为我知道这些事与我的力量和最深挚的内心相连。我增长的敏感如同洞察力的礼物。我没有变得恼怒，尽管如果我这样做了，我也会注意，不会将之归罪于“我愚蠢的激素”。我喜欢在台历上追踪月相的变化，记录自己的排卵日期，是在满月、新月还是两者之间。当我在满月时排卵，新月时行经，那么内在反应时间与月亮的晦暗同步。若我在满月时行经，结果会是更为剧烈的：我表现得比平时更为情绪冲动，经血也比平常多。我发现有时仅仅简单地预计经血在新月时出现，这也会影响到周期朝此方向进行，但也不总是这样(我并没有试图“人为地”控制它)。有意识地记录我个人的生理周期与月相变化周期的关系，使我与自然相沟通，并帮助我感受与过去及现在的女性的联系情况。

我们的文化遗产

直到 5000 年前，当古老欧洲和平的母系文化毁灭之前，月经周期和女性身体一直被看做是神圣的。“禁忌”一词的原始含义是“神圣的”，经期间的女性被认为是神圣的。现在的一些社会却把她们看做是不洁净的。她们的梦境和幻想过去经常被作为部落的指引。世界范围内的当地文化都很重视年青女性成年的节日。母亲们、阿姨们和其他的成年女性，把首次月经看做成为“正式女人身份”的开始。超过 6000 年前的考古学实物指明一个事实：刻有记号的骨头就是原始的日历，它们是女人用来记录生理周期的。然而在遍及西方历史的书面记录中，甚至在宗教法典里，月经周期经常被认为与羞耻或退化相连，与女人的无知、不可控制的天性相连。经期间的女性被认为是不洁的。在公元前 65 年，普里尼——一位教会长老写道：

但很难发现有比女人每月流出经血更不可思议(记着这个矛盾的词义选择!)的事情。它的出现总与灾祸相连：它使新酒变酸，农作物歉收，花园中的种子干枯，树上的果实跌落。它能使镜面无光，钢刃变钝，使象牙失去光泽。蜂箱中的蜂群也会死掉，甚至使青铜和铁器立即锈铸。它使空气中弥漫着可怕的气味。狗

若尝到了经血就会发疯，咬人一口，那就无可救药。

与月经周期相关的禁忌一直持续到现在。一代代的女性受到教导：在这段时间里我们的身体抵抗力更差，不能去游泳、洗澡或洗头。这些信条原本根据维多利亚时期的理论，这种理论认为月经期间洗澡、洗头或游泳会导致经血的“逆行”，结果是中风、精神错乱或者是急性肺结核发作。时代更近一些，则认为这段时间里碰了水会引起感冒。所有这些禁忌都是没有科学依据的，然而它们却起到了使一代代的女性害怕这一自然生理过程的作用。

如果我们打算开发月经周期智慧并尊重其自然本性，我们就必须承认与上述认识相反的态度，那就是我们中大多数人已经开始内在性地关注月经周期。我们必须承认许多女性每月一次经期体验的疼痛和不舒适。我们的月经周期已经成了各种玩笑话的奚落对象，诸如“戴上月经带了”或“倒霉了”等。对许多女性而言，青春期和首次月经充满着羞愧与耻辱。在我们的社会中，除了暴力和恐怖外，没有什么比月经周期的衰弱对女人影响更大的了。

对于月经周期，以科学的知识替代有害的遗传神话是进行女性治疗的一个部分。当今社会，女性首次月经大多发生在 12 岁前后，至此一名年青女性就达到了性别上的成熟。完整的生理构成需要月经期的开始。对一名年青女性来说，通常体内脂肪含量达到 17% 时才能开始行经。研究显示，对大多数女性而言，承受排卵周期需要平均 22% 的身体脂肪含量。为什么年青女性中的厌食者、舞蹈家和运动员中，那些身体非常瘦的，一般没有固定的经期，这是一个原因。尽管年青女性的首次周期通常并不排卵，而在以后数年中会逐渐形成生育能力，每月从卵巢中排出一个卵。如果每月排的卵在周期中途并未受精，结果会在排卵后大约 14 天左右进入月经期。月经来潮时，子宫壁（子宫内膜）成了保护舍。每个月中，子宫壁、子宫内膜周期性地积聚并形成保护舍，受卵巢、垂体、下丘脑所产生激素的刺激，形成复杂而奇妙的相互作用（参看图 5）。由于这种内分泌相互作用的复杂性，女性生命中的许多方面影响了月经周期，周期又依次影响到了女性生命中的诸多方面。

多数女孩子通过枯燥的、临床的方式学习有关月经周期的知识，并不重视自己的生理和性征。她们很少讨论身体、性征是如何与月经周期相关的。极少有女孩子被介绍说月经是阴道内的定期活动。我母亲过去曾经告诉我有关“生命的本质”并向我解释何为卵和精子。我回忆起当时听了感觉非常难过。那时我上四年级，妹妹比我小 11 个月，在那天之前，我曾向妈妈发问：“妈妈，我知道婴儿是从哪儿来的，但他们是怎么到那儿去的呢？”妈妈把我们带到卧室，给我们念了本书，书上说女孩子大概到了 12 岁左右就会出现月经周期，在有了经期之后，如果她们过性生活就可能会怀上孩子。

我对这些知识并不欣赏，我一直希望女人怀孕是通过接吻而不是通过像妈妈描述的那样令人作呕的行为。为何我认为整件事如此令人作呕，也许与我母亲自己体验的青春期的开始有关。她并不关心月经周期的含义及女性生理的神圣，尽管她过去和现在都很聪明，并走在她那个时代的前列。我母亲曾认为，一旦她有了月经周期，她就不能像往常那样快活了。少女时期她最喜爱的活动是打棒球、同男孩儿一起爬树。一旦当她“成了女人”，就不允许她再和男孩子们一起玩耍了。多年以后，母亲告诉我她曾恳求祖母带她到医院去“接受治疗”，以便使自己不再有月经期并能重回棒球场。对于月经周期，由于直到 60 多岁时母亲都未能完全释怀青春期的情结，所以尽管她是将其作为生命中的寻常部分向我介绍的，我还是从中吸收了她的一些关于月经周期的无意识感受。

与把女性的生理周期作为生命中积极的部分来庆贺相反，我们的文化教育我们，根本不应该承认有什么月经周期，省得因此而忽视了配偶和孩子们的需要。这儿有一段 1963 年月经棉塞盒内的插页摘要，考虑一下上面说的话吧！

当你成了妻子

别想要去利用你的丈夫，这是美好婚姻行为的古老准则，现在这样做与以往同样明智。当然，即便你并未尝试这样做，偶尔不自觉地越界还是在所难免。

例如，你不该借月经之名打扰丈夫。月经期在每月里是很寻常的，然而如果你忽视了这个简单规则，做出仿佛你病了的样子，那么你就是在利用丈夫的善良天性。他与之结合的应该是一个全职的妻子，而不是只尽部分职责的。所以你应该做到每天都活跃、愉快和生机勃勃。

总是愉快——就像那些老式的多丽斯节电影。可毫无疑问有那么多妇女得月经期前综合征！当我想到以 1963 年的这种插页为代表的思想灌输（那年我首次来月经），我简直怀疑我们女人是怎么走到今天这一步的。

月经周期、避孕药和女性的直觉

在月经周期的不同阶段，我们的直觉意识作用不同。停经之后又会再有变化。我的一个同事是位整骨疗法医师，当他为了一名患者(是由于改变了避孕方法而生的病)向我求助时，注意到了直觉意识与月经周期期间的联系。这名患者使用避孕药已有多年，我的医师朋友感到持续地使用避孕药阻碍了她的能力，她本可借此能力了解生命中将会发生的下一步。在他给我的转诊介绍中写着：“避孕药阻碍着直觉功能。意见供参考。”我为这位大夫的洞察力喝彩。

在这样一个时代，由于避孕药的使用，数以百万计的女性的身体，更多地不是与月亮、而是与制药公司相联系，宣传上对众多女性进行高度吹捧的药物作用亟待重新考虑。毕竟，经期间提供给女性的避孕药使得她们的快活的周末永不会遭受破坏，它也经常能起到减少痛经的作用，还可以减少患卵巢癌与子宫内膜癌的风险。不过，没人能保证这样做是否增加了患乳癌的风险，研究确已显示它能增加患子宫颈癌的风险。

劳瑞，我的一位在产科 / 生态学室的同事，在她改变了对避孕药效能的看法之前，已有超过九年的使用历史。她以自己的经验为权威，习惯性地吧避孕药作

为万能药向她所有的病人推广。当她教训病人都应该使用避孕药时，总是以这样一句话结束：“他们永远不能从我这儿把避孕药拿走。”在劳瑞开始看到疾病在自己身上发生的生理反应后，她在精神上对自己关于避孕药的立场进行了重新评估。她观念上突破的部分原因与她丈夫的关系开始恶化有关。围绕性生活的主题，她一直与丈夫有争论。“简直让我发疯了，”她讲，“他似乎要把性关系从我们之间发展着的各种关系中完全独立出来。同时，我自己生理上的混乱、程度不同的不适感、对性生活中发出的噪声及尴尬深感抑制、还有混杂了童年时期对于性和诱惑的潜在意识，这些使性生活充满了对立的内涵，有时成为不可克服的障碍。”

劳瑞认识到，身体不同部分的症状，是部分的内在引导系统显示给我们的。如她所言，她意识到，持续使用避孕药或许会阻止她的生理器官与她本人的最佳联络状态，特别是她自己在性欲方面处于个人危急关头。她清醒地认识到，自己是如何以文化引导替代了内心的引导，不经意地使自己与身体相隔绝。这次清醒伴随了她一生中头一次对女权运动发生的兴趣。她已经非常成功和有效地认识到，过去自己是如何地流于表面化。然而她已经得了良性卵巢囊肿，几年前开了刀，她在产科/生态学室工作期间，又做了甲状腺癌的手术。她正在形成的内在智慧向她显示，这些症状都是试图引起她注意的身体表现方式，让她知道生命中有些东西失去了平衡。现在她很乐意并且是热切地关注着身体的表现，尤其是在她获得了健康以后。

“我感到难过，”劳瑞说，“过去我一直想当然，自我欺骗，或是给我的大脑、激素、子宫及卵巢所做的非凡工作都贴上‘倒霉’的标签。没有人祝贺我的首次月经。没有人帮我与产生于性方面的力量相联系。我渴望重新体验一些失去的魔力和秘密。在我感到能够尝试性地相信自己的身体以前，几乎花了我两年时间去揭开生命的帷幕和掸掉身上的蛛丝。”

经过这两年的个人奋斗之后，劳瑞决定从在大城市里的繁忙的产科事务中脱身出来，休息一年。三个孩子的需要、她的工作，又加上现在这段正在结束的婚姻，使得她精疲力竭。她知道需要去反省自己的生活，制定一些新的方向。她说，

她终于能够付诸实践，摆脱了避孕药，这是一次“庆贺新生和反抗的行动”。对她来说很明显婚姻已经走到了尽头。“自从我不再需要避孕以来，”她评论到，“对我来说，现在是允许自己享受激素奢侈的时候了。所以我丢掉了最后的包袱并且等待。我能相当肯定经过九年的矫形药剂师的指示，我的卵巢一定是完全混乱了，所以我打算耐心地等它恢复。对肿痛、焦躁、狂野的情绪和混乱我都有所准备，没有准备的是那些已经发生的。”

停止服药两星期后，劳瑞与一组妇女坐在一起讲述过去两年来发生的事。她记录下来，“突然，我热泪盈眶，几乎不能说话。我记得那时在想，‘现在这样不奇怪吗？’”她用了一段时间认识到，对于生命进程中的某些变化，她的的确确感到难过。事实上以前在她服用避孕药期间，她也曾向别人讲述过这些变化和感情，讲述时却无论怎样也没有情绪的和生理的反应。后来她发现，对她而言，排卵活动是与增长的感受和表达深层情感的能力相连的。她写道：“在两天多的时间里我都没有意识到，过多的子宫颈粘液(排卵时非常普遍的现象)和感情洪闸的突然开启都是排卵的征候。甚至当我把它们联系在一起时，我仍不能相信自己的身体。‘好吧，’我想，‘我会再等两个星期看一看。’两星期后，果然来月经了——十九年多来，我头一次自发的月经，没有比看到这更让人高兴的了。我感觉仿佛从久已失去的朋友那里获得了一份令人惊奇的礼物。这个身体，我曾在如此长的时间里，用各种方式滥用的身体，突然和我重新对话了，她给我鼓励，让我放心。所有的东西都没有失去。”

除了发现感情对她更为有用之外，劳瑞还发现自己更多地触及了以往总是拒绝的愤怒的情感。她述及在自己月经周期恢复后的极短时间里，“我发现了我的愤怒。我的正当的、炽烈的、狂热的愤怒。当然，像积聚了 20 年的这种压抑感情，我丈夫是不知情地去接受的。我不知道他是否应该全部地接受这种压抑感情——当然并非马上做到。不过当我倾诉出来时，我记得那时想过，‘这太神奇了！这是真正的我。我的激素。我的魔力！’我现在想，假如我一直感受着的那种愤怒能在过去的年头中被提出来，我或许仍会结婚——或者也许会很快离婚，但无论怎样都好过现在这样。失去了那么多自我真是令人痛心”。

劳瑞知道去尊重和关注正发生在身上的事，尽管其中有些是痛苦的。后来她反省到，“自从我了解了，我就希望去有规律地倾听自身内分泌发出的信息。这样教会我哪里仍需引起注意。当我突然流泪了，我知道暂时停下来并去考虑有什么样的情绪工作要做。愤怒来时，我提醒自己把它压抑下去并不是一个好主意。愤怒不发泄会导致疾病。它本应属于我的身体以外。”

劳瑞注意到的另外一件事是她的月经周期与天生的性欲之间的联系。我已经从许多女人那里听到过类似的故事。她告诉我，“每月中排卵前后的几天里，总有这种强烈的欲望在脑海中盘旋。朋友也告诉过我这种情形，但这是令人惊奇的。我还以为在所有这些年里，使用避孕药消除了怀孕的巨大障碍，它一直在帮助我的性生活！”她过去仅在哺乳期使用子宫帽，她还责备自己缺乏性欲是由于使用子宫帽而引起了生理上的混乱。但她现在明白了缺乏性欲更多地与哺乳期的内分泌及精力枯竭有关，而不是由于子宫帽。许多哺乳期的母亲对性交流不感兴趣，因为她们的精力确实被另外一个非常迷人的“人”——新生儿给“吸走了”。性欲会随着婴儿的成长而逐渐得到恢复。

劳瑞记下了另外一个非常普通的变化。停用避孕药后，她的身体想要弥补失去的时间，一段时间里排卵频繁，然后调整到大约每月一次。“当我开始改造自己的周期，”她写道，“它们变得非常短，大约每三星期一次。尽管短暂地闪现于头脑中的念头是，每三个星期中有一个星期要流经血会很疼，我还是意识到这个想法是习惯性的。有多少女人向我抱怨经期变得频繁，恳求我能否为此‘做点儿什么’？现在我想短周期是给予我的礼物，我以它去‘补上’失去的时间。我喜欢经期频繁。我每三周排一次卵。我从自己的身体上学到了更多。它在女性生理上就像一个碰撞的过程——它属于我自己。我开始庆幸能够每三周有一次月经期，我希望绝经期能延迟到 65 岁才出现。允许我自己享受所有这些新的课程，我再次学到，我并不是在控制之下的——我的周期开始延长到三个半星期，随后是四个星期。我想三周的月经周期，这只不过是内在智慧对我的一个测验，它想要看到我是不是真想让身体的这部分功能恢复。我的确做到了。”

怎样纠正对月经期智慧和力量的看法，劳瑞的故事向我们提供了一个例证。虽然避孕药对许多妇女来说一直是便利的，但同时也使她们不能与自身女性智慧的一些最本质部分保持联系。举例来说，当人们之间关系密切时，他们保持联系的一种方式是通过释放外激素。然而，口服避孕药已被显示消除了我们之间部分的外激素联络途径，包括我们与男人之间性的联系。一项研究发现，阴道分泌物中一种称为“交配外激素”的不稳定的脂肪酸，刺激了男性的性兴奋。然而，使用避孕药的妇女不能分泌这种脂肪酸。生活在一起的女人通常周期相同。我的一个朋友将之称为“成为卵巢的姐妹”。这种情形也不会发生在服用避孕药的女性身上。研究显示，与别人关系密切的女性有比较短和更为固定的周期，反之，不合群的女性则更有可能经期不稳定。

痛经

女性中，有 60% 的人受痛经折磨。其中的一些人由于剧烈的疼痛甚至在每月中的一到数天里不能活动。我们文化中的大多数女性受痛经折磨，这个事实清楚地显示，我们没有完全摆正与自己身体的关系。它证明我们已失去了许多与月经智慧的联系。50 年代心理学和妇产科医学的文献中充斥着这样的研究，即认为痛经主要是心理上的作用，它与做一个女人所感到的不快有关。卡罗琳·米斯说，痛经和经期前综合征是一个显著的迹象，说明女性对如何成为一名女人陷入了冲突当中，这包括她在部落中所处的角色以及部落加之于她的期望。这种对于女性的传统期望，放在当前社会，只会令人惊异地使我们中 100% 的人都不会有痛经和经期前综合征。

痛经与经期前综合征不同，尽管女性同样受到二者的折磨。痛经可分成两个部分。主要的痛经不是次要的、骨盆内别的器官的疾病。次要的痛经是由子宫内膜异位或别的骨盆疾病引起的。帮助主要痛经的治疗同样也有益于次要痛经。

我在十多岁时得了主要痛经并一直延续到第一个孩子的降生。由于疼痛，我

有时不得不从学校打电话给妈妈并离开课堂。在医院实习时，由于痛经我甚至不得不从外科病例的主修课请假。同住的伙伴对我说：“噢，克丽丝，你也痛经？看来这并不必然地发生在女人身上！”(还记得吗，我原来一直是“小伙子中的一个”并一直尽全力去保持这个地位。你可以想象当由于可怕的女性虚弱而不得不离开实验室时，那是怎样的一个打击，痛经！)

自 70 年代末开始，研究显示，有痛经反应的妇女在经血中分泌出高含量的前列腺素 F2a 激素。当子宫内膜壁分解，这种激素就被释放到经血中，子宫产生痉挛，结果就是痛经（痛经毕竟不会是在头上——它发生在子宫内！）

当我首次月经时，同时也得了近视，必须配眼镜。我对此非常恼怒——家里没有别人戴眼镜。我的视力问题由于在读书时得不到适当的休息而加剧了。我怀疑我是像一般意义上的那种长大成人，还是特别像女孩子那样的长大成人，这很矛盾，就像妈妈所经历的那样。不断增加的青春期的压力，与每天我吃的食物一起，增加了我血液中肾上腺素(去甲肾上腺素)和前列腺素 F2a 的分泌，结果是严重的痛经。痛经在我的第一个孩子出世后消失了一段时间，但后来又回来了，却已是温和了许多，也不是在每次月经时都出现，这时我的第二个女儿大概已经五岁了。这段没有痛经的时间更使我相信，当我的生命处于平衡状态时，我就不会痛经。当我变得很忙或是压力过大，我会在月经头天有几个小时的痛经反应。这确实使我的节奏慢下来，得到很好的提醒，我需要作些调整了，去与我的身体智慧作更好的协调。

治疗

经精加工的食品缺乏必要的营养成分，不完全氢化脂肪含量高，引起内分泌失衡，并引发许多女性的健康问题。你应该吃什么样的食品作为替代？我对这个问题的答案在本书开始已有论述。

从治疗经期前综合征到绝经的症状，或仅仅说是为了保持健康，我习惯于推荐一种食谱，富含糖分和低脂肪。通常效果不错。但对许多妇女来说，这种饮食规定的方法完全不起作用，尤其在她们已遵照执行了多年之后。比方说，我开始注意到，一份食谱中有益健康的脂肪含量过低，糖分含量过高会引起发质脆弱、指甲易断、缺乏精力、免疫系统衰弱、沮丧，甚至体重增加。我也看到一些妇女没有摄取足够的蛋白质去保持血糖的平衡。在此之上，我的病人和我一直在吃富含糖分的食品，且使我们渴望更为精美的类似食品。我们不会对法式面包、小甜饼或其他餐后甜点敬而远之。

当我开始对此领域做更多的研究，我发现在这方面，我得到了许多人的帮助，其中有理查德博士；瑞切尔·海勒——《令人入迷的含糖饮食与生命的健康》一书的作者；玛丽·丹博士及迈克尔·艾德斯——《蛋白质的力量》一书的作者。高糖低脂的饮食会使相当多的人血液中胰岛素水平过高而胰高血糖素水平过低。已知的二十烷类，就是这种失衡依次影响了类激素化合物之间不可思议的复杂的交感作用。二十烷类包括前列腺素类，它们参与了细胞几乎所有的生化过程。使之更为复杂的是，二十烷类反应受到了来自他人的压力的影响。

因此，平衡二十烷类的饮食是治疗痛经或许多别的健康问题的核心。为了使身体不产生过多的前列腺素 **F2a**(二类二十烷类)并进入前列腺素 **E**(一类二十烷类，这不会造成痛经)，一个女人必须拥有足够的、正确类型的基本脂肪酸。她也需要适当标准的维生素 **C**，维生素 **B6**(吡多醇)和镁。在新陈代谢上，压力大而食物营养匮乏的女性总是会产生过多的前列腺素 **F2a** 并受继之而来的痛经的折磨。

营养治疗

不要吃奶制品，尤其是冰激凌、乡村芝士和酸奶酪。根据我的临床经验，许多妇女在停止食用奶制食品后，诸如经痛、经血过多、胸痛及子宫内膜痛的症状都减轻了。这并非对所有人都同样有效，但值得一试。尽管并不完全清楚为什么

奶制品似乎总与女人的骨盆症状相联系，我还是有一些观点。其中一个可能的解释是，今天奶牛所产的大部分牛奶都经过了牛类生长激素的处理，这种激素过分刺激了奶牛的乳房。这些牛更可能患乳房感染，这样就会需要抗生素。不论激素还是抗生素，残留在牛奶中会以某种方式刺激女性内分泌系统，对此我们仍未完全明了。然而我们确实知道，喂给家畜的抗生素进入到了人类的食物链中。抗生素改变了内分泌的方式，在肠内产生代谢变化，这样就能改变激素的水平。纯天然的奶制品(即在奶牛的食物中不含牛类生长激素，抗生素或杀虫剂)，似乎不会对子宫和乳房组织产生同样的不利影响。许多女性提到当她们改食纯天然奶制品后，症状消失了。吸取那些对你有作用的经验和发现。但要乐于在一段时间里停止食用奶制品，看看你是否能注意到其中一些益处。同时还要确保你能从别的食物中获取钙。

减少食用经精加工的碳水化合物。这些食品比别的食物含有更多的、过量的糖分——尤其那些精致的食物，像小甜饼、蛋糕、油炸土豆条、薄饼干等等——它们能够引发二十烷类不平衡，结果导致痛经。

少吃牛羊肉和鸡蛋蛋黄，每周至多两次，或干脆取消。如果你确实想吃这种肉，那就去食用通过有机饲养的家畜的低脂肉。牛、羊肉和鸡蛋蛋黄中富含花生四烯酸，会导致那些免疫力弱的人二类二十烷类增加和子宫疼痛。并非所有人都对花生四烯酸敏感，所以此项建议不会适用于每一个人；为了发现你是否对花生四烯酸敏感，你可以在三个星期内避免食用这种肉类和蛋黄，然后在一天之内吃上几次，看看以往的症状是否又回来了。这种肉类可能会有很高的脂肪含量，也会增加二类二十烷类的产生——这就是为何你需要食用低脂肉的原因。

摄取基本脂肪酸。 ω -3 脂肪酸以鱼油的方式存在，其中包含廿二碳四烯酸和二十烷戊烯酸，二者已经被发现对痛经的形成作用很大，甚至对那些并未改变她们规定饮食中别的部分的女性也是如此。近期研究建议使用一种配方，其中包括 1000 毫克二十烷戊烯酸，720 毫克廿二碳四烯酸以及 1.5 毫克的维生素 E；你可以使用与之近似的任何数量。由于鱼油暴露在氧气中会引起损耗，使用瓶盖就可

以增加维生素 E(阻止氧化)。另一种更为经济和健康的方式是食用沙丁鱼，通常每周两到三次，鱼要用本身的油或橄榄油包裹。其他的淡水鱼，例如鲭鱼、鲑鱼或旗鱼都是很好的鱼油资源。蓖麻油——每天使用两到三次，用量 500 毫克——同样可被使用，如果鱼油不起作用或者对它的味道难以接受，你也可以购买新鲜的蓖麻子，用咖啡搅拌机研磨，然后加入汤、色拉或谷类食物中。通常每天使用一到两个大汤匙的量就足够了。

服用含多种维生素和矿物质的药片。

每天摄入 100 毫克的维生素 B6。维生素 B6 已被证明能够减少痛经的强度和持续时间。

月经期过程中，每天，每两小时摄入 100 毫克的镁，经期的其余时间里则改为每天三到四次。镁使平滑肌组织得以放松。使用以螯合形式存在的镁。

在整个月经周期过程中，每天三次，每次服用 50 毫克维生素 E。维生素 E 已被证明能够改善痛经。为了符合人体的要求，必须用 d-α 生育酚的形式。

在任何可能的情况下，取消提供转移脂肪酸的食品。这些食物增加了二类二十烷类的产生，与痛经相关。发现含有转移脂肪酸的食物，都包含有部分的氢化油。人造黄油和脱水蔬菜就是例子。要注意检查所有加工好的食物的商标。

药物治疗

你在经期开始时如果服用像爱迪维尔、纽朴林和朋斯特尔之类的非类固醇消炎药，就会起到阻挡前列腺素 F2a 化合的作用，用药要在疼痛开始之前，或开始后的尽可能短的时间里。一旦子宫内膜壁开始脱落，前列腺素 F2a 释放到经血当中，再想去阻止子宫痉挛引起的疼痛就是非常困难的了。

避孕药会取消排卵过程，导致内分泌的变化，故常与痛经相关，但使用避孕药对许多无意改变生活方式和饮食习惯的妇女作用很大。然而，有些妇女甚至在口服避孕药时痛经。更新的避孕药可以被大多数超过 35 岁以上的女性安全地使用，只要她们不抽烟。

精神治疗

减轻压力。

学会欣赏你的月经周期的节律。

女人们的故事

痛经康复者 在上一个冬季，26 岁的简第一次来到我这儿。多年以来，具体地说是从她 13 岁首次月经后不久，简就开始忍受极其痛楚的经期的折磨。她向我描述痛经的出现，是从真正的经期开始之前一直持续到经血停流为止。她很着急，想着也许有什么东西严重地影响了她的生殖器官，比如说像子宫内膜炎或卵巢囊肿。

几年前，简曾经尝试着服用过一个月的避孕药，但她后来停止了，因为她不喜欢那种服药以后的感觉。她也试着用过阿那普罗克斯，一种类似于莫醇的非类固醇的消炎药，莫醇现在已同艾力维一样充斥着药品柜台。这种药对她起了一些效用，但她仍感觉相当不适。除了痛经之外，她还抱怨经血过多(从白天到第二天每小时用一个止血棉垫)，经期前急躁，痤疮，肿胀，乳房易破和经期前阴道发痒。简的两个姐妹，没有一个有痛经或其他妇科疾病。简的食谱，根据日常食物而定，诸如乡村芝士、冰激凌和酸奶酪等，都是她经常吃的。

简是一名小学教师，对工作并不满意。她说她总是想搬到爱达荷州去，又怕这样做伤了父母的心(父母不想她走那么远)，因此而有种负罪感。她的父母认为简只跟着自己的兴趣走是非常自私的。他们只觉得简应该离他们近一点儿，过教书、结婚和育子的稳定生活。简童年时期取悦父母的愿望现在直接与个人发展的需要相冲突。她开始认识到，待在父母身边，忽视个人的需要只会带来自身的疾病。我向她指出，她正处于典型的相互依赖的两难选择状态中，要想获得痊愈，就需要与自己达成协议。除了迎合父母的期望以外，工作中不再感到满足所形成的压力使她极度忧虑。

简做了一次彻底的例行骨盆检查，结果发现没有囊肿、炎症或任何别的生殖疾病的迹象。我向她推荐下述的治疗过程：

每周用蓖麻油抹下腹部两次

停止食用任何奶制品或牛肉、羊肉

每天两到三次服用多种维生素

着手实施移居爱达荷州的计划

阅读一些关于“相互依赖”的读物

三个月以后，简又回到了我的办公室，这时她的痛经已经得到了明显的改善。对于停止食用奶制品和牛、羊肉之后所感到的不同，她深表惊讶。经血过多的症状也有了相当的好转。她认识到自己的饮食确实对痛经影响很大，还说用蓖麻油“感觉棒极了”。在她使用这些方法的同时，她花时间与自身和自身的需要进行协调，并且考虑到生活在外的梦想，这代替了并不适合她的以往的生活模式。关于相互依赖，她读了些书，并开始认识到从童年时期开始她就被训练成为“取悦

别人的人”。她意识到如果想使自己对生活满意，她就必须学会如何“取悦”自己。她已经够大，不适合再在家里做一个乖乖的小女孩了。

三个月后，简的经期变得更为轻松，她已经能相当多地减少阿那普罗克斯的剂量，同时她也改变了饮食，减轻了压力。给人印象最深的是，她制定了移居爱达荷州的计划，也不会在下个学期再到学校去了，她不喜欢那份工作，也不喜欢那个地方。尽管移居到陌生地方的前景使她害怕，同样却也使她感到振奋。如果她没有制订计划去独立于父母，过自己的生活，我相信她的健康会最终由于她的“好心”而承担风险。通过运用身体智慧，简不仅医治了痛经，也医治了自己的生命。

经期前综合征

现代的紊乱指明，我们需要重新考虑对月经的观念，重新开发我们月经周期的智慧，没有什么比经期前综合征这种常见病更能直接反映这一需要的了。诊断过数百个经期前综合征的女子病例后，我想，进行这样一种重新考虑，需要找出经期前综合征的病根。对治疗经期前综合征来说，饮食规律的变化、运动、维生素及黄体酮治疗都是有用的，最初我也正是这样向许多女性进行推荐的。但在经期前综合征的持久病例中，一种更内在的不平衡在于，仅有生活方式的改变不会对病症起到帮助作用。正如研究已证明了的，未能解决的情绪问题也会破坏月经的规律和一般的激素环境。

至少占 60% 的女人受经期前综合征的折磨。这种症状至早发生在青春期，至晚发生于绝经期，但最有可能发生在女人 30 多岁时。古代已经知道有经期前综合征，但对它形成普遍认识是在 80 年代，是通过当时《家庭周期》杂志的一篇文章，此文清楚指明了这一令千百万妇女每月忍受痛苦的病症。这篇文章引起了媒体的关注，在数月之内，经期前综合征成了一个全国性的知名的问题，经期前综合征也成了家喻户晓的词儿。它也成了女权扩张论者的热点话题，她们争论

说这种诊断会被用来反对女性。医生们为此焦急，因为类似这样的诊断可能成为“废纸一堆”。不过同时，多数妇女最终为她们每月遭受一次的痛苦找到了一个名字并开始去寻找医学的帮助。

有意思的是，传统的产科 / 妇科学会议在《家庭周期》的那篇文章传出之前，并未注意经期前综合征这一话题，而在此之后，女人们开始带着自我的诊断去看医生。我们医生对此在许多方面准备不足。因为这并不在我们的训练内容之列。女性所创造的需求，媒体对治疗经期前综合征的呼吁在 80 年代中期就是这样，经期前综合征在许多产科 / 妇科学专业的会议上成为演讲的主题，这方面的研究也上了日程。正像女性自然生育的要求迫使医生们改革产科实践的家长式的步骤，女人们要去理解经期前综合征的愿望也影响了医学的实践，并且帮助它在女性生理方面朝着一种更具启发性的态度前进。

诊断

经期前综合征有很多不同的症状。在诊断过程中，女人经期前所有的特殊症状无关紧要。重要的是它们发生时的周期方式。通过制图反应女映三个月或更长时间的症状，我们会发现图表模式中的规律，并且能够预言这些症状在她们周期内的开始时间。除了非常严重的例子，大多数妇女在每个月中完全解除下列症状之前，至少有一天时间的身体不适。周期的后半部分，许多潜伏的症状加剧了，诸如青光眼、关节炎和情绪沮丧。潜伏症状的加剧并非以经期前综合征的方式表现出来，尽管它与经期前综合征不无关系。有超过 100 种的经期前综合征的知名症状。这些症状中的每一种都兴许与细胞中的二十烷类水平失去平衡有关，是复杂的情绪、身体及遗传等因素相互作用的结果。

经期前综合征的症状

腹部肿胀、浮肿、腹部绞痛、情绪的不稳定、意外倾向、先有症状的加剧、痤疮(关节炎, 溃疡, 敌对心理 狼疮, 等等)、酒精过敏、视觉困难、焦虑、昏晕、哮喘、疲累、背部疼痛、无节制的饮食、乳房肿痛、头痛、挫折感、心悸(心脏的惶惑 连续重击)、身体协调困难、痔疮、沮丧、疱疹、麻疹、(病的)侵袭、失眠、性欲变化、易怒、瘰管症状、关节肿痛、喉咙痛、懒散、腮腺炎、偏头痛、自杀的念头、恶心、嗜糖、狂怒、小便困难、嗜盐、情感冷漠

如果我们对经期前综合征束手无策,它就会变得日甚一日。经期前综合征早期阶段的症状,据有些女性描述,是在经期的头几天出现的,表现为刚一来潮又突然停止。看来这种症状是在月经开始前一到两个星期内逐渐显露的。有些女性在排卵时经历着一连串的症状,接下来的一个星期症状消失——在月经前一个星期症状又复发。随时间的过去,一个女人在一个月当中也许只有两到三天的无症状时间。最终,剩下的日子里,“轻松”的日子和“难受”的日子就没有可以分辨的模式:她感觉自己似乎总是处在经期前综合征当中。

有些妇女把痛经和经期前综合征等同起来,然而,经期前综合征是不同于痛经的。这种不同并不总是清楚地反映为写法上的不同。得经期前综合征的许多女性会有完全无痛的经期。许多严重痛经的女性却没有经期前的痛苦。痛经是由于子宫收缩引起的,是前列腺素 F2a 过度分泌的结果,这种腺素产生于月经周期当中子宫壁的分解。一些研究显示,在经期前综合征的症状当中,也包含有前列腺素的分泌。由于这个原因,规定饮食的变化、维生素和无机物的补充,以及反前列腺素的药物(通常是非类固醇的消炎药,像爱德维尔)的使用,这些对无论痛经或是经期前综合征经常都是有作用的。

尽管一些医生仍在寻找导致经期前综合征的某种“生物化学的机能障碍”,上百种已出版的科学杂志也在讨论这个题目,还是没有人能发现这样一种机能障碍或者是找到一种灵丹妙药去治疗它。一种简化的步骤——寻找化学的“原因”及“治疗”——并不起作用,因为导致经期前综合征的原因是多遗传因子的,必须进行全盘的处理。大脑、情绪、日常饮食、光线、运动、人际关系、遗传及童

年期的伤害，所有这些方面的影响在治疗经期前综合征过程中，必须都被考虑进来。

下列活动导致体内激素的变化。除非治疗及时，否则这些变化容易引起经期前综合征的开始和加剧。

与经期前综合征发作有关的活动

月经开始或者绝经前的头一两年

停止使用避孕药

在一段没有经期的时间后

孩子的降生和孕期的停止

血毒症使怀孕过程复杂化

输卵管结扎(尤其在 70 年代经常做这种手术，单极电烙术使很大一部分输卵管毁坏，这种灼烧输卵管的手术方法已经不再使用了。)

不寻常的创伤，像家人的去世

在秋天和冬天时减弱光亮

研究显示，有经期前综合征的女性倾向于具有下列营养学和生理学的特征。

造成经期前综合征的因素

过多食用乳制品

摄入过多咖啡因、软饮料(咖啡及巧克力中都含有咖啡因。)

精糖食用过多，而新鲜蔬菜等摄入不足。

血液中雌性激素水平相对偏高(产生的原因是由于日常饮食及体内脂肪产生过多的雌性激素，或是由于肝脏对雌性激素的分解较慢。雌性激素过多与维生素 B 类不足有关，尤其是与其中的 B6 和 B12 不足有关。肝脏需要这些维生素去破坏和阻止雌性激素的活动。)

血液中孕激素水平相对偏低。孕激素起着平衡过多的雌性激素的作用，孕激素水平降低的原因可能是孕激素的产生不足或是体内孕激素被分解得过多。这方面的研究还没有得出统一的说法。

造成前列腺素 F2 水平增高的饮食同时也会导致雌性激素水平相对偏高而孕激素水平相对偏低。食用低脂肪、高纤维食物的素食者的脸部比非素食者排出的雌性激素要多两到三倍，她们的血液中的雌性激素水平比食用标准的美国式饮食的妇女要低 50%，结果是她们的经期前综合征发生率大大地减少了。(按：据我们的经验，素食者更倾向食用水果、蔬菜和更少摄入脂肪。有证据表明，肉类并非我们想当然地那样一定是罪魁祸首，只要肉类的消费量适中，并多增加一些绿叶蔬菜、粗粮、水果——只要饮食中不要有太多的精加工、高糖、高脂肪的食物，就不会有太大的问题。)

身体过胖会使雌性激素水平过高的可能性增加，从而使经期前综合征发生率增高。身体脂肪会产生雌素酮(雌性激素的一种)。

维生素 C、E 和硒的水平低。除了 B 类维生素，肝脏也需要这些物质，从而使雌性激素的代谢达到正常水准。

镁不足。食用过多的巧克力会造成体内镁缺乏。肝脏需要镁以及 B 类维生素来使雌性激素的代谢达到正常水准。

月经周期（9）

季节性情感紊乱和经期前综合征：链接的清楚显示

到了秋天，白昼变短，许多有经期前综合征的妇女发现她们的症状也变得更糟。许多与经期前综合征有关的症状正好与所谓的季节性情感紊乱相关的沮丧情绪相同。光线充当了体内的营养素。当它射入视网膜，便经由视丘下部和松果腺影响到了整个神经内分泌的系统。在一项研究中，使用明亮的光线对有经期前综合征的患者进行治疗，她们的反应是值得注意的。在每晚上进行了两个小时的全光谱的亮光治疗后，患者的许多症状，诸如体重增加、沮丧、嗜糖、社交冷漠、疲劳和易怒等都被颠倒了过来。这并不令人惊讶，因为自然光线和对糖分的消耗都能够增加血液中复合胺的含量，它可以缓解沮丧的情绪。而在人工光线下生活时间过长，不能做到定期地暴露于自然光线下，这样虽然可以深深地影响月经周期的规律性，但也带来了经期前综合征的各种症状。

经期前综合征与季节性情感紊乱之间的联系是一个意义深刻的例子，它说明女性的智慧是在季节周期和我们每月的生理周期之间进行同时的编码。P109 图 4 为我们阐明了月亮活动周期的各个阶段是如何与女性月经周期的各个阶段相联系的。在图 6 中，我已经把季节的因素增加到这个图表中，所以你可以清楚地看到，每月经期前综合征最普遍发生的周期、月历上显示的季节性情感紊乱发生的时期，这二者是平行的。在我们每月的生理周期当中，月经期前的时间里，有转向内在的自然倾向，自然界中，一年里的成熟期(秋天)也有转向内在的自然倾向，女性的周期倾向反映在自然界的周期倾向当中。大自然把这种智慧反射给我们。在秋冬天里，树木把它们的能量聚集到根部，在那里，尽管我们看不到，却一直在进行着意义深长的活动并孕育着新生。月经周期中早期的黄体阶段、接下来的

排卵，这是我们聚集能量的时候，我们可以清点存货并准备接受外在成长的下一个周期。我们的文化不理解这种生理周期智慧，我们受到的教育使我们对生理周期内的时间及一年中的季节感到害怕，而这时正是周期智慧需要我们进入到黑暗中，再退出来，去观察我们的生命。

我们受到教育怀疑这些自然的力量——太多的女性把此视为软弱，忽视它，把它搁在一边。我们应该听从自己的生理智慧，而上帝禁止这样做，上帝包办了一切，还是去休息一下吧！

月经周期的下半部分以及秋天是这样的一个时间：这时，潮汐退落了，在海湾泥泞的底部，所有你不愿看到的东西都对你暴露无遗。在每年每月的这些时间里，女性需要去学着注意对她们有用的信息。把这些信息视作混合肥料，一旦春天的阳光重回大地，你要用它去创造新的生长。

治 疗

许多女性被给予的针对经期前综合征症状的疗法，长期以来并不见效。治疗肿胀用利尿剂，治疗头痛用止痛药，治疗焦虑用安定，这些疗法经常会导致药剂本身产生新的副作用，并且首先就忽视了能导致经期前综合征的潜在的不平衡。尽管精神疗法经常被推荐给患经期前综合征的女病人，它也能提供关于压力的洞察力，但此疗法忽视了这种紊乱症状的营养学及生物化学的部分。许多患经期前综合征的女性现在的用药，比如像普罗扎克，增长了血液中复合胺的含量。研究显示，药在经期前综合征的严重病例中，对于减轻症状是很有帮助的。这些药最好仅在周期的黄体阶段低剂量地使用。但假如患者没有认识到经期前综合征是生理上更大的不平衡的部分反映，那么仅使用这些药就不能够帮助一个女患者真正地从经期前综合征中学习和创造健康。

经期前综合征解除的纲要

规定的饮食方法促成二十烷类的平衡。(参看第十七章对痛经的日常饮食建议。)

多种维生素、矿物质的补充。它包括 400 到 800 毫克的镁(镁的不足是经期前综合征中的普遍现象)和最多 50 到 100 毫克的 B 类维生素复合物。所有的女人都应该每月每天依量补充，不仅仅是在经期前才补充。

取消精制糖类、精制面粉产品和转移脂肪酸。

取消咖啡因。据我这些年的观察，最好远离咖啡因。即使每天只喝一杯咖啡或可乐，对一些妇女而言，仍会对经期前综合征造成相当剧烈的影响。

足够的基本脂肪酸。基本脂肪酸存在于未加工的干果、种子、深水鱼(如鲑鱼和沙丁鱼)和许多其他植物当中。芝麻油很棒，向日葵油、红花油和胡桃油也都很好。你也可以进行别的补充，药房和当地的食物店广泛地提供这些。一般说来，每天三到四次补充 500 毫克的鱼油是适量的。亚麻子油也能提供帮助：每天四次共 500 毫克。身体内基本脂肪酸最理想的新陈代谢需要一些元素的适当含量，像镁、维生素 C、锌、维生素 B3 以及维生素 B6。

压力减轻和心理治疗。那些尝试冥想或别的深度放松方法的女性，能够减轻不少经期前综合征的症状。各种放松方法减少了血液中的氢化可的松及肾上腺素的含量，并帮助平衡你的生物化学反应，包括像二十烷类的水平。有无数种冥想的方法能够发挥作用。每个女人都应去选择一种最能沉入进去的冥想方式，并将之合并到日常的生活规律当中。

例如，对于这种放松的反应，赫伯特·本松博士建议每天做两次 10 到 25 分钟的放松活动。这种冥想活动包括：(1) 在一个舒适的地方闭目静坐；(2) 从头至脚，深度放松所有的肌肉；(3) 用鼻子呼吸，并做到有意识地呼吸；(4) 吐气时心里默数“一”。一项研究显示，三个月的这种固定练习会极大地缓解经期

前综合征的各种症状。

反射疗法。这种疗法包括对耳朵上、手上和脚上的穴位进行特殊的按压，它已被证明能够减轻经期前综合征的症状。受过训练的反射疗法工作者通常的疗程需要八周时间，每周一次，每次 30 分钟。在吉尼·布拉姆所著《女性自我疗法》一书中讲到，点穴治疗的完整疗程可以减轻经期前综合征、痛经和子宫内膜炎的症状。

每周三次，每次至少 20 分钟的增氧健身方式的运动。轻捷的步行是非常必要的。这种条件反射的活动减少了许多经期前的症状。它也增加了内啡肽(自然出现的类似吗啡的元素，能够帮助身体处理沮丧情绪及生理疼痛)的含量。据估计，超过半数以上的情绪沮丧的病例可单独通过运动加以治疗。

全光谱的光线治疗。每天晚上和每天早晨接受两个小时的全光谱光线照射(2500 到 10000 勒克斯；勒克斯是一种光照强度的测量单位)，这可以通过自然光或者人工的全光谱光线来源获得。在北欧，阴天时提供了 10000 勒克斯的光照。而在接近赤道的地区，一个阳光明媚的日子能提供 80000 勒克斯。

需要时进行天然孕激素治疗。天然孕激素，结合着生活方式的变化，经常对经期前综合征的症状造成深刻的改善。在作为神经传递素的才能方面，雌性激素和孕激素很明显地影响了情绪。雌性激素，如果没有孕激素相抗，更倾向于刺激神经系统。在另一方面，孕激素，与平静的情绪相关，它是中枢神经系统的弛缓剂。可能，在孕激素对经期前综合征的有利影响中，对中枢神经系统的松弛影响是首要的。

我向那些患不同程度的经期前综合征的女性推荐天然孕激素疗法，她们不能对简单生活方式的变化作出反应；我还向那些女性推荐这种疗法，她们经常把月经前个人身体的变化描述为哲基尔-海德式的。对于那些经期前主要症状是偏头痛的女性，这种疗法也能起到很好的作用。这些头痛症状经常随雌性激素和孕激

素的逐渐变化而开始，并倾向于一直发生到绝经期之前。

天然孕激素与人工合成孕激素不是一回事，一般剂量的天然孕激素不会造成严重的副作用。有时它也许会引起月经中红斑或者延迟月经周期。这种症状通常会在一到两个月内自然消失。过大的剂量——远高于我所推荐的——会在少数病例中，引起欣快症和偶然的头晕眼花的反应。经医生推荐的口服天然孕激素药剂是有效力的，外敷形式的药剂同样有效。要注意，天然孕激素药剂是从野生的墨西哥山药中提炼而成，外敷药则仅含有山药汁，尽管外敷药对一些妇女有帮助，它的作用却比不上那些含有适当数量天然孕激素的药剂。并非所有的药房都有天然孕激素，也不是所有的医生都知道在哪里能买到它。

用外敷药的，你可以从药柜中的一些天然孕激素药膏中选用一种，或者让你的医生从药房中为你推荐一种专门适用于个别情形的药方。多年以来，我一直推荐一种名为普罗杰斯特的含 2% 孕激素的药膏。这些 2% 含量的药膏每盎司中至少含有 400 毫克的天然孕激素。每天一到两次，每次使用四分之一到半茶匙适用于皮肤的药膏，显示在生理学上结果是，孕激素的含量与所发现的普通黄体阶段的含量相匹配。

一般用法说明都讲，早晚两次，把四分之一茶匙的药膏(大约 20 毫克)涂抹于皮肤的柔软区域(乳房、腹部、脖子、脸部、胳膊内侧或者手上)。每次涂抹时轮流选择区域，这样在你的月经周期中从 14 号持续到 18 号，并至少用三个月时间。然而，精确的使用时间和剂量将随不同的女人而变化。在你通常所经历的情绪变化之前，使孕激素进入到你的身体系统中是很重要的。你需要在排卵前的一两天或症状通常开始前的一两天内使用药膏。对一些女人来说，这一天将会是在 21 号；而对另外一些女人来说，是在 12 号或 13 号。这样一直持续到月经来潮的第一天(周期的一号)。这样经常会阻止症状的发生或极大地减弱它们。如果一直等到症状开始出现，那么治疗经常会失去作用。增加或减少剂量要根据症状的严重程度；大多数女人不得不自己去发现对她们起作用的剂量大小。你的周期为你提供了超过两周的时间，这段时间里你可以去安全地使用自然黄体酮，另外，

在每个周期中，你至少得停用 12 个小时。人工合成孕激素，与天然孕激素相反，有许多大家熟知的副作用，诸如肿胀、头痛及体重增加。不幸的是，许多女性被告知，人工合成孕激素与天然孕激素是一样的。但人工合成孕激素确实能够增加经期前综合征的症状，因为服用人工合成孕激素减少了身体自行产生的孕激素的含量。

在控制体内孕激素方面做得好的女性，通常也就是那些经历了快速情绪变化的女性，这种情绪变化在排卵后开始，正好在月经开始来潮时结束。她们描述说，开始感觉不错，但随后在数小时之内就有“阴云”笼罩在头顶。当经期开始时，她们又感到“露出了一线光明。”这些女性正在描述在她们的身体头脑中一种非常真实的生理化学变化，这并不仅仅是“在观念中”。

雌性激素、孕激素和别的激素之间可能有的不平衡，使得经期前综合征似乎成了一种动态的、变化的现象，当前已经存在的实验结果还不能够对此加以证明。微妙的激素失衡同样联系着经期不规律或情绪的压力。经常导致无卵性的周期（此周期中一个卵都未排出），这都是不适度的孕激素表现出来的特征。

随着时间的转移，使用天然孕激素能帮助重新平衡雌性激素与孕激素之间的比例。在每个周期中，使用天然孕激素都会产生对于症状的逐渐改进。随时间过去，一旦症状能得以完全减轻，许多女性就能够减少她们服用的剂量（天然孕激素有许多有益的影响，即使在经期前综合征的症状消失后，一些女性也许还想继续服用它们）。然而，如果你开始服用时剂量很大，最后回到一般的剂量，并继续使用几个月，那么它就会更有效力。

最终，当经期前综合征治愈后，女人会乐于看到情绪的发泄，她们最终能够不借助外界刺激而改变内在的激素状况。治疗我们情绪和心理压力的过程导致了生理上的生物化学变化。

月经周期（10）

格温多林：转变了经期前情绪激动 格温多林第一次来我这儿时 36 岁。她又高又瘦，带点儿戏剧色彩，发音清晰并有很强的幽默感，但她的经期前综合征如此严重以至于她会习惯性地突发情绪激动并变得狂躁。在这样一个精力充沛的经期前狂躁阶段，她可以整晚不睡去粉刷厨房，然后，不经过任何休整，投入到一整天的工作中去。然而，接下来的几天里，沮丧和疲劳甚至让她起不了床。她的家庭对此非常关注，她的行为甚至使家人考虑要把孩子从她身边带走，他们还打电话向我寻找建议。她的经期前综合征和严重的情绪摇摆早在十多岁时就开始了，还经常伴随着把她带入危险情况的自我破坏行为。其中有一次，她遭到了轮奸。另外一次，她怀孕了，后来做了人工流产。由于格温多林症状的严重性，我首先对她进行了大剂量服用孕激素的治疗。尽管格温多林已被这种生命中的失衡困扰多时，最终，她还是治愈了她的经期前综合征。

恢复以后，格温多林告诉我，“在我经期前的时间里，每一份愤怒、苦难和被出卖的感觉爆发了出来——这种爆发是如此强烈，使我对于保持婚姻，照看患孤独症的大女儿和另外两个更小的孩子变得越来越困难。”

到她第一次找我时，格温多林已经离婚，她作定期的默想，吃全营养、有益长寿的饮食，这在某种程度上对她起到了帮助作用。她经常做运动，进行适当的食物补充。这些饮食及生活方式上的调整对治疗轻微的经期前综合征的症状是足够了。然而，尽管有这些调整，她仍然每月经历一次情感的地狱。她在生命中有如此多未完成的情绪问题，经期前生理智慧要求她更深入地探索生命中的不平衡。

到开始进行孕激素治疗时，格温多林生命里很多方面都已失去了控制。她开始看到每月经期前经历的情绪碰撞正迫使她揭开生命里每一层的自我克制。回顾过去，她开始意识到这个过程对她的治疗是最根本的。她治疗中的一个特点是加入了所谓性爱沉溺起因不明的十二步疗程。她认识到过去她总是从一种虐待的关系转到另一种，从未发现过“相配”的男人，无论与谁在一起总是感到困扰。当

她艺术家的男朋友表示要终结两人的关系时，格温多林正处于经期前，她情绪突然发作，在一种混合着惊讶和恐惧的复仇感中，她对他进行身体殴打。她意识到自己有典型的人际关系问题，便到社会上的咨询服务机构那里去探究和治疗虐待的问题。她了解到性爱沉溺常常是童年时期受性虐待的结果，于是开始把早期受性虐待、强奸与当前的自我破坏行为联系起来。她开始了解到自己的经期前狂躁就像是那些没治愈的孩子中的一个，现在她是成人了，要处理这些不成熟的孩子气。同时，她还持续做默想、运动、按规定饮食、向专家咨询及参加十二步疗法的集会。

通过对身体提供天然孕激素、好的营养及固定默想的深度放松等各种支持，格温多林发展了她的内在力量，这种力量对于“处理所有不得不爆发的和清除自己的身体”是非常必要的。在她到我办公室就诊期间，不管她感觉如何糟糕，我都不断提醒她去体验那些正经历的感受，愤怒和狂躁没有关系，它们不过是治疗过程中很自然的部分。她需要去感受自己的愤怒，必要时甚至可以重重地击打一个枕头。与攻击别人来发泄愤怒不同，她需要将愤怒作为一种消息来加以重视，因为这种情绪向她传递了她所需知道的东西。随着治疗过程的延续，她发现在月经期前的狂躁和愤怒之下，智慧和真实正等她去发掘。通过感觉和体验愤怒情绪，她发现了从受虐待中留下的眼泪及自暴自弃的深刻感受。“自暴自弃的感觉有时是无法抗拒的，”她告诉我，“但如果我容许这种痛苦进入内心，最终，我会振作而变得坚强。”

经过九个月的孕激素治疗后，格温多林能够减少她的使用剂量。“在一个月当中我仅持续服用两天孕激素，这还是由于轻微的不稳定症状，”她说，“偶尔我还会情绪发作，但现在不同的是由于我知道它们产生的原因，所以能够很好地处理它。我相信当一个女人得了经期前综合征，情绪、生理及精神上的所有感受都需要去处理，这样一个人才会再次有完整的感受。”

两年过去了，通过学习信任和转移她的狂躁情绪，格温多林头一回听从和理解了她的月经智慧。近来我与她谈话时，发觉她比以前做得更好了。她说如果她

只能用一个词来描述自己生命的话，那就是“被授权的”。她正在照顾老问题，向那些她曾伤害过的人赔偿，对那些伤害过她的人，她告诉他们实情。她很兴奋，“我与生俱来的天分正在表现出来：我的声音、音乐和艺术，我相信我们都有这些天分。但对于许多值得做的事情，我们并未去感受。”她写道，“当我完全愤怒时，我给自己找个安静地方，进入内心，问我自己，‘你害怕什么，你正想逃避什么样的痛拔？’我几乎总是能得到答案，然后加以处理。”

经期前综合征和相互依赖

经期前综合征与在一个酗酒者的家庭（父母或祖父母是酗酒者）中成长，二者之间有很强的相关性。经期前综合征与出卖自己去迎合别人的需求——沉溺于对他人的依赖——有着密切的联系。在许多男人有酗酒倾向的家庭中，女性更易多发经期前综合征。酗酒者的子女有 40% 的机会成为酗酒者，不是由于在这方面遗传有易患病的体质，而是由于他们认识到酒精是麻醉感情的方法。酗酒的行为经常被传递给他们，连同遗传使他们也倾向于酗酒。在有酗酒倾向家庭中的女性，或是有酗酒伴侣的女性多发经期前综合征，其结果是感情麻木。我对无数妇女进行过治疗，她们都决心打破家庭中一代代女人经历的经期前综合征的链条。（低血糖症和结果导致的嗜糖倾向，对那些有酗酒倾向家庭中患经期前综合征的女性来说也是非常普遍的。这种情形会在月经之前变得更糟，可以用我已经提及的规定饮食的推荐来加以治疗。）

莱思莉是一位 49 岁的家庭主妇，以前是教师，患有经期前综合征，她带着严重的经期前情绪不稳、嗜糖和疲劳到我这儿来就诊。当我查看她的个人历史，我注意到她丈夫是个酗酒者，她厌恶教学的工作。她有酗酒的母亲和姐姐，她从未处理过任何一些这样的家庭问题。她头次来的时候，我劝告她在月经周期时注意身体的营养和运动，并强调除非她乐于看到正传递给她的关于自己家庭情况的信息，否则将不会“治愈”她的经期前不适。她不打算听从我的劝告，此后几年也再没来过。

然而，七年后，莱思莉安排了一次会面。她告诉我，“1985 年我来这儿就医，你说我需要检验我的相互依赖，还有经期前综合征，要减少与之相关的精力投入。我走后一直在想，‘诺斯拉普博士是个好女人，但她不知道自己在说什么，事实上我想她真是疯了。共同依赖怎么可能与经期前综合征有关系呢？’但现在我认识到我生活中一直发生着的事与我的经期前综合征有联系。我认识到这些年来，丈夫一直在对我进行语言虐待。我正在离婚之中，我现在看到过去我完全‘自我分离’了自己。”

莱思莉告诉我她已经加入了十二步疗法小组，正在捡回生命中失去的片断，并在了解这么多年来与语言虐待及酗酒者相伴所带来的影响。莱思莉的情感不再麻木。她变回了她自己，并正在决定对于她家人的行为，她将接受什么和不接受什么。大多数时间里，她没有了经期前综合征的症状，但一经出现，她就会关注，并慢下来，在生活中作适当的调整，以使自己的需要得以满足。

不规律的经期

在几乎 20 年的医学经历后，对于月经周期或经血与生活内容非常清楚地相关这一事实，我仍然感到惊讶。不寻常的子宫出血几乎总是与某些方面的家庭问题相关。正如卡罗琳·米斯所说，经血现象是家庭现象——几乎总是。一个女人告诉我她有两个姐姐，住在不同的地区，却在同一个月内跳过了经期，而同时四个姐姐流产了，她们直到再次重聚时谈起来才意识到了这件事。我的一位患者，55 岁，她最后一次月经期是在 52 岁，经历了一次典型的绝经，这在热反射和实验室测试证实为“更年期”，不过就在她母亲去世后她又来了一次完全正常的经期。当绝经期妇女发生绝经后出血现象，我总是问她或她的家庭怎么了。她们也总是会告诉我在经血出现之前有情绪性的典型家庭事件。

月经血，尤其当它不按时间表来时，是一种信息。它带来某种智慧。米斯指出大多数经血问题源于我们生理系统的不平衡：情绪过多而没有足够的精神上、

智力上的精力去平衡它。它记录着，一个女人内在混乱的信号是从家庭或社会而来的，家庭和社会对其性兴趣和性需要的看法加剧了她的经血活动异常。多数开业医生已经看到精神所能带给月经周期的深刻影响。1949年，S 祖克门认识到情绪的干扰会扰乱月经节律、加快子宫出血，也影响了排卵时间。连接大脑和卵巢的神经传播网络(称为神经节前的植物性神经系统途径)也许做了情绪和子宫及卵巢功能之间进行联系的媒介。

什么是规律的经期

在我详细考察关于不规律月经周期的主题以前，有必要解释一下什么是正常的周期。女人有时被教导说，如果她们的月经不发生在每次周期的第 28 天，就是不规律的。我考虑周期规律是指月经粗略发生的时间，大概在每次周期的第 24 天到 35 天。像时钟机构一样，每次月经都发生在第 28 天，这是对一些女性而言，并非对全体女性而言。成千上万的女人并不属于每次第 28 天的模式，给人印象好像她们的经期是不规律的，其实她们是完全正常的。经期的规律取决于大脑(视丘下部、垂体腺和颞突)、卵巢和子宫之间复杂的相互作用。周期模式会随许多因素的变化而改变化，包括像季节、光照条件、食物或旅行，或有家庭压力的时间。不规律的或不排卵的周期常与过早的骨质流失相关。经常地，女人能说出什么时候排卵，因为从她们上次月经周期开始的头一天到此次排卵大约需要 12 到 16 天时间。有时戏称之为“肥土流失”，其浓度如同蛋白一样。(在第十一章中有更多细节讨论。) 女人排卵的周期也表现出所谓月经前违和特征。违和是由体内正常周期激素改变导致的一组“症状”。包括轻微的月经前体液重新分配，经常的感觉是“肿胀”，或是轻微的乳房疼痛，或是轻微的下腹部疼痛，与之相关的情绪的变化也是更趋于深思的，较少活跃情形。不排卵的女人通常没有这些变化，她们会在毫无预期的情况下，“突发”月经。不排卵的周期倾向于更加不规律。

子宫壁过度生长（子宫内膜增生，囊肿和腺瘤增生）

在一些经期不规律的女性那儿，子宫内的活组织切片检查（子宫内膜切片检查）揭示出一种情形，正常的子宫壁已经被一种过度生长的腺组织所取代。在显微镜下，子宫内膜腺看上去似乎互相堆在顶部，过密地挤塞在一起。这种过度生长是由于缺乏了孕激素的平衡作用，使得雌性激素对子宫壁产生了过度刺激。这就是所知的子宫内膜中囊肿和腺瘤增生（意思是腺过多）。（不能与子宫内膜炎相混淆，对子宫内膜炎我们将在第六章详细讨论。）当一个女人的卵巢经常不排卵，增生就会出现。由激素引起的一致增厚，然后是子宫壁（子宫内膜）的脱落与规律的排卵相关，作为替代，子宫内膜从同步中获得。子宫壁的一些部分“觉得”这是第七天，同时另外的部分却“觉得”这是第 28 天。这导致不规律的和间歇性的经期出血。

囊肿和腺瘤增生或是简单的子宫内膜增生并不被认为是危险的，除非在子宫壁的活组织切片上出现了不正常的细胞。在活组织切片上发现一些简单的子宫内膜增生是相当普通的，如果仅发生一两次就不必引起警惕。许多女人在 40 多岁或 50 岁时，她们的卵巢正经历着通向绝经的变化，会时不时地跳过一次排卵期。当女人的经期变得不规律，她并不一定需要做一次子宫活组织切片，当然这个决定的做出要根据具体情况，根据她的个人历史和检查中的发现。

治 疗

请注意，无论从哪方面来说，我将讨论的疗法在美国是最普遍被提及的。这些疗法并不处理潜在的症状问题。潜在的问题和女人从中所能学到的，将在本章末的个人故事中论述。许多简单的子宫内膜增生病例自行消失了。然而，在有此情形的极小比例的女性中，她们的活组织切片检查发现有非典型的细胞。子宫内膜增生需要被监督，然后又要确定它是在逐渐消失而不是逐渐增长。患有多年慢性停止排卵症的女性在统计数字上，确实有子宫癌的较高发病率。妇科医生受训

把每个患者当做有潜在癌症风险的人来对待。因此对子宫内膜增生开始的常规治疗包括提供人工合成孕激素，诸如醋甲孕酮或阿甲斯汀，患者服用三个月后，重复做子宫内膜切片确认，情况已经消失了。为了这个目的，我经常使用孕激素。尤其是用在那些使用人工合成孕激素会产生副作用的妇女身上。医生们对药的用量和用药期的长短方面分歧很大。开孕激素药剂有时被称为“医学 D&C”（子宫壁的膨胀和刮除术），因为它立刻引起了整体方式上的子宫内膜壁抛除，并帮助子宫消除组织积聚。在另一方面，天然孕激素能起到对雌性激素受体进行降低控制的作用，意味着它减少了细胞对雌性激素的敏感性；这经常能消除良性的子宫内膜增生。

患持久性子宫内膜增生的一些妇女对使用孕激素治疗没有反应，这也许需要在手术室中做一次外科的膨胀和刮除手术。在极少的实例中，如果症状不消失或者进一步产生不正常细胞的话，那么她们需要进行子宫切除。

功能性子宫出血

并不仅是偶然地跳过月经期，经期之间经常性地出血或经期之间出现斑点，这些现象即所谓的功能性子宫出血。做过剖腹产手术的女性也许会偶尔出现不正常的经血方式，这是由于子宫创伤引起子宫壁分裂而造成的。许多非正常方式起因于下丘脑，意味着它们与大脑、卵巢和子宫之间复杂的相互作用有关。严重的焦虑和沮丧改变了大脑中神经传递素的含量并能影响下丘脑的功能。功能性的子宫出血经常联系着无卵性的周期和相对孕激素而言的雌性激素过多。尽管我受过训练去寻找能引起月经异常性的内分泌异常（比如甲状腺问题或者垂体问题），通过血液测试和身体检查我还是很少发现有哪儿不对。因为功能性子宫出血也会与垂体瘤引起的高泌乳刺激素含量有关，我也总是为这种激素安排一次血液测试。

对功能性子宫出血的诊断应该根据个人历史，检查垂体和甲状腺含量的血液测试，或者从子宫内活组织切片检查中看是否子宫壁显示出停止排卵或不正常细

胞的信号。

传统疗法

对功能性子宫出血的传统疗法包括给予像避孕药这样的激素来使其经期规律化。这种一般疗法现在甚至也向处于绝经期间不抽烟的女性提供。(过去，避孕药不向超过 35 岁的妇女进行推荐，但现在这个标准已经不同了，因为避孕药中激素的剂量较低，更近的研究显示它们对年纪较大的妇女是安全的。)避孕药确实导致每个月可靠的经期，对那些生活繁忙无力改变环境的女性来说，服用它们也许是第一选择。但避孕药不治疗任何病——它们仅仅是简单地遮掩了身体内潜在的问题，或者在一段时间内“催眠”了体内的不平衡。不过，像大多数妇科医生一样，我给许多妇女开避孕药，既为避孕也为功能性子宫出血，因为服用避孕药对女人来说是消除症状的最容易的方式，无需为了病症对生活中各方面加以改变。

从统计上看，有功能性子宫出血的妇女在 40 岁或年纪更大时要冒子宫内膜增生的更大风险，大多数医生在激素疗法开始前会做一次子宫内膜的活组织切片。人工合成孕激素是经常受选择的疗法，它既能消除已出现的增生又能停止不正常的经血。在相同的意图上，我经常使用天然孕激素。如果一个女人正在隔过月经周期并想怀孕，有一种常开的促进生育的药剂——克罗米德，会诱使大脑和卵巢进入排卵时期。

有功能性子宫出血的一小部分妇女身体超重。她们排卵不规律，部分原因是体内脂肪产生了太多的雌性激素。雌性激素过度刺激子宫壁并能造成排卵停止。这些女人有时得一种叫多囊的卵巢综合征，她们的卵巢发展着一种变厚的外壁，使许多东西难以释放，部分地刺激了卵形成囊肿。在超声波监测下，卵巢有扩大的趋向，内部有多种小囊肿。研究显示，身体超重的女性与身体适中的女性相比，患月经不规律的比率是后者的二到三倍。能减少过多身体脂肪的规定饮食变化能

够帮助降低雌性激素水平。

持续的压力，经精加工而缺乏必要营养成分的食物以及缺乏自然光线的照射都会导致功能性子宫出血。在我的许多患机能障碍性子宫出血的病人中，仅通过生活方式及规定饮食的变化就可起到帮助作用。有一些则是在激素治疗外加上这两种改变。

德伯拉赫：冲破家庭的约束 德伯拉赫离家上大学时 17 岁。她把自己的家庭描述为“较低的中产阶级，并不赞同大学教育”。事实上，德伯拉赫是家里除了结婚的理由以外，离开家庭的第一个人。她的家庭不支持她在外面生活，他们想让她在每个周末都回来。

大学生活的头一年，德伯拉赫遇到了许多有趣的和让她激动的人，一个智力挑战和经历可能性的全新世界正开始向她敞开。她很幸福，感觉比生命中任何其他时候都要更加充实。不幸的是，她母亲，由于害怕将会失去德伯拉赫，开始每晚给她打电话，告诉德伯拉赫如果她继续待在大学里，她就会是失败的，什么事都不可能做成。她威胁说要打电话给校长，废除德伯拉赫的奖学金，使她没有别的选择，只好回家。

德伯拉赫变得沮丧，初潮以来头一次出现了月经期的不规律。它们一个月里来两到三次，或是在两三个月内一次都不来。为了使自己感觉好一点儿，她开始跑步这种锻炼形式。开始，她感觉身体更强壮了，更独立，更能控制自己的身体。但运动对经期不规律并无帮助。事实上，还造成了长时间的停经(根本没有经期)。她去看妇科医生，医生告诉她，骨盆检查完全正常。她问题的症结，那位医生说，是由于她“与太多小伙子逢场作戏”。德伯拉赫在这段时间里并未与任何男人搅在一起，她没能从这位医生那儿得到帮助，并在接下来的 11 年里避开妇科医生。

然而，德伯拉赫与一位针灸大夫接触了，这位大夫除了针灸外还给她开中药。这些治疗帮助她在两个月内控制了经期，但她发现一停止针灸和中药治疗，她的

经期就又回到了原来的不正常模式，她还发现必须去对付自己沮丧情绪的根源，因为一次受伤使她不得不停止跑步后，沮丧情绪又回来了。她开始意识到自己与母亲间的关系是问题的症结，为了打破母亲对她生活的控制，最终，她离开了本州。

我第一次见到德伯拉赫时，她已经从运动瘾和与母亲的关系中恢复过来了。她开始心理治疗，暴露这些问题。为了解决她的问题，我向她推荐了许多治疗方式，包括营养全面的饮食、天然孕激素药膏及对钙-镁的补充。6个月后，她的经期变规律了，每次28天到29天，她也不再沮丧了。她上完了大学，近来正在完成她的哲学博士学位。她已经冲破了原来的家庭约束，这是她问题的根源，现在她的生活在各方面都变得平衡了。

多娜：功能障碍的家庭与功能障碍的月经出血 多娜，一位有六个月不规律的经期历史到我这儿来——持续两周的经血，然后六个星期毫无动静，然后出现几天的斑点，诸如此类。她也有一阵持续三个星期的严重焦虑和情绪沮丧，正好发生在经期不规律开始的时间里。子宫内膜的活组织切片检查显示出囊肿和腺瘤增生，这是与停止排卵相关的不正常现象。多娜的母亲在40多岁时也经历过不正常的经期和情绪摇摆，但她认为这全是内分泌的原因，她只打算顺其自然。多娜相当肯定她母亲与父亲之间有未解决的问题，因为多娜记得当她还是个孩子的时候，她的祖父令人害怕，很难接近。

多娜告诉我，她过去经常做一些梦，还经常有种念头是关于被叔叔性虐待。“我很害怕，如果我告诉别人发生了什么或者我认为会发生的什么，上帝会帮我的，”她告诉我，“我能迫使自己更迅速地对付这种念头吗？”像许多别的女人一样，她有一种其实很少会发生的错觉——谁，什么，在哪里和什么时间——这将帮她一次性地对付不适感并继续自己的生活，长久的生活。但这不是治疗我们生活的方式。我们不得不让治疗以其自身的方式，轻轻地、逐渐地、恭敬地对待我们。

多娜的教养使她以为：“生活中的一切都是我的错。我一直在想我一定是疯了并一定是虚构了这种念头。”我安慰她说，在我们的文化中，几个世纪以来女人一直因说了实话而被贴上疯狂的标签，她正经历的事是相当普通的，这只会是她个人历史中的一段。她打算为乱伦残存者的团体做些工作，去帮助她突破自己和家庭的否定态度。经过几个月的工作之后，她做了另外一次子宫内膜的活组织切片检查——为了检查不正常的细胞——结果是完全正常，垂体激素分泌也正常。她的经期逐渐变得有规律了。

处理情感创伤确实是“治愈”了多娜的月经周期问题。她的月经期，通过表现不规律性，联系着她身体的智慧。她的经血转移了她的注意力，使她意识到需要治疗的是她与她的家庭(她的血统)之间的关系。

达拉尼：从初潮以来经期的不规律 达拉尼是位教师，作为患者我第一次见到她时，她 30 岁。她结婚了，没有孩子，从青春期以来，就长期患功能性子宫出血。她经历过长时间的无经期，接下来经血能一次持续一个月，然后是罕见的红斑。达拉尼正有情绪焦虑问题，如果离开房子时间过长会毫无理由地感觉恐慌。她的婚姻对她而言与其说舒服，不如说是无幸福可言的。她总是焦急、失眠和头痛。

达拉尼的教养是强制性的。她父亲和至少一位祖父是酗酒者——尽管，她说，有许多家庭否认这一点。她母亲，母亲的祖母，她的堂姐有经血不规律的终生问题，这导致了子宫切除。她的姨母和别的堂姐有卵巢癌，也做了子宫切除。

达拉尼最初到我办公室是为了做生育力的检查。由于她的月经血方式，我们做了子宫内膜活组织的切片，结果显示子宫内膜增生。为了治疗，给她开了大剂量的人工合成孕激素。然而，与大多数妇女在这种治疗上表现的相反，她的经血并未停止。孕激素治疗后重做的切片再次显示出囊肿和腺瘤增生。下一步将是外科手术的膨胀和刮除以确定她没有患子宫癌。

但达拉尼害怕这个程序并恳求我作另外的选择。由于她的强烈反应，我妥协了并向她推荐蓖麻油疗法去帮助恢复她的免疫系统，这种疗法施行于下腹部，一周要做三到四次。我知道这将给她机会对症状做每周至少三次的反射，其间出现的一些信息也许会对她有效力。我们达成协议如果这仍不能改变她的细胞，我们将去做膨胀和刮除的手术。

两周后，我做了另外一次子宫内膜活组织切片检查。受检查的组织是正常的子宫内膜，检查时间正和她月经周期的第一个阶段相一致。达拉尼对症状的免除狂喜并痛哭失声。然后她就开始有了完全正常的经期。接下来的几个月里她的经期也是正常的，并保持了下去。这些月来她通过生物反馈改变了生物化学，进行这种反馈的实践是为了治疗失眠、头痛和强烈的情绪焦虑等症状。认识到婚姻对她来说并不健康，她与自己的丈夫分开，开始办离婚手续，她还沉浸在一个性需求获得满足的恋爱事件当中，这被证明对她的治疗非常有好处。三年后，当达拉尼来进行年度检查，她告诉我她正围绕月经周期发展一种有力的感觉，这对她来说既新鲜又非常使人激动。“我的乳房变大了，”她说，“我感到强大，我走来走去好像自己知道了宇宙的秘密。我想我的家庭多年来一直很害怕我的力量。我甚至能够记起当我还是个小女孩时就感觉到它。尽管现在感觉这种力量是新鲜的，但似乎我认识它又已经很久了。”达拉尼已经找回了她与完整的女性及性方面的联系。通过这样做，她打破了家族中经血不规律这种代代相传的症状。

严重的经期(经血过多)

一些女性在经期经血特别多以至于经常一次就得用了一两个止血棉球和衬垫。她们的经血甚至会渗透到衣服上。一些女人由于经期之间经血太多都不能离开她们的房子。我的一位患者，从事室内装潢业，在到欧洲进行的两次不同的商务旅程中，经血透过衣服渗入到飞机座位上，她后来决定做子宫切除。这种严重的经期出血称为月经过多。患月经过多的女性经期有固定的时间间隔，但经血过多。随时间过去，如果不能从食物中吸收足够的铁或者身体不能补充每月中失去

的血，月经过多就可导致贫血（红血球含量低）。纤维瘤、子宫内膜炎和腺瘤炎都能引起月经过多。但月经过多却很少与甲状腺问题有关。有些女人经血过多的原因不明。

慢性月经过多可能与第二人体精神力量中心所受的慢性压力有关，第二人体精神力量中心包括创造性、社会关系，金钱和对别人的控制。我的一个病人有时记录下她的严重月经过多，当经期变得严重时，她会感到难过并需要哭泣。“当我像那样出血时，”她说，“我忍受生命中的痛苦，我觉得好像身体中的一部分也正在为所失去的而哭泣。”当她花时间去关注正在发生的不同问题，让自己去感受失望和痛苦，她的经期就会是正常的了。另外一个病人，每月有痛经反应，经血流出很多，她开始想子宫疼痛与自己生命中创造新天地的强烈需求有关。她开始每天留出一个小时搞雕塑。每次她这样做，就会有一种完全为了自己的愉快而创造的喜悦，每个月她的骨盆疼痛和经血过多也会逐渐地减少。腺瘤炎——引起疼痛和月经过多的一般原因——是腺通常仅生长在子宫壁（子宫内膜）上的一种情形，生长在子宫壁更深入的地方。（有时称为“内在的子宫内膜炎”，腺瘤炎经常连同纤维瘤或子宫内膜炎一起出现，但也不总是这样。）这种情形可导致在每个月经周期血液流入子宫壁内。子宫壁成为海绵并充血，并使得一般子宫肌不能正常收缩去减少出血。

腺瘤炎的诊断通常从女性的个人历史或从骨盆检查中沼泽般感觉的子宫特征而来。然而，要下最后的诊断，只能通过磁性共振成像或子宫壁的活组织切片，这需要像外科手术般的承担移动一片子宫或整个子宫的任务。

治 疗

至于这部分提到的所有情形，像改变身体周围的电磁场形态，释放骨盆中的能量会对月经过多产生有利的影响。

饮食的改变。无论女性的经期过多出血是否由腺瘤炎引起，她也会对日常饮食做出反应，规定饮食能帮助平衡她的二十烷类，减轻过多胰岛素的影响，并减少过度的循环雌性激素。

补充。对严重的月经期，尤其在接近绝经期时，每天试服用下列药剂：维生素 E，100 到 400 国际单位，维生素 A，5000 到 10000 国际单位。维生素 A 似乎能帮助控制过度的雌激素含量；维生素 E 防止过多血液凝块并帮助保持更为正常的流动。如果限制在三个月内使用，可提供每天高达 100000 国际单位的维生素 A——除非有毒性的风险。(尽管 5000 到 10000 国际单位的维生素 A 是在安全线内的，但如果你想怀孕就不要用它。)含有维生素 P 的维生素 C(每天 500 毫克)及维生素 A 也显示能够减少经血的流失。我也推荐效果很好的多种维生素矿物质，各种维生素之间适度比例的含量使之趋向于互相促进的作用。取消至少三个月传统生产的日常食物(即使是低脂肪的那类)也能起到帮助作用。

药物治疗。月经过多的女性，有的对规定饮食改变没有反应，有的宁愿进行别的治疗选择，对她们来说，人工合成孕激素能够使经血得到控制。我通常的诊断是在每个月经周期的最后两个星期，每天服用 5 到 10 毫克的醋甲孕酮或阿甲斯汀。避孕药在许多病例中也能发挥很好的作用。天然孕激素，无论外敷或口服，都可使用。剂量可根据问题的严重情形而定：口服孕激素，对于最严重的病例，我推荐每天四次共 100 毫克，轻微的病例每天两次共 50 毫克，从周期内的第 14 天到 28 天中服用。对于孕激素药膏(400 毫克 / 盎司)，我建议每天两次用半茶匙涂抹于皮肤的柔软区域——乳房、脖子、脸、腹部、大腿内侧、胳膊内侧或手上。跟着第十七章所列规定饮食的做法，经常能随时间的过去而减少或取消对孕激素的需要。许多女性成年累月地使用这种疗法，以之取代了进行子宫切除的选择。前列腺素抑制剂，比如布洛芬，或萘普生钙酸，也能帮助一些女性减少经期出血。这些药最好是在月经期前三到四天内服用，每天一两次，并持续到经期中通常是最严重的那一天。

外科治疗。子宫内膜切除——对子宫壁的灼烧——是对那些有严重经期出血

的妇女进行的外科治疗，月经过多已使她们对别的疗法失去反应。这种选择能有效地控制超过 85% 以上的月经过多病例。在医院里，对门诊病人进行子宫内膜切除需整夜时间。女人在选择这个手术之前，必须事先仔细观察以确定病情可能做出的反应，因为它并非对所有女人都适用。子宫切除也是一个选择。

康复我们的月经期：为女儿做准备

许多女人，正如你在本章中所读到的，已经转变了对她们痛苦的月经经历的看法，开始要求收回她们正当的遗产：她们身体的和月经的智慧。正如一个女人所做的，她把更为积极的生理想象与身体之间关系的看法传给了下一代。

很长时间内，年轻姑娘仅是根据性关系或不经心地导致怀孕的可能性来接受月经周期知识的。大多数女孩并没有从心理上完全理解她们的女性性特征，除非她们能够知道和理解自己的子宫、输卵管、卵巢以及周期性月经本质等的作用。收回月经智慧包括女人正在预想的一种新的和更积极的方式，这种方式是对我们自己、我们的女儿和家里的男人思考并谈论我们的月经经验。它包括在女性性特征方面的自我教育及教育别人。我们中许多女人的丈夫都声言对女儿的青春期的感到不安。父亲们似乎持有一种旧的和未经检查的感觉，认为他们应该从别的男人或男孩那里保护自己的女儿。如果这种保护确实起作用并使我们从生理上感到安全的话，我们会乐于接受。然而，事实上，父亲们并不能有效地保护他们的女儿，女孩们或女人们不能也不必继续去挑选男人作为保护者或提供者。

许多女人告诉我，她们在初潮时感觉缺乏来自父亲的照顾：“一旦我有了经期，我们之间的关系就发生了变化。他从未再拥抱或宠爱过我。我们的关系再也不同于以往。”一个得子宫纤维瘤的女人突然回忆起来，当她 14 岁时，有一次装扮一新准备外出赴一个约会，她父亲穿过房间的吼叫声传来：“你这个荡妇，你这个婊子！”她已经有许多年没有记起过这件事了。她说她当时感觉是这些话直穿过她的身体并留在了那儿，影响了接下来 20 年她作为一个女人的感受。

从出生开始，女性就被灌输这样一种观念，我们的身体是为服务于别人的观看需要的，是为了取悦公众的评论和观察。我们在外夸耀自己的小女孩是为了吸引别人，把她们打扮得像工艺品一样是为了取悦别人。我的一位同事描述了他13岁的女儿是怎样地坐在餐桌旁而她最大的哥哥说：“我想我们已经参观了一个仙女的胸部。”他述说故事当中夹杂一阵大笑，但我想他的女儿并不会感到怎么有趣。

对这个社会当中的许多女孩子来说，青春期是失落的时期。当我的大女儿11岁时，一天晚上我给她盖好被子，她告诉我为一些事感到担忧。她胸部有种疼痛在增长，这把她给吓着了。她想让我检查一下。我照做了，并发现了左侧乳头的发育——这是青春期的第一个信号，我告诉她这很正常，没什么可担心的。我向她表示祝贺。

后来，因为睡不着，她跑到我房间里说：“我们能谈谈吗？”我说：“当然可以，”并问她什么打扰了她。她一下子哭出来，说：“我不想长大。”我抱住她并告诉她我所记得的相同感受。我已经很多年没考虑过这种事了。但现在，女儿躺在我怀里，正处于青春期的边缘，我记起了以前对于长大所感受到的痛苦。我回忆起从不想离开家，不想使自己的生活会发生变化。我们坐在床上，我抱着女儿与她一起分享这种感觉。

不久，我问她是否想和爸爸谈谈，她说是。她问道：“爸爸，你曾经对长大感到难受吗？”他回答：“直到前几年才开始。”对这个回答我们都笑了。承认了我的女儿对青春期的感受，几分钟后，她向我们表示感谢，很高兴地回去睡觉了。这段经历对我来说是个很好的例子，说明当我们能尊重和表达它时，我们的情绪会怎样自然地通过身体并被释放出来。

我的女儿以前没有提出过这些问题，但我知道如果她觉得需要支持，她会提出来的。她的难过是一种挑战，我们应该在我们女儿成年时带着高兴和尊重去帮助她。在一些深刻的，难以用语言表达的水平上，在女人的身体被当做日用品的

文化中，我的女儿知道从纯洁的少女时期向青春期的转变并不完全是一种幸福的期望，这让我高兴。当我们一起努力去为女人创造新的一页，我们必须承认前进也意味着放开和哀悼我们正失去的。

显然，我们不能把女儿带到一个我们从未到过的地方。在连我们自己仍有很深创伤的领域，我们不能为她们提供健康。如果我们仍带着代与代之间那种羞涩去看待女人身体的过程，就别指望去明白女儿们对她们身体的那种爱的感觉。我们需要用新的方法去认识这个领域。我们每个人都必须为女儿们创造新的礼仪和宗教仪式。但在想有效地做这件事之前，我们必须拥有自己的经历，尽管可能是无助的和痛楚的，我们还是应该在自己经历的基础上进行工作。

如何重新认识我们的周期？如何庆祝我们来潮的时间、我们最有力量的时间、我们同全球的女性都有联系的时间？塔玛拉·斯来顿把补救月经周期作为她毕生的工作。她创建了月经健康基金和新月经周期公司。除教育设施之外，她的公司还制作了一种叫做“成人玩偶”的背包来帮助那些母亲和女儿们(或是父亲的女儿们，或是所有那些由支持者所组成的团体)，让他们选择丝线、珠子和其他饰物来制作一个玩偶，以此来庆祝女儿的初潮。

塔玛拉给处于青春期的少女提供车间，在那里每个女孩用粉红色的石蜡去制作子宫。这个子宫上带有卵巢、卵子和月经中期不同类型的宫颈流出物——用红的代表血，白的代表受精卵。然后把不同类型的宫颈流出物按月经制成一个图表。在粉色石蜡做成的小卵巢上点上绿色代表卵子。这个人工制作的过程，同时用了手和脑，还有关于月经周期的信息。它能使我们找到自己生理周期和创造力之间的联系。你能体会到这与“性教育”的不同吗？女孩们只有理解并尊重她们的周期和体内节律，才能使自己与性别融为一体。塔玛拉目前正在推行一个女性的训练计划，该计划可使她们成为自己所在圈子中的月经健康教育者。她的工作对全国乃至全世界的年青女性（和男性）的生活都会产生正面的影响。

几年前，我为外甥女接生并保留了她的脐带。我把它缠在卫生纸的硬质卷筒

上，然后放到有阳光的窗户里面晾干（如果是冬天的话，你可以把它放在一个温火的烤箱里）。这条细长弯曲的肉干是体现孩子和母亲联系的强有力的证据。我想在她长大成人时，在她的成人宴会上把这条脐带送给她。一些美国土著把脐带编在孩子第一匹小马的鬃上来保佑孩子。许多其他的文化中，脐带也有独特的用途。我的女儿们对脐带很感兴趣，奇怪我为什么不把她们的脐带留下来，我说当时根本没有想到这些。现在觉得当时想到了该有多好。

如今十几岁的女孩简直就是“情感炸弹”。因为她们对自己的周期没有任何知识，把性行为 and 性交当成是履行仪式。我提倡教会所有十几岁的女孩如何同自己做爱，这样她们就不会觉得有出去找个男孩的需要！当我们教会年青女性珍爱她们的身体和她们的周期，当我们也在这些领域内治疗我们自己时，我们事实上是在帮着中止已经发生了多少世纪的周期中的这些弊病。

读了帕垂克·瑞思著作中关于女神和女人身体的一篇文章，玛吉·罗森斯记起她曾编造了一个神话来给女儿讲解月经周期。在给瑞思的一封信中，她写道，“当时我女儿四五岁，我处于经期前，正在寻找能缓解痉挛的事情，发点儿牢骚，总之是所有那些能让女人感到高兴点儿的事。我编造出了女神门瑟思，她来自一个天然的地方：妈妈的牢骚——孩子想问个明白，而我已经有了可信的答案。

“我告诉她门瑟思女神每月都光顾我们女人身体一次，她是一个非常神秘的女神。有时我们并不知道她已溜进了我们的身体，有时为了显示她的存在，她在我们体内猛力拉扯。我告诉女儿流血时往往是疾病或受伤的信号，但女神使我们流血是对生命的再次肯定，是对身体的一次清洗。我告诉她，女神来到我们体内是值得庆祝的时刻，是买点儿鲜花和只给女人的小而精的礼物的时刻。

“我之所以告诉她这个牢骚是因为我不是在倾听我的身体。如果我真的感到女神的拉扯，我就能分辨出加于我的额外看顾了（也许吃几片阿斯匹林）。这样做的结果是，我看到了创造我们自身女神的所有积极影响。我创造出了一个小女神与月经周期保持积极的联系。她是一个非常活泼的、精力饱满的女神，她同我

们的身体开玩笑，来得或迟或早，或者平静或者猛烈，在我们体内用力拖拽或翻转，不过一旦她的出现被接受，她就会安静下来并等待——等待下一次。

“进入绝经期时我就会失去这个女神。我们享受过了，是她看顾年轻人的时候了，而对我来说，是让下一位女神进入身体的时候了。我想知道她的名字会是什么？”

通过月经周期创造健康

安静地坐着并问一问自己：“对于月经周期，我的信念是什么？我怎样去感受周期带来的信息？从家庭方面看，我学到了关于月经与激素的何种信息？在生活中，我为年青女性传递了什么样的信息？对自己的月经周期，我能告诉自己什么？它教会了我什么？”不管你在哪儿，对自己都要温柔一些。

接下来的三个月时间里，为了观察月经周期在你生活中的影响，要坚持做一份月相日志。追踪月亮变化的各个阶段。（这些经常被列在报纸上或是月历上。）看你能否注意到自身周期与月亮周期期间的任何联系。看你在月经前想吃哪种食品？长时间沐浴的感觉会像吃热乳脂软糖的圣代冰激凌一样好吗？

给自己时间去协调和改善周期的本质。每天写一篇短的日记。这样做所获得的回报是难以估量的。随着你对自己和你自身神奇的激素越来越尊重，你会以全新的方式去感受生活。

以你独特的方式来欢迎月经女神吧！

第六章 子宫

希腊最古老的神祇，神圣的伟大母亲土地、海洋与天空，被称为德尔斐，这个名字来源于德尔弗斯，意为“子宫”。

——巴波拉·沃克《女人的神话与秘密百科全书》

子宫位于盆腔下部的中心，它通过子宫颈与阴道相连，通过宽大的深红色的韧带与骨盆壁相连。膀胱的后部粘连在子宫前边靠下的部位上。输卵管排列在子宫上部的两边，通称为基底。卵巢位于输卵管末端的下方，通称为输卵管伞。输卵管伞看起来像纤细的蕨类植物复叶。

卵巢、输卵管与子宫都是女性内分泌系统的组成部分。这些器官相互间紧密相连。卵巢里的血液循环多多少少要依赖于完整的子宫。做过子宫切除术的许多妇女，由于其卵巢内血液供应的变化，导致她们的绝经期提前到来。子宫本身对激素的影响也很敏感。作为盆腔内的核心器官，子宫及其粘连盆腔壁的附属物——深红色的韧带，都是整个盆腔解剖的组成部分，它们虽然至关重要，但是被低估。

我们的文化遗产

子宫除其生育的功能外，几乎未被研究，这个事实反映了这个社会的基本文化偏见。子宫被看成某人的潜在的家庭，而且当它能够扮演那个角色时，才被认为有价值。子宫的生育功能完成以后，或者当一个女人做出不生一个孩子的选择时，现代医学就认为子宫丧失了其固有价值。人们对卵巢的看法同样如此，因为医学认为人工激素替代物也能完成卵巢的功能，甚至比女人自己的卵巢更好。人们教导女人要以同样的方式看待自身，即只有在完成做某人的母亲或妻子的任务时才有价值，她们自身不再有其固有价值。

当我在校培训期间，我们肿瘤学的一个伙伴（一位专门担当妇科癌症学培训的医生）教育我们：“坟墓里没有子宫的房间。”培训我们的另一个口号是：“子宫是孕育婴儿的或者是滋生癌症的。”在我的培训期间，当我们的一位医学老师摘除了一个看起来非常正常的子宫时，我们常常戏谑地称这个诊断为 CPU，这是一个用医学方法处理的首字母缩略词，即“有慢性病而又持久生存的子宫”。这些观点在传统医学上流行许多年，但是今天它们正在迅速变化。

在传统的妇产科医师培训中，子宫除了生小孩与患癌症外，也许还有其他功能的可能性还没有被充分提及。即使在今天，如果一个女人患了生殖器疾病，即使她对生孩子没有兴趣，但她又想保留她的子宫，她的医疗组就会认为她太感情化或者太伤感，有点儿迷信，对那个器官知之甚少。这种教育普遍而又咄咄逼人的口气是，如果这种女人更精细的话，她应该懂得，子宫除了生小孩外，别无益处。

我曾经为一个 48 岁的女人做过子宫肌瘤切除术，她并不想做子宫切除术。辅助我的主治医生说：“你为什么不做一次子宫切除术呢？医生们随时都可以为我切掉子宫，因为我已生过几个孩子，它只会对患癌症有利。”我告诉这位医生，应该转变观念。

下面的引述摘自一份关于子宫切除术的文件，它概括了这种观点，这种观点贯穿 20 世纪 50 年代，今天，尽管它有所减弱，但仍然存在。“子宫切除术适合于生殖器接近末期的妇女，她们的子宫不再有好的功能……并且……当不再想要生殖器时，子宫可有可无，因为，尽管它贡献很小或者无贡献，这个变老的器官却易于退化、易于生严重的病。”M·E·戴维斯医生写的这份文件消除了任何反对子宫切除术的观点的可能性，他写道：“孩子一出生时就将其子宫完全切除，这并不影响正常的性生活；它实际上证明了这一点。……宽大的阴道，结合免于害怕怀孕的自由，导致理想的婚姻生活。”事实上，子宫似乎扮演了节制激素的角色，如果不是绝对必需，不应建议切除子宫。

医生与大众一样低估子宫的价值，助长了这一事实，即在美国，除剖腹产手术外，子宫切除术成为第二大的外科手术。在 1984 年的《妇产科医师新闻》中报道，“在美国，子宫切除率在几年内增长如此迅猛，以至于 50% 的 65 岁以下的妇女将不再有子宫”。事实上，在 20 世纪 80 年代，大约 60% 的 65 岁以下的妇女切除了子宫。做过子宫切除术的妇女平均年龄是 42.7 岁，中间年龄是 40.9 岁。这一数字在过去 20 年一直保持不变。子宫切除率在美国随地区的变化而变化，南方的子宫切除率最高，东北最低。黑人妇女做子宫切除术的也比白人妇女做此手术的普遍，并且由男性妇科学家做手术比由女性妇科学家做手术普遍。做子宫切除术的数字在 1985 年达到高峰，那时据报道有 724000 例，但我很高兴地报道，从那时起，数字已经在减少。1991 年，据报道有 544000 例。虽然美国有人口计划与最近的子宫切除率(每 1000 名妇女中有 6.1—8.6 例)，但是估计在 2005 年将完成 824000 例子宫切除术。尽管自 1985 年以来，子宫切除率出现下降现象，但是在可以作出其他选择时，这一外科手术仍然做得太普遍。直到妇女改变对她们盆腔器官的信念时，子宫切除术的数字才会发生重大变化。因为我们的思维活动影响身体，在最近通过调查得来的统计中，关于子宫的消极观念是与本地区妇女遇到的大量问题分不开的。

能量解剖

尽管在卵巢的能量与子宫能量有明显差异，但是许多妇女在这两者中还是同时存在问题。例如，许多卵巢受子宫内膜异位影响的妇女，在其子宫里也有子宫肌瘤。因此，总体上讨论盆腔器官内导致健康与疾病的情绪和心理能量模式的总的特性是有益的。

盆腔内部器官(卵巢、输卵管与子宫)与第二能量中心有关。它们健康与否，取决于一个女人的感情能力、竞争能力，或者创造金钱的能力、心理的丰富与稳定的能力以及完全创造性地表现自己的能力。她必须对自己感觉良好，对她生活中的人际关系感觉良好。另一方面，她若发现人际关系紧张或受限制，则可能会

对其盆腔内的器官造成不良影响。因此，如果一个女人因感觉她不能从经济上或情绪上支持自己，而一直处于不健康的人际关系中时，那么她盆腔内的器官，可能会逐渐处于生病的危险中。

疾病只有在一个人感到在生活中欲做出有效变化的努力受挫折时，它才会产生。疾病发生的可能性和严重程度是与人在生活的各个领域的进展好坏有关的。例如，一个互敬互爱的婚姻家庭，能多少弥补紧张的工作。一个传统的盆腔里的生理问题的心理模式是：一个女人想从行为受限制的关系(如与其丈夫或工作的关系)中解脱出来，但她又没有勇气去面对做出这种变化后所带来的孤独。虽然她能够察觉别人正在限制她能力发挥的自由，但是她的主要冲突实际上存在于她对周围的恐惧心理。我的一位病人在 40 岁时得了子宫肌瘤与卵巢囊肿。我问她是否有创造性的欲望，她告诉我非常想放弃她的工作而去做花卉生意。她从童年时起就对鲜花感兴趣，但是她的父母一直限制她的兴趣的发展，因为他们认为这个兴趣“不庄重”。她孝顺地听取了他们的建议，去学习打字与做秘书的技巧。最终她成为一个会计事务所的秘书长。尽管她对这份工作不满意，但是她一直在工作，因为它为她提供了稳定的收入与好的利益，她害怕自己去闯的风险。随着她 40 岁生日的临近，她感到需要追随童年的激情，她经常梦见可望而不可即的花地，因为它们被铁蒺藜圈住了。通过她的卵巢与子宫肌瘤症，她渐渐认识到这一点。她身体的生育中心正试图告诉她一些事情。另一个影响妇女盆腔器官的因素是她的各种需求间的竞争。当她最内心的同伴之谊和感情支持的需求与外界的成功、自立及同事赞同的需求相竞争时，这种情形就会显示在她体内的盆腔器官上、卵巢上与子宫上。我们的文化教育我们，我们做不到既满怀激情地工作，又同时取得财政上的成功，我们的这两种需求是水火不容的，作为女人，我们不能同时拥有它。女人经常接受这种教育，在处理经济与财政问题时，不要去争夺利益，因为父权制的基础在于女人是仆从。因为有钱有地位能保护我们，使我们有安全感，所以女人接受的教育是要想获得安全就必须结婚，男人接受的教育是他们必须为女人提供金钱与社会地位。在这习以为常的制度下，成功能让我们去摆布别人。由此产生的这些信念与摆布行为，变成了通向盆腔问题之路。子宫与女人最内心的自我意识和内心世界是紧密相连的。它是女人乐于生小孩的梦想与本

性的象征。子宫的健康状况，反映了妇女的内心情感现状以及她内心最深层次的信念。如果一个女人不自信或过度自责，那么子宫的健康就会危在旦夕。

子宫的能量比卵巢的能量低。妊娠胎儿的时间是 9 个阴历月份，而产生卵子的时间仅为一个阴历月份。将子宫看做象征性的或生物性的土壤，在它里面，卵巢排出的卵子需要生长很长时间。

卵巢能量的变化比子宫能量的变化更有动力、更快。在生殖年龄，健康的卵巢每月都以有力的方式排出新的卵子。这时，这个有力的卵巢能量需要引起我们的注意，卵巢能量变化很快。一个巨大的卵巢包囊在适宜的环境下几天就生长起来。卵巢的健康同一个女人的人际关系的质量以及与她外部事情的质量休戚相关。(见第七章)当女人们感到被别人摆布或批评，或者她们自己摆布或批评别人时，卵巢就有危险了。

慢性盆腔疼痛

下腹疼痛可以出现在某一个盆腔器官上，如卵巢，可以出现在几个盆腔器官上或者遍及整个盆腔，即便整个盆腔器官都切除了也是如此。外科手术或药物治疗对一部分患慢性下腹疼痛的妇女爱莫能助。虽然子宫切除术能减轻一些慢性下腹痛，但是四分之一的因患此病而做过子宫切除术的妇女，并未减轻。患慢性下腹疼痛的妇女，通常有复杂的心理与情感历史。研究发现，她们很可能为无关的疾病寻求过治疗，有多个性伙伴，尤其是很可能在以前有过性的精神创伤。她们的肉体疼痛也与未愈合的感情创伤有关，这种感情创伤是在过去或最近在工作、性虐待、感情虐待或强奸（任何程度的）中造成的。一个女人已经察觉到的无法解除的个人或职业生活中的紧张情绪，是导致下腹疼痛的最大因素。过去事件带来的未愈合的创伤存在于体内能量系统内，即使盆腔器官已被切除，也是如此。我经常看到下腹疼痛发生在有乱伦关系的女人身上，它光顾乱伦关系发生的部位，或者在控制着她们而她们认为又必须继续做下去的工作中起作用。我告诉这些妇

女，通过她们的疼痛，身体正要求她们引以为戒并爱惜它。身体，以它的智慧，想把她们的注意力集中在引起她们感到疼痛的部位，以便她们能开始予以治疗。

在许多慢性下腹疼痛病例中，找不到物理原因，因此医疗业不重视它。但是慢性下腹疼痛来源于从过去就开始而未消除的感情伤害，这是真实的，它不是仅“在脑子里”。疼痛在我们的神经、免疫与内分泌系统里以物理的与化学的方式存在着，它存在于体内意识中。它不能简单地通过外科手术切除掉。

子宫内膜异位

子宫内膜异位是一种神秘但越来越普遍的疾病。组成子宫内表面的组织，即子宫内膜，在子宫腔里正常生长（并与每月的月经循环）。在子宫内膜异位的情况下，由于一些原因，这种组织在骨盆内的其他区域，有时甚至在整个骨盆外面生长（有用资料证明了的子宫内膜异位，甚至在肺内表面，甚至在大脑里的病例）。子宫内膜异位最普遍的位置是在盆腔器官里，在盆腔壁上（它围绕在骨盆腔的内部器官上），有时在肠子上。

尽管不是经常性的，但子宫内膜异位有时导致不育症与下腹疼痛。因为子宫肌瘤与子宫内膜异位常常同时出现在相同的个体上，因此我谈论的子宫肌瘤的情况，通常也适用于子宫内膜异位。像子宫肌瘤一样，子宫内膜异位与饮食有关并阻碍盆腔能量。

子宫内膜异位是竞争带来的疾病。当一个女人的感情需要与她在外部世界的职责相竞争时，它就发生了。当一个女人感到她最内心的感情需要与世界正要求她的东西直接冲突时，子宫内膜异位成为她的身体尽力吸引她对这个问题注意的方法之一。

爱丽霞的情况很好地说明了这一点。当她第一次因患下腹疼痛与子宫内膜异

位来找我看病时，她说她上大学时怀过孕并做了流产。虽然她对这个决定感到痛苦，她确实有点想要这个孩子，但是她被迫要完成大学学习，并且还要去上法律院校。她告诉我，在某种层次上，她从来不能解决有一个小孩的愿望与在外部世界里富有创造性的竞争愿望之间的矛盾。正是这种矛盾经常导致慢性子宫内膜异位与疼痛。爱丽霞阐明的这个矛盾几乎是原型，我经常看到它。现在，女人成为传统的以竞争和事业为主导的男性世界的一部分。并且许多人在她们的家庭里或个人生活中得不到感情支持。其他人已经抛弃了她们甚至还有感情需求的观念。我见过的许多有子宫内膜异位的妇女，在外部世界里毫无怜悯地驱动自己，几乎不休息，很少对她们最内心的需求与愿望进行调整。很明显，在我们这个历史时期，有如此之多的妇女将患此病。一位荣格心理学分析家将子宫内膜异位称为“祭祀给女神的血”。是我们的身体正试图不让我们忘记我们女人的自然属性，我们的自我保养需求以及我们与其他女人的联系。

历史上，子宫内膜异位被称作“职业女性的疾病”。耽误了生小孩的妇女觉得它是最大的危险。最近许多有子宫内膜异位的妇女被告知，如果她们待在家里生孩子，她们就会好了。这是一个有争议的断言，也是一个攻击性的断言，因为最近的一些研究显示，怀过孕的妇女与未怀过孕的妇女患子宫内膜异位的几率没有什么差别。戴维德·雷德旺大夫是一位国际知名的子宫内膜异位专家，她证明怀孕并不能预防子宫内膜异位。防止这一病症的将是不要求精神情感分裂的职业与个人环境。这一革命来得较慢，与此同时，每一个女人都能通过理解与倾听身体的信息而开始治疗自己。

症 状

子宫内膜异位主要与下腹疼痛、月经失调以及不育症有关。这些症状从一个女人到另一个女人变化很大。一些有严重子宫内膜异位的妇女从来没有任何症状，甚至在医生诊断出来后，才知道患有此病。另外一些妇女，只要有轻微的子宫内膜异位，可能就会有轻微的下腹疼痛与几乎不断的痉挛。多数妇女是处在这两个

极端之间。子宫内膜异位出现最多的地方是在子宫后部，这个地方位于子宫与直肠之间，通称“道格拉斯死巷”。这个地方的子宫内膜异位能引起性交时疼痛、直肠受压迫以及肠子蠕动疼痛，尤其是在月经来临之前。一手资源微信 ipip885。

诊 断

我常常怀疑那些下腹疼痛、经期之间少量出血的妇女患有子宫内膜异位，这些症状与子宫内膜异位有一致性。不过要确诊是否患有子宫内膜异位，则只能通过腹腔镜检查。如果子宫内膜损伤出现在子宫颈、阴道或阴门上，那么在盆腔检查中就能被诊断出来。不幸的是，研究显示有子宫内膜异位的妇女在被诊断出来前，平均找过五个医生看病，因为许多其他内科疾病，如肠道过敏综合征，与子宫内膜异位的特征很相似。

一些权威人士认为，如果你仔细检查，你会在任何人身上发现子宫内膜异位。我同意这一点。在进行腹腔镜输卵管结扎时，我发现数量惊人的完全无症状表现的妇女其实患有子宫内膜异位，而她们和我都不曾产生过怀疑。

我想知道的是没有问题的妇女患子宫内膜异位的比率。我认为所有女人在其骨盆腔内都可能含有萌芽期细胞，它能长成子宫内膜异位组织。但是，如果我们都有子宫内膜异位的可能，那么为什么一些妇女发展为症状而其他妇女没有发展为症状呢？既然医学权威人士不能告诉我们，那么答案在于单个的妇女，每一位患此种疾病的妇女都应自己破译自身的症状背后隐含的信息。

常见的疑问

为什么如此多的妇女有子宫内膜异位 在我上学的那个时候，我们没有见到有现在这么多的妇女患有子宫内膜异位。有许多理由说明这一疾病增长的原因。

首先，随着腹腔镜检查的出现，我们能更频繁地诊断该病，病人在同一天之内便可得知检查结果。这种检查不用做大手术便可轻松地观察盆腔，因此，有下腹疼痛症状的妇女应用腹腔镜检查就成为家常便饭了。

子宫内膜异位发生率明显增加的另一个因素是，今天的妇女都推迟生小孩，而且比过去要经历更多的月经周期。她们即使生孩子，也不会生好多个。由于子宫内膜异位是因为激素紊乱所致，所以当身体有较高的循环雌性激素水平，而又不因怀孕与养孩子被打破时，将会推动子宫内膜异位的出现。

子宫内膜异位会遗传吗 子宫内膜异位经常在家族中延续，因此有遗传的可能。我见过一些病人，她们的姐妹与母亲都有此病。有一个有子宫内膜异位的姐姐（妹妹），不能肯定你也有此病，尤其是如果你以不同的方式生活。如果你的环境与健康习惯不促使它出现，那么遗传潜势不是非表现出来不可的。标准的缺乏必要营养的美国式饮食习惯会对敏感个体的二十烷类平衡产生影响，导致子宫内膜异位。并且与有子宫内膜异位的遗传因素有关。我在临床中发现，吃用传统方法制造的奶制食品，尤其会加重子宫内膜异位疼痛。

子宫内膜异位会影响生育吗 许多子宫内膜异位患者是有生育能力的女人，她的主要问题是疼痛。子宫内膜异位不会引起不育症，但是人们认为它是导致不育症的主要因素。最近，40%到50%的做过腹腔镜检查来确定不育问题的原因的妇女，发现有子宫内膜异位。许多有子宫内膜异位的妇女，有严重的骨盆创伤，它常常导致不育。戴维德·雷德旺大夫说：“研究的对象主要是不育妇女，这会混淆不孕症与子宫内膜异位之间的关系。”不管是什么原因引起子宫内膜异位症状，它也会导致不育，但是子宫内膜异位与不育症不会相互引起。

那么，什么原因引起子宫内膜异位呢？子宫内膜异位的医疗理论很丰富，但没有一个人真正知道它是什么，为什么现在有如此多的妇女好像有此病。传统理论是子宫内膜异位产生于推后的月经，以至于充盈子宫的一些月经血与组织回到输卵管，然后注入骨盆组织内，并开始生长。因为在某种意义上，月经推后可能

出现在每一个有月经的女人身上，所以这不能解释为什么一些妇女患此病而其他妇女则不患。另一个理论是骨盆组织自发地转化为子宫内膜组织，这可能归因于外界环境有毒物引起的过敏或激素活动，如二氧芑，它能产生类似雌性激素的活动。

是什么原因引起与子宫内膜异位有关的疼痛，这一点不是十分清楚。但有一点是清楚的：月经周期激素部分地刺激了子宫内膜异位，在排卵期以及在月经期前与月经期间，疼痛较厉害。因为子宫内膜异位损伤与子宫内组织是一样的，所以一个女人随着月经的到来，她的子宫内膜异位损伤也将在体内少量地出血，这是可想而知的。一些专家认为，子宫内膜异位损伤分泌的某种化学物质会导致腹膜（即赛纶圈——类似盆腔内表，子宫内膜异位会在此处出现）周围的血管流血，久而久之，每月向盆腔流血被认为是囊肿疼痛与粘连的原因，它们在适当的环境下极易发作。

使我最清楚的理论是子宫内膜异位是正常状况并与生俱来。根据这一理论，子宫内膜异位出现于萌芽期的有利于其生长的组织，它在发展期间从未使子宫内膜异位进入子宫。这有助于解释为何子宫内膜异位在家族中遗传，为何一些女孩一患上了子宫内膜异位就有严重的下腹疼痛。然而，在这个理论里，如果盆腔里的萌芽期细胞遇到一系列合适的环境刺激，那么所有妇女都会患子宫内膜异位。

虽然大多数妇科医生接受的教育是子宫内膜异位是一种会不断恶化的疾病，会越变越坏，但是另一些研究成果，包括雷德旺大夫的理论，显示子宫内膜异位不会扩散或者愈变愈坏（尽管其外表发生变化），如果它被全部切除掉，也不会复发。

在用腹腔镜检查来诊断下腹痛的原因时，许多妇科医生没有发现早期阶段的子宫内膜异位，因为医生们接受的教育就是只检查黑色的“粉末状灼伤”的伤口。事实上，子宫内膜异位会以多种颜色出现：清亮色、白色、黄色、蓝色与红色。许多早期伤口在没有适当设备的情况下，是难于察觉和看到的。

子宫内膜异位伤的颜色可能与周围毛细管的渗血有关。久而久之，伤口由清亮色转化为黑色，这一变化取决于出现的伤口的数量。患子宫内膜异位的妇女，年龄越大，患黑色“粉末状灼伤”伤口“老”子宫内膜异位与卵巢“巧克力”包囊的机会就越大（卵巢里的子宫内膜异位能引起大的卵巢包囊，里面盈满淤血。当它们作怪时，整个包囊看起来就?巧克力糖浆）。

神经内分泌免疫的联系

我们的思维、情绪与免疫间的紧密的相互影响是解释女性个体子宫内膜异位信息的关键。对有子宫内膜异位症状的妇女的免疫系统的研究显示，这些妇女常常有抵抗她们自己的组织的抗体，它被称作自动抗体。这意味着在一些深层次上，她们的骨盆腔正抵制它本身的各个方面的影响。

自动抗体影响人类生殖的各种过程，包括精液功能、多产与怀孕的正常过程。它们的出现可以解释那些同时有这两个问题的妇女的不育症与子宫内膜异位间的关系。子宫内膜异位明显与卵子减少、受精成功率降低（“试管”受精）与流产增加有关。物理治疗专家尼拉维·佩恩治疗不育症与子宫内膜异位的临床经验清楚地显示，在无意识的层面上，这些妇女可能对已怀孕持矛盾心理。她们从理智出发很想怀孕，而她们的内心却并不确定。子宫内膜异位病人里这些非正常自动抗体的出现是了解许多疾病特征的关键，当这些疾病被科学家们仅作为结构问题看待时，他们不能解释它，好像它是一个应该切除的肿瘤。

使自动抗体抵抗身体自己的组织是其他自动免疫疾病的特征，这种疾病阻碍了常规医学，并且在常规意义上是不能“治愈”的。免疫系统高度灵敏，我们的生存依靠它的能力来认识与区分自我与非自我。当免疫系统秩序自我紊乱时，可能会发生什么呢？为了帮助我们自己得以康复，我们可以利用免疫系统从我们的思想中携带的信息。

治 疗

有子宫内膜异位症状的妇女，最好制订一个综合性的治疗计划，这一计划在她们能找出她们需要对生活做出什么改变时，能全力支持她们的免疫系统。我的一些病人通过各种治疗方法治愈了子宫内膜异位。最重要的是，她们中的许多人都逐渐深深懂得，为了真正治愈它，她们需要学习什么，而不是仅仅去掩饰她们身体上的疾病症状。

激素 一旦被诊断出来患有子宫内膜异位，最普通的治疗就是激素疗法，药物有避孕药、合成孕激素、炔羟雄烯异恶唑或者最新的 GnRH（促性腺激素释放的激素）兴奋剂，如烯那热尔与鲁普任。这些药品作用于脑垂体，使女人暂时停经，因此可以通过消除周期性的激素刺激来防止出现子宫内膜异位。

所有这些激素疗法可以改变雌性激素及其系统内其他激素的数量，以便使子宫内膜异位不活跃。当激素水平降低时，症状常常消失，疾病本身变得不活跃。炔羟雄烯异恶唑与 GnRH 兴奋剂在外科手术之前也被优先用来降低子宫内膜异位的数量——在一些情况下，以便外科手术更容易。这些方法的问题是它们不能真正治疗疾病；它们只是简单地暂时地抑制它的激素刺激。另外，有些妇女不能很好地忍受这些治疗的副作用。炔羟雄烯异恶唑价格不菲（一剂药大约花一美元），它有男性化副作用，如体毛发达与嗓门变粗。许多妇女在服用时，体重会增加。促性腺兴奋剂疗法导致潮红、阴道肌肉松弛与骨质损耗。然而，其他妇女非常需要这些激素药物来止痛，好像一旦药物间断，疼痛就时常出现。

我曾经看到一个病人整个夏天都用烯那热尔（一种促性腺兴奋剂）。“野营、冲浪与滑翔太精彩了，不用担心疼痛，”她告诉我，“我只感到精彩。我知道我不能永远依赖它，但我确实感觉好极了。”当我看她时，她已有两个星期没用它了，她的疼痛正开始出现。当我们讨论她的选择时，她说，当她服药前正疼痛时，她常常利用按摩使疼痛完全解除。虽然她被这惊呆了，但是她感到按摩花费太高，而且她的日常安排使改变饮食太困难。而烯那热尔每月花费将近 400 美元。她通

盘考虑后，决定尽力改变她的日程安排而使饮食的营养状况变得好一些，现在她正愿意尝试三个月的一些非药物方法。在那之后，如果疼痛没解除，她知道就得选择外科手术了。

尽管停药后，与促性腺兴奋剂有关系的更年期综合征是可以逆转的，但是这一类疗法，如果采用的时间长达几个月，对每一个人来说都是不恰当的。对于有月经不调或中枢神经系统紊乱问题的任何人使用它时，我都特别谨慎，因为在一些人中，它已与记忆力问题有关。高度紧张的工作、长时间的工作、过多的旅游、几乎没有自己的时间以及对改变自己的生活方式缺少愿望与能力的病人才有可能需要激素治疗。在这种情况下使用药物，使女人继续活动变得更容易，但这种活动仍然会多多少少对她有害。我担心她的药物治疗，但是我也相信她的进程，我知道她将从她的任何选择中懂得某事。我也相信，将她带到我这里来的东西，已经让她了解了她的身体。她知道她能回来尝试一些别的东西，当她认为这些别的东西才适合她的时候。

天然孕激素对减轻子宫内膜异位效果很好，在改善饮食的治疗方法后，它是首选的治疗方法。通常的方法是用含 2% 孕激素的药物软膏 1/4 到 1/2 茶匙，涂在皮肤上，一两次。天然孕激素通过减少子宫内膜异位伤口上的雌性激素的影响来抵抗子宫内膜异位。天然孕激素没有副作用，也不会让人觉得难受。每疗程 10—28 天，一些妇女需要天天用。有时使用含 2% 孕激素的药物软膏会显得剂量不够，在这种情况下，药方上开的药膏要由正规药剂师调配。口服天然孕激素胶囊是另一个选择；通常的剂量是每天 50 到 200 毫克，每疗程 10—28 天。

外科手术 许多有严重子宫内膜异位的妇女，使用激素药物与抗疼痛的药物多年，她们常常在很年轻时就不再使用了，取而代之的是完全的子宫切除术，包括卵巢的切除。虽然这在当时是女人们通常的选择，但是，后来她们中的许多人知道还有其他方法可以替代外科手术这一较危险的方法。

只切除子宫内膜异位而保留盆腔器官的更谨慎的外科手术，是非常有帮助的。

越来越多的妇科医生娴熟于这种骨盆腔外科手术，他们知道如何切掉子宫内膜异位而不造成任何伤害。如果在这一谨慎的外科手术后，留下任何子宫内膜异位，疼痛很可能再次出现。正确完成的盆腔外科手术，疼痛复发率大约为 10%。在这些女人中，疼痛常常不是因为子宫内膜异位造成，而是子宫肌瘤、粘连或腺炎造成。

因为子宫内膜异位疼痛而打算做手术的妇女，必须去找熟悉这种治疗方法的医生。

能量药物 提高免疫系统功能并减少能量流失的任何东西，都是易于帮助子宫内膜异位的。就下列问题问你自己，并如实回答：

你的情感需求是什么？

你希望在工作与生活中发生什么，以使你获得更好的滋养？

生活中你是否被卷入了某种竞争之中？你想改变吗？

你获得了足够的休息吗？

你相信自己有能力改变生活现状吗？

在你的下腹部放一个海狸香油包，每周至少三次，每次一个小时。留意你心中出现的各种想法、意象与情绪。可以考虑接受一个疗程的配合中草药的针灸治疗（见第五章）。至少每隔一周做一次全身按摩，共两个月。按摩后你注意到什么？

饮食变化 子宫内膜异位是一种雌性激素过敏症，雌性激素会使其症状加重。其他会使症状加重的是超量的二类二十烷类，如前列腺素 **F_{2a}**，与月经痉挛有关

的相同激素、一类二十烷类。缺乏一类二十烷类能帮助身体防止发炎、保持血管通畅、帮助体液循环并帮助改善神经与免疫功能。子宫内膜异位疼痛严重的妇女，比没有此病的妇女子宫内膜囊肿中二类二十烷类水平更高。限定饮食的目的是减少体内过量的雌性激素产物并减少二类二十烷类，限定饮食后症状会大为减轻。为了平衡二十烷类，每天吸收基本脂肪酸（见本章中关于经期前综合征的部分讨论及第十七章），并且不吃肉制品与奶制品，它们都含有太高的花生四烯酸；为什么不能有花生四烯酸，其原因还不十分清楚，不吃奶制品常常能大大减少子宫内膜异位疼痛。不吃任何氢化油，包括人造黄油。

我的一位病人患子宫内膜异位多年。她失败地尝试过炔羟雄烯恶唑与手术治疗。但是当她去掉饮食中的奶制品后，她的子宫内膜异位症状消失，并保持十年未患。最近，尽管另一个医生曾告诉她可能不能怀孕，但是她毫无困难地怀上了第一个孩子。能够降低雌性激素水平的食物是十字花科蔬菜，如：甘蓝菜、羽衣甘蓝菜、芥菜、花椰菜、卷心菜与萝卜。每天吃一到两种此类蔬菜。豆制品也有帮助。经常食用豆腐、印尼豆豉、大豆酱、日本豆酱。纤维含量高的饮食也能减少雌性激素循环。每天吃 25 克谷物、大豆、黑米、蔬菜与水果。注意：大多数经精加工的谷物含有太多的碳水化合物而纤维含量低。坚持吃燕麦粉与面粉。

补充多种维生素、矿物质，主要是复合维生素 B、锌、硒、维生素 E、镁（大约 50 到 100 毫克维生素 B 与 400 到 800 毫克镁）。戴安·米尔斯（伦敦营养学家及英国子宫内膜异位协会理事会前成员）经研究发现，补充营养物质的妇女与不补充这些营养物质的妇女相比，症状改善率达 98%。研究中所补充的营养物质是维生素 B1、核黄素与维生素 B6，各 100 毫克；锌柠檬酸盐 20 毫克；氨螯合物 300 毫克。

营养的提高，可使她们至少在两到三个月内达到最佳效果。

多里斯：了解子宫内膜异位 多里斯第一次来找我看病时，她 41 岁。她是一个非常成功的职业女性，她花费许多时间旅游与工作，但是她对照顾身体与情感

需求没有时间。她经血过多，夜晚更糟，有时会透过床单。她抱怨流血、肿胀与严重的月经痉挛。由于子宫肌瘤，她的子宫扩大到怀孕 10 到 20 周那么大。她有不育症病史、几次小产与一次堕胎。另一个内科医生做的腹腔镜检查证实出现了子宫内膜异位与子宫肌瘤，他认为它们都与她的流产有关。她的妇科医生建议她做子宫切除术，因为他说她的月经将继续有问题，直到她最终选择做手术才会结束。不管怎样，她对这个诊断不满，并且为了她的选择，她来找我。

当我第一次给她看病时，在她的子宫后面有大量的嫩肉，在有子宫内膜异位的妇女里这是很普通的。我问了关于她的生活方式、饮食、小产、堕胎、锻炼与紧张程度的问题。我同意外科手术在当时不是必需的，并建议采取几种替代疗法。它们包括：消除饮食中的奶制食品、用海狸香油包放在下腹部、吃维生素补充物以及阅读至善论的读物，并对阅读入迷，食品的营养也要全面。从多里斯告诉我的关于她的情况中，我认为她需要调整自己对于小产与堕胎的情绪。她决定听取我的建议。为了激发起她对生育的激情，她决定给曾经存在于她身体内却未出生的小家伙写信。后来她给我写信说：“很明显，它们一直以一些形式留在我脑海里，并且是以子宫肌瘤以及也许是子宫内膜异位的形式留在我体内。我写了这些信后，最难以置信的经历出现了。我一直记得我的很有规律的形象化的梦。一天晚上，在梦中我十分清楚自己的身体，我梦见成千上万个白鸽子飞出我的子宫。一种难以置信的光明感照到我身上，我醒来后高兴得哭了。”多里斯的梦中经历过去三个月后，我检查了她，发现她的许多子宫肌瘤不翼而飞，她的子宫嫩肌肉也是如此。子宫肌瘤好像已固化成一个平块，它肯定比最初检查时小了。多里斯发现，当她仔细照顾自己并遵守食谱、锻炼身体以及只为自己做一些事情时，她感觉好了，任何种类的盆腔病症都不见了。虽然她的子宫肌瘤未完全消失，但它们很多年来没有生长。现在，在检查时，她已经没有了子宫嫩肌肉，事实证明她的子宫内膜异位很不活跃。多里斯用她身体的智慧，治好了一些让自己伤心的非常痛苦的病。她心甘情愿地去冒险，完全改变她在人世上对待自己的方式。如果一个女人要想根治自己的病，就得做出变化。这常常包括要非常诚实地反省自己：我们是怎样真正认识做女人的。它也包括从我们的社会活动中回归，并在内我与外我之间建立一个健康的平衡。

子宫肌瘤

子宫肌瘤开始于子宫肿瘤。它们生长于子宫壁外表面与内表面或者子宫腔内的各种位置。(见 P173 图 8)测量子宫肌瘤大小的标准医疗新实践是，将长有肌瘤的子宫的大小与各种怀孕阶段的子宫的大小进行比较。因此，如果一个女人的子宫与其怀孕 14 周时的子宫的大小一样，那么她就会被告知长了一个 14 周大的子宫肌瘤。子宫肌瘤是由坚硬的、白色的、可怕的螺旋状组织长成的。20%到 50%的妇女会出现子宫肌瘤。我的一个病人，看了她的通过腹腔镜切除的子宫肌瘤后说：“子宫肌瘤的样子使我惊呆了。我原以为它是凌乱的样子。子宫肌瘤看起来像一块高密度聚乙烯塑料，就像制切菜板的材料一样。”

子宫肌瘤病人占妇科医院病人总数的 33%，它们是造成美国妇女子宫被切除的第一原因。患此病的黑人妇女比白人妇女多三到九倍。许多有子宫肌瘤的妇女直到常规盆腔检查发现它时，才知道自己患有子宫肌瘤。从常规医疗观点来看，没有人知道引起子宫肌瘤的原因是什么。

卡罗琳·米斯指出，子宫肌瘤代表我们从未表现出来的创造性，包括我们自己的“幻想”形象（这些形象从未见过白昼之光），以及我们的其他的“自我”的创造性秘密。当我们的生命能量流进死巷时，子宫肌瘤也会产生，如同那些无法再进一步发展的工作或社会关系。我让有子宫肌瘤的妇女调整她们与别人的关系，并学习如何表达其创造性。子宫肌瘤通常与关于创造力的矛盾心态、生殖以及人际关系有关。在我们的急剧变化的社会文化中，女人的角色不断变换，这一点很明显，即养育孩子与个人的创造性的表现之间的矛盾是一个文化现象，而不仅仅是个别现象。我的一个病人，看了她的子宫肌瘤后说，很容易把它看成是一个坚硬而无情的天使。有如此多的妇女长子宫肌瘤的事实，可能证明在目前这种社会文化之中我们的创造性能量被封闭了。

症 状

许多妇女的子宫肌瘤没有症状。这些子宫里的生长物通常在常规骨盆检查时才引起妇女的注意。子宫肌瘤是否有症状与其大小以及在子宫内的位置有关。那些仅位于子宫肌肉壁表面下（次绒毛膜）的子宫肌瘤常常引起严重的或无规律的流血。一些子宫肌瘤通过一根细茎附养在子宫内或子宫外。那些被称作有肉茎的子宫肌瘤，如果它们长在子宫外，常常与卵巢肌瘤混在一起。我有两个病人，通过子宫颈口“传递”出肉茎达6厘米长的子宫肌瘤。我简单地通过缝合切除这些子宫肌瘤，然后切断肉茎。这两个女人没有更大的问题。

同时患有子宫肌瘤与子宫内膜异位的妇女，可能经历月经痉挛、下腹疼痛，或者这两者都经历。大多数子宫肌瘤可以先等等看，大约六个月到一年做一次检查，监控它的生长。

流血 有子宫肌瘤的妇女有严重的经血过多现象，导致贫血、疲劳，甚至在最严重的几天不能出门。如果子宫肌瘤生长迅速，如果一个女人的内分泌状况处于剧烈的变动当中（这在更年期很普遍），或者如果她高度紧张，她甚至会从子宫肌瘤发展为大出血。一些妇女一直习惯了每月大量失血，她们甚至不明白正常流血的感觉如何。

子宫肌瘤能引起大量流血，因为子宫提供了非常丰富的血液。如果是次粘膜子宫肌瘤（位于子宫内表面下面），它会使身体用来阻止经血过多流出的机制难以发挥作用。月经期流血可以被子宫肌肉收缩部分地阻止，而子宫肌瘤可以干扰这一机制。在非正常流血肯定是由子宫肌瘤引起而不是由癌症引起的情况下，子宫内膜活组织检查（从子宫内取出组织样本）或者子宫壁膨胀和刮除术是必需的，这对于那些整个月都无规律地间歇性流血的妇女来说，是尤其必要的。

子宫肌瘤退化 随着子宫肌瘤的迅速生长，它也会开始退化，这是能够发生的。例如，在情绪特别紧张期间、在怀孕期间或者在绝经前一年左右。当子宫肌瘤生长得因血液供应不上而不能再生长时，它就会出现退化。当发生这种情况时，

子宫肌瘤中心丧失了血液中的氧供应，这一组织深处的神经因缺氧而表现为疼痛，这与冻伤的脚步疼痛的方式一样。疼痛虽然烦人，但这种状况通常没有危险。子宫肌瘤中心的退化常常引起子宫肌瘤缩小，有时子宫肌瘤完全退化并消失。子宫肌瘤是缩小还是消失，神经自行调整大约一个星期后，疼痛通常都会消失。

盆腔压迫与尿频 有时子宫肌瘤的位置会引起症状，因为子宫肌瘤有可能压迫另一器官，如直肠或膀胱。这时直肠、背部下方或者腹部会产生被压迫感或发胀的感觉。如果子宫肌瘤在子宫前部并相对较低的地方，对膀胱的压迫能降低膀胱的储尿功能，导致尿频（尿液不得不频繁地少量排出）。这些症状虽然烦人，但是一般对身体无害。我从未发现毗连良性子宫肌瘤的器官会被子宫肌瘤伤害。当一个女人躺下来时，一个暂时较大的子宫肌瘤能部分地阻塞输尿管（从肾到膀胱的管道）。泌尿科医生与妇科医生都不能确切地知道这种情况是否最终导致肾出现问题。大多数因子宫肌瘤过大而引起尿道压迫的妇女，宁可做手术。不管怎样，我的几个病人未做手术也不错，她们的肾是好的。其中一个女人，有一个至少有 10 年历史的大子宫肌瘤，她的尿道时不时地被子宫肌瘤阻塞，她刚刚开始进入绝经期。她的子宫肌瘤现在正迅速缩小。

常见的疑问

我的子宫肌瘤是什么？当我第一次感觉一位病人的子宫肌瘤时，我常常用盆腔超声波测量它们并检查卵巢的状况。有时靠检查盆腔来说明卵巢生长与子宫上的肌瘤的区别是不可能的。

子宫肌瘤会癌变吗 子宫肌瘤几乎从来不会癌变，只有不到千分之一会变成子宫癌，这是一种罕见的子宫肌肉癌。不管怎样，确诊的唯一方法是取出它们，放在显微镜下观察。因为子宫切除术本身的死亡率为千分之一，所以外科手术的危險性比子宫肌瘤癌变的危險性更大。

子宫肌瘤最普遍的问题是它们的生长以及它们有可能引起流血。但是正如我所治疗过的许多妇女一样，如果与子宫肌瘤有关的基本能量模式、生活问题、矛盾与情感问题都得到处理并发生了变化，那么子宫肌瘤通常不会生长或引起问题。

子宫肌瘤会遗传吗 子宫肌瘤能在家族中遗传。我的一个子宫肌瘤病人告诉我，她的家族中三代女性都有子宫肌瘤。她打算成为她的家族中第一个在绝经期中子宫仍完整无缺的人。她改变了她的饮食，现已完全没有症状。

就像一个有严重酗酒历史的家庭，在一个有严重子宫肌瘤病史的家族中，单个女人要起而反对信仰体系，免于此病是非常困难的。我曾经读过一篇题为《我的母亲、我的细胞》的关于家族卵巢癌的文章，在文章里作者阐明了她不想继承这种病的困难，这种病使她害怕，也使她感到无法控制。

在美国，我们总是将遗传倾向当做不可避免的“判决”，即我们将患此病。不管怎样，环境因素在那种倾向是否表露中扮演了一个重要角色。例如，一些有子宫肌瘤包囊基因的个体，却完全没有发病的迹象，并很好地活到 50 多岁。有严重乳腺癌病史的家族中的一些妇女，却从来没有患此病。

有严重子宫肌瘤、卵巢包囊或子宫内膜异位病史的家族中的一些妇女，曾发生过此类病症，但她们最终却治愈了它们。有一位病人概括了治愈此类病症的一个必需的部分，她说：“我最后明白，我不是我母亲。我不是非得在我身体里去重复她的生命。”在有遗传疾病的家族中，我们应该研究那些未患此病的成员。她们很可能是打破家族疾病模式的个体，她们不去重复家族历史上曾发生过的那些疾病。

我的子宫肌瘤会影响怀孕吗 怀孕期间，激素水平很高，先前存在的子宫肌瘤可能会迅速生长。如果子宫肌瘤开始退化，它们有时能引起子宫收缩，这能导致早产。不管怎样，不是所有子宫肌瘤都产生这种情况。我见过有 14 周大的子宫肌瘤的妇女怀孕，怀到最后，经过正常分娩，毫无问题地将孩子生下来了。

一位 29 岁的女人来我这里，她怀孕已 12 周，在其子宫后部长了一个巨大的子宫肌瘤。尽管她没有计划怀孕，但她对此病不寒而栗。她的医生已让她流产，然后在重新怀孕前切除子宫肌瘤。他告诉她子宫肌瘤将可能引起早产，婴儿将太小而不能存活。她对自己的窘境伤透脑筋，她需要一个同意她保留胎儿的医生，她知道也许有问题，但也存在一切进展良好的可能性。她的怀孕正常进行，整个过程都没有疼痛、流血或者早产。她的子宫肌瘤在产后六周检查时缩小到只有八周大。

子宫肌瘤能导致流产或者不育，尤其是如果它们将子宫腔变形过大。是否有问题，好像取决于子宫里的肌瘤的位置以及它距离正在发育的胎儿和胎盘的远近。超声波或者子宫输卵管造影图（一种将染料注射进子宫与输卵管的 X 光透视研究）能够让你在怀孕前知道子宫肌瘤的位置，就像 MRI（磁共振成像）那样。

一些怀孕的妇女长有开始退化的子宫肌瘤。她们最终住进医院，在她们躺在床上治疗疼痛时被细心护理。一般说来，如果子宫肌瘤不引起十分严重的子宫过敏以至于子宫开始收缩并导致早产的结果的话，那么它不会伤害发育的胎儿。在怀孕期间，没有办法保证防止子宫肌瘤生长，因为整个子宫在生长，包括子宫肌瘤壁。子宫肌瘤距离子宫腔越远，一个女人有问题的可能性就越小。一些医生对子宫肌瘤与怀孕倾向于采取等等看的态度，建议病人尽可能留着腹中的胎儿并看看会发生什么情况。其他医生将建议她在试图怀孕前切掉子宫肌瘤。

子宫肌瘤会生长吗？它们会消失吗 许多长有子宫肌瘤的妇女被告知应该在子宫肌瘤相对较小时做子宫切除术，以便在未来不需要冒更大的危险做更复杂的子宫切除术（假设子宫肌瘤会生长）。研究显示对此很少有或者没有正当理由。有时候子宫肌瘤确实生长，但不是普遍性的。它们仅仅在绝经前几年内长得很快，当内分泌发生剧烈变化时，它们在绝经后紧接着就急剧缩小。我的一个接近绝经或者“几乎绝经”的病人，已经 49 岁了，我对她的病情跟踪了十多年，她用手指按摩腹壁就能容易地摸到子宫肌瘤。她说，在她的月经期前子宫肌瘤长大并升到腹部的扣子外，月经期结束后三天，它就缩小降到耻骨上面一点点！子宫肌瘤

通常在每个月经期都改变大小，在排卵期与月经期刚开始时达到顶峰。它们在情绪紧张期间也能生长。每六个月到一年提供一次健康状况检查能跟踪子宫肌瘤。如果你没有激素治疗或其他手段不能控制的反反复复的严重流血，就没有理由匆忙做手术。

有时子宫肌瘤会完全消失。最近，我遇到一个信仰宗教的因子宫肌瘤而计划做子宫切除的妇女。她天天为它们祈祷。六周后，当她再回去看她的医生时，子宫肌瘤不见了，她不需要外科手术了。

我的一个病人，名叫波细斯，她是一位 40 岁的音乐家，她的嗓音作过矫正。她第一次来找我看病时长着一个像四到五个月孕期的胎儿那么大的子宫肌瘤。经过两年的限制饮食、内在的心理暗示按摩与声波治疗，她的非常大的子宫肌瘤几乎变正常了。我很少看到子宫肌瘤缩小得像她的那么多。这种缩小不是因为绝经，她的月经一直正常。下边是她的故事。

“1988 年夏天，我被诊断出患有子宫内膜异位并长着葡萄那么大的子宫肌瘤。接下来的几年，令人难以忍受的疼痛日益加剧，几乎使我不能开车。用了两周时间，我才逐渐习惯了疼痛，后来的两周我从筋疲力尽中恢复过来，但已变得害怕月经。

“当时我看过的医生告诉了我所有治疗这个问题的备选方案。他最倾向于子宫切除术。他说：‘在你这个年龄阶段，无论如何都不需要子宫了。’他还提出可用激素治疗，这样可使月经停止两年，‘你的声音将变粗，并且你会失去性欲。’他提供的最后方案是我可以继续疼痛与流血，直到最后自然绝经。

“因为我想保持一个完整的身体，尤其不想做激素治疗而放弃女性特征，也不能忍受疼痛，我开始寻找其他治疗。我对生活做出了保证，我承担了仔细照顾自己的责任。我接受了其他人的爱心和帮助。我开始严格遵守长寿饮食起居制度、用浴盆坐浴、锻炼与治疗。回顾过去，我不知道在我繁忙的生活中是如何适应这

些的，我知道自己的确变了。

“我也开始慢慢寻找在我的‘女人的麻烦’的背后的原因。我承认我的依赖性，并且在孩提时代与刚进入成年时代疼痛就开始了。我腹部的疼痛是终身疼痛的顶峰。我知道仅仅切除它，并不能治愈我所有的其他疼痛。

“我现在没有疼痛，感觉特别好。我正处在并将常常处在我的生命过程中。通过医疗与靠我自己的声音治疗，我已恢复了内心的自信。我接受了我的生命，也相信自己有着能治好自己也能帮助治别人治愈的能力。当我帮助别人时，我也是在帮助自己。”

如果我做了外科手术，子宫肌瘤会再次生长吗 这个问题的答案必须分别考虑。一般说来，在绝经期五年之内的妇女，子宫肌瘤切除后可能不会再生长，因为她的雌性激素水平将自然地降低。有时子宫壁上有许多小的子宫肌瘤。做手术时很难将它们全部切除掉。如果与子宫肌瘤有关的潜在能量模式、情感问题或激素水平不改变，这些所谓的籽状子宫肌瘤就会开始生长。改变饮食的妇女能大大减少子宫肌瘤复活的可能性。我的大多数病人的子宫肌瘤没有复活或恶化。我认为这是因为来我这里的这类妇女，准备做艰苦的工作来对待问题背后的信息。我给她们介绍了饮食改变法、体力劳动与其他备选方法，甚至包括那些选择了做手术来治疗的妇女。单单做手术不会改变体内加强子宫肌瘤生长的基本模式。倾听身体正在努力传递给我们的信息是最关键的。

治 疗

我绝对不专横地向我的任何病人提出治疗子宫的方法。没有绝对的对与错。相反，我为她们提供看待她们的子宫、卵巢与身体的方法，以便当她们需要对激素、药物或手术做出决定时，她们能知道关于那些器官的个人事实是什么。治疗子宫肌瘤的方法现在比以前多了。一旦一个女人收集了所有治疗方案，她就能根

据自己的内在引导机制决定哪一个对她是最好的。

许多妇女已经知道在这件事情上她们有选择的权利，这本身就是一件令人欣慰的事情。例如，当一些妇女不能自由选择治疗方法时，她们把外科手术看成进一步的摧残。乱伦幸存者有时告诉我，由于女性的本能，她们觉得任何对她们身体的侵略都像是在对她们进行强奸。很显然，在这些病例中备选治疗方法应该被尝试，而不能让这个摧残性的周期再次出现。

下面的这些病例能够说明子宫的治疗可以有不同的方法。每一个女人对相当直接而普遍的症状都需要帮助，而且每个人选择的治疗方法不同。这当中只有一个女人想做子宫切除术。每一个女人都能安排一个尊重她的选择的医疗，当医疗技术在个体治疗中被有意识地采用时，对治好的女人的身体是重要的帮助。声称子宫切除术通常是错误或较差的选择，就像声称所有自然疗法都是江湖骗术一样，都是十分有害的。我不是说所有情况、特殊的心理与感情问题都与“骨盆内封闭的能量”有关系。不是所有的女人都开放的或者准备探索她们的深层次问题，我尊重她们等待恰当时机的选择。

保守者：观察与等待。如果一个女人的子宫肌瘤没有引起一些问题，根据她的情况，我建议每六个月到一年做一次骨盆检查。我最初也建议做一个超声波扫描来确定我正处理的是子宫肌瘤而不是卵巢包囊或肿瘤。保守疗法有时被称作“有益的疏忽”或者“时间剂”。有时它是最好的治疗法。

子宫切除术 子宫切除术可能是提供给患有子宫肌瘤的美国妇女的最普通的选择。当一个女人整月甚至整年流血、因血液流失而贫血、有一个像怀孕一样的大肚子、因害怕血流到衣服上而不敢出门以及因子宫肌瘤压迫膀胱而产生尿频时，这个选择常常被做出。

研究显示，如果一个女人不仅仅有外科手术这一种选择时，子宫切除术能改善她的生活质量。不管怎样，如果一个女人做一个她确实没有思想准备的外科手

术，没有充分考察各种选择方法，那么结果将是毁灭性的。很多年来，我发现在决定做手术前充分考虑了她的选择的妇女，对结果更高兴。（关于怎样准备做手术以及康复过程，见第十六章。）很不幸，在医学上常常有一种创造危机形势并匆忙采用外科手术的趋势。有时一个女人因子宫肌瘤而仅仅有吓人的流血情况时，就被告知尽可能做子宫切除术。因为害怕被她的医生与家人拒之门外，她常常违心地听从了，其实那时她本来可以等待。我相信，这些过后常常对自己的决定后悔的女人，都是认为除外科手术（通常是子宫切除术）外，她们别无选择。在开始任何治疗过程前，一个女人应该给自己一点时间去收集必要的信息并权衡一下她的所有选择。

富兰是一位有一个女儿的老师，她来看病时是 43 岁。在此前的六个月中，她在月经期与月经期之间流血严重，痉挛与日俱增，性交时有些疼。当我检查她时，我发现她长了一个巨型葡萄那么大的子宫肌瘤（直径大约 11 厘米）。在此之前，我认识富兰已有多多年，而且她的女儿是我接生的。在她的教学过程中，她走遍了许多不同的学校，她发现保持一个健康的饮食是困难的。她的体重特别重，她嫁给了一个痛恨自己的工作并有点抑郁的男人。鉴于她的生活状况，她的选择是要求保留卵巢的子宫切除术。她知道，虽然我能使子宫完整无缺地切除子宫肌瘤，但是这不能保证她以后不会痉挛与不会无规律地流血。富兰没有兴趣去花时间搜寻治疗的备选方法，她也没有兴趣去了解她的子宫肌瘤会对她说什么。她从月经期、痉挛以及怀孕的恐惧中解脱出来的想法很强烈。她毫不复杂地做了外科手术，并在一个月內恢复了她的正常生活。富兰是一个好例子，她知道她有权利选择并对自己的选择了如指掌。

在我做子宫切除术或其他外科手术前，我通常指出，器官的切除可能会改变一个女人身体的经历。至于子宫切除术对妇女的身体的、感情的以及心理的健康与身体形象的影响，还需要做更多的研究。

性反应 大约一半的切除了卵巢（大多数常常是与子宫一块被切除的）的妇女，不管其年龄多大，将相当突然地发展为睾丸激素缺乏，原因是卵巢睾丸激素

缺失以及随后的肾上腺雄性激素的分泌减少。一般说来，伴随子宫切除术的性功能障碍发生率是 10% 到 40% 之间。例如，在英国实施的研究结果显示，33% 到 46% 的妇女在子宫卵巢切除（切除掉子宫与卵巢）后性反应降低。但是在 1994 年做的《迈恩妇女健康研究》中，没有显示那么高的比率。虽然有报道说一些妇女在子宫切除术后增加了性反应，但是这很清楚，对大多数人来说并非如此。医生们对子宫切除术与性反应之间的联系没有给予足够的注意，并且将伴随子宫切除术的性反应或性兴趣丧失的变化仅看做是心因性的或原因“全在大脑”。心因性理论的基础是古老的假设，即女人的卵巢、子宫颈与子宫跟她的性欲没有关系，对她的性满足不是必不可少的。这种古老的看法喜欢将身体与思想分离，并认为大脑是基本意向、思想与感情的源泉。因为这种想法轻视女性身体与我们的器官，所以它将性本能看成最初的精神起源是不奇怪的。我的一位病人，当她的医生问她为何将卵巢看得如此重要时（他想用子宫切除术切掉它们），她来我这里寻求第二种意见。为了回答他的观点，她问他为什么将他的睾丸看得如此重要。正如大多数妇女所知，思想与身体是统一的。很简单，如果一个女人认为她的性器官有积极作用，那么它们的切除将因生理与心理原因而影响她的性生活。

现在我们知道，在一些妇女中伴随子宫卵巢切除术的性反应降低有一个心理基础。研究者知道与卵巢切除相联系的雄性激素丧失是伴随外科手术的性本能丧失的因素。即使卵巢完整无缺，一些妇女在子宫切除后性高潮体验不同，可能因为子宫颈与子宫为性高潮充当了触发点。这些妇女感到深深的、有节奏的子宫收缩是性高潮的一个非常满足的部分。她们发现子宫的丧失是一个变化、一个性高潮深度的实际减少。那些主要是通过刺激阴蒂体验性高潮的妇女不会有这样的体验。另一方面，对于那些多年有性交痛体验或者因子宫或卵巢问题而有下腹疼痛的妇女，子宫切除术能大大增强她们的性体验质量与生活的全部质量。

那些遭受伴随子宫切除术而丧失性欲或能量普遍减少之苦的妇女，应该检查她们的雌性激素、睾丸激素与脱氢表雄酮水平，然后用天然激素将她们的激素水平恢复正常。我采用唾液激素测量，它不需要一滴血（见做这些测验实验的资源）。在我的经验中，最好的替代物是含天然睾丸激素的皮肤软膏。通常剂量是每天或

每隔一天 1 到 2 毫克。这必须由一个健康保健医生开药方，并由正规药剂师准备。一些妇女，但不是所有的，能从脱氢表雄酮药物中得到帮助；通常剂量是 5 到 10 毫克，每天一次或两次。一些妇女认为最好是每天 25 到 50 毫克。

绝经期 仅仅是子宫切除不会必然影响一个仍然排卵的妇女的绝经期激素水平。它常常会导致月经的停止。不管怎样，即使卵巢保留下来，其供血状况也会改变。这改变了身体的内分泌环境，并会导致绝经症状与绝经期提前。在一项研究中，这一点出现在大约 50% 的例子中。（据报道，许多妇女紧接着子宫切除术好几个月都出现潮红，甚至当卵巢留在那里时也是如此。仅仅是卵巢切除而无其他手术也会发生类似的事情。卵巢在手术后恢复功能或一个卵巢代替两个卵巢的功能，有时需要花费一段时间。）有一些证据显示，做过子宫切除术的妇女，其骨质疏松症开始的时间比其他妇女的早，甚至卵巢还留在里面也是这样。很明显，以任何方式削弱卵巢功能的任何事情都可以导致性欲降低。

小便的问题 做过子宫切除术的妇女在之后的生活中，很可能发展为小便失禁。原因是支配膀胱的神经离子宫很近。一些神经纤维在做子宫切除时被损害。

心脏病 一些研究显示，卵巢切除产生的有害于心血管的效果早于一个女人的自然绝经期（自然绝经期的平均年龄是 52 岁）。因为甚至在绝经期后，卵巢还继续分泌激素，所以甚至在绝经期后切除卵巢也有可能产生不利影响。

肌瘤切除术（子宫肌瘤的外科切除手术） 肌瘤切除术是一项子宫肌瘤被切除而子宫被修复并留在那里的外科手术过程。过去 10 年在外科手术技术上的进步，使这种手术成为那些想保留完整的盆腔器官或有孩子的妇女的很好的选择。我的许多病人甚至在因饮食变化而消除了各种症状后，仍选择做肌瘤切除术。子宫肌瘤的出现会一直引起腹部增大，这影响她们如何看待与感觉自己。越来越多的肌瘤切除术正通过腹腔镜（一种通过腹壁插进盆腔的显微仪器，因此不会造成大的腹部伤口）完成。这个过程尤其适合于六厘米或更小的子宫肌瘤，但这取决于外科医生。许多内科医生首先开促性腺兴奋剂以缩小子宫肌瘤而使外科手术更

容易。子宫肌瘤越小，能够通过腹腔镜检查切除的机会越好。

当格罗里亚第一次来看我时，她 45 岁，已生了两个孩子，她丈夫做了输精管切除术。格罗里亚长了一个正压迫她的膀胱的大子宫肌瘤，它引起尿频，这使她夜晚常常醒来。她的月经正常，没有疼痛。她的妇科医生推荐了子宫切除术，但她感到这个选择太严重。相反，她选择了肌瘤切除术。她的妇科医生“因为她的年龄”而不愿做这个手术，这是歧视老年人的态度。与许多受常规训练的妇科医生一样，这个医生认为格罗里亚的子宫没有用，因为她已进入不惑之年，而且不想要更多的孩子。格罗里亚最终做的肌瘤切除术完全解除了她的尿频症状，现在她整夜能睡着。她很高兴她的子宫保留下来了。

当子宫肌瘤的位置与大小使生孩子成为问题时，肌瘤切除术是一个好的选择？在一些女人做肌瘤切除术前，她们被告知，在做手术时，一旦医生认为必须，就将这一手术改为子宫切除术。在我自己的经历中，我没有见到一例认为这是必须的。当然，我处理的主要是健康的病号，并且是与其他熟练的妇科医生共事。一般说来，肌瘤切除术最好由那些在不育外科手术上受过特殊训练的妇产科医生来做。这类外科手术主要是修复盆腔，而不是切除器官。

激素疗法：合成孕激素或者天然孕激素 对那些最初的症状是流血的妇女，我常常提供合成孕激素或天然激素作为治疗法，来防止子宫内表过度生长。在许多病例中，这个疗法有效地控制了流血，并且比腹部外科手术有利得多。孕激素对于那些不能改变饮食或她的症状通过改变饮食并未减轻的妇女来说，是一个选择。一些妇女在依靠合成激素时变抑郁了；其他人感到肿胀或月经提前或者头痛。我开激素药物的方法因病人不同而变化。因为每个女人的生活状况不同，她的医疗方法需要个别化。

促性腺兴奋剂 促性腺激素兴奋剂，如鲁普任和烯那热尔，都是合成激素，它们引起垂体腺关闭卵巢功能。大约服药一个月后，女人的身体就会人为地停经。她的雌性激素水平降得很低，她的月经停止。她的子宫肌瘤组织的周期性刺激停

止，而且在大多数情况下子宫肌瘤缩小。促性腺兴奋剂最近被用来在做外科手术前缩小子宫肌瘤或者使它缩得足够小以便不需要做外科手术。一些内科医生用这些药来保持一个女人的子宫肌瘤无症状，直到她达到停经年龄，在这一点上子宫肌瘤自然缩小。通过这种方法，能使她免于做外科手术。这些药大约需要三个月就达到最佳效果，但是大多数妇女为了使肌瘤获得较多的缩小，她们仅服两个月的药。因为不是所有子宫肌瘤都长得一样，所以不是每个人都能获得相同的效果。

正如我早先注意的，促性腺兴奋剂昂贵(几乎每月花 400 美元)，而且它们的使用不能长于六个月。如果一个女人在服药期间不是自然停经，那么一旦停止用药，子宫肌瘤就会迅速复生。

因为合成激素相对较新，所以我的许多病人在用这些药时都有些犹豫。她们中许多人还记得，几十年前为了防止流产，人们热衷于采用乙烯雌酚(DES)。这种药后来被认为会引起某种罕见的阴道癌以及用过它的女性(甚至是男性)后代的其他生殖器官异常。虽然这样说，很显然，促性腺兴奋剂在治疗子宫肌瘤上确实有一席之地。最近正着手研究，在施用足够的“添加阻止”激素来减少它们的绝经副作用而不破坏它们的效果时，如何用它们来缩小子宫肌瘤。这一进步能够使一些妇女免遭绝经前后的子宫切除术之苦。

通过子宫镜检查的子宫内膜切除术 克里斯婷多年来月经期令人难受——她一次不得不用两个高级卫生巾以及一个卫生带。有时，在她的月经期间，白天每半小时要换两次，这使她去旅游甚至离开家去食品杂货店都很困难。她做的小的饮食变化不起作用。进一步的检查显示，在她的子宫壁上有许多很小的子宫肌瘤。

克里斯婷非常不想做子宫切除术，因此我们在每月最后两周试用了合成孕激素疗法，共三个月。虽然这一疗法几乎常常减少流血，但在她这个病例中不起作用。子宫壁膨胀与刮除疗法也不能缓解她的流血。我介绍她到一个用子宫镜检查做子宫内膜切除手术的医生那里。子宫镜检查是一项外科技术，它是通过阴道与子宫颈口插进一个观察仪器来观察子宫内表面并做手术。次绒毛子宫肌瘤有时可

以由深谙此术的外科医生通过此法切除。这一手术是在手术室里在麻醉状态下完成的，腐蚀并消除子宫内膜表面——子宫内每月流血的部位。当它起作用时，绝经期停止或者流血变少。对于克里斯婷，这个手术效果极好。与切除子宫需要一个月时间恢复不同的是，她做手术这一天进医院，第二天就走了。虽然这类手术不适合于每个人，但是对于一些人来说，这是一个很好的选择。它在有些病中不能适用，这取决于子宫肌瘤的位置。

绝经后：天然激素疗法 一旦一个女人进入绝经期（通常在 50 岁到 52 岁之间），子宫肌瘤通常会急遽缩小。有子宫肌瘤的妇女只是在 45 岁到 50 岁之间频繁地经历症状，子宫切除术通常是在这个年龄阶段完成的。如果一个女人愿意，那么通过控制子宫肌瘤直到在绝经期自然收缩而避免子宫切除术。这可以通过饮食变化、海狸香油包、孕激素疗法与减少紧张情绪综合完成。

比娅，是一个没有孩子的单身老师，她于 1984 年带着一个子宫肌瘤与每个月经期有 12 到 18 个小时严重流血的历史第一次来找我看病。因为血液流失而贫血，她正服用铁。她的子宫肌瘤是次粘膜性的，它影响子宫内膜表面并常常导致严重流血。她已开始了个长寿饮食疗法，但是每月流血更严重。她服用铁，来保持有点少但不是特别少的血液数量。当我第一次看她时，她的子宫有 12 到 14 周孕期大，半年内缩小到 8 到 10 周大，我归功于她的饮食疗法。饮食疗法开始后几个月，她开始每周指压按摩治疗。她感到指压按摩比饮食疗法更有利。在随后的八年，根据她坚持饮食疗法的情况，比娅的子宫大小在 10 周到 20 周之间变化，它仅出现于绝经期前。我反复提醒比娅，她任何时候都可以选择肌瘤切除术与子宫切除术，但是她对做手术就是感到不舒服。就在绝经期前的三到四年内，当雌性激素水平以不规则形式上下波动时，比娅要求用孕激素疗法来控制她的严重流血。偶尔地，她流血如此严重以致吓坏了她的家人。尽管那样，她回避外科手术并逐渐进入绝经期。现在她发现子宫肌瘤迅速缩小——在一周之内就从 20 周大降到 14 周大！我跟踪治疗比娅的这整个十年，她都坚持自己的饮食疗法并坚守自己的回避外科手术的決定。她现在正进入绝经期，并为她月经期内的损失感到伤心。

绝经后，理论上激素药物治疗法会引起一个女人的子宫肌瘤再次生长，但是小剂量激素药物一般不会引起问题。

饮食变化 对于那些不愿采取药物与外科手术疗法而乐于此项选择的妇女，饮食变化是我的治疗法的支柱。因为子宫是对雌性激素敏感的器官，改变雌性激素水平的任何东西都会影响它（以及子宫肌瘤与子宫内膜异位）。有大量证据显示，饮食中尤其是高氢化与饱和的脂肪、高精炼糖、低纤维食物，能增加雌性激素循环。标准的美国式饮食正好是将一个女人推向子宫肌瘤、子宫内膜异位与乳腺癌危险之中的饮食。

一个把食用高度精练、营养差的饮食（包装食品、甜饼干、白面包、油炸土豆条、糖果以及意大利面制品）改为吃水果、蔬菜与其他食品的女人，常常会经历流血减少、较少肥胖，甚至子宫肌瘤缩小。许多妇女开始时渴望试一试这个方法，她们知道，如果这个饮食疗法不起作用，然后可以做外科手术。

我常常建议三个月的试验：**高纤维、饮食全面、清除精炼糖、面制品与奶制品**。用于治疗子宫肌瘤的饮食在一段时间内必须很严格，由此减少雌性激素。亲脂性的东西**蛋氨酸、胆碱与肌醇**（每天各 **1000 毫克**）都可用作饮食补充物，它们至少含有 **600 毫克镁**，同样级别的维生素系列以及其他营养。

绝大多数通过饮食法治疗子宫肌瘤的妇女，在饮食疗法开始后的三到六个月内消除了疼痛与严重流血。饮食全面使子宫肌瘤休眠，也就是说，不能根治。骨盆内的能量闭锁也必须被打破，能量应得到释放。事实上，我发现依靠非常严格的长寿饮食法的妇女，其子宫肌瘤实际上生长了。这些妇女通常有尚未解决的早期问题，如乱伦、或者嫁给一个虐待狂。

释放闭锁的能量 当这些方法由受教育好并且天赋好的人来做时，非常有疗效。

虽然子宫肌瘤在针刺疗法、指压按摩、极性疗法与按摩这些治疗方法中通常不会缩小，但是它们通常对子宫肌瘤症状有好的效果。

我对顺势疗法医学没有经验，但是使用它的从业医师指出，采用正确的顺势疗法可以使子宫肌瘤缩小或消失，而且症状减轻。顺势疗法医学是一种自然医学，现已被广泛接受。

中国针灸文化指出，它常常采用上百个或更多的日常疗法来消除大的子宫肌瘤。日常疗法需要病人与医生双方认可。

一个被称作 **NAET**（耐姆布德里波德过敏性消除技术）的新疗法，被用来治疗子宫肌瘤与其他各种疾病。**NAET** 是由德维·耐姆布德里波德发展的，他是一个自己就有严重过敏症的针灸专家与推拿治疗专家。它的基础在于假设过敏症（及其他疾病，如子宫肌瘤）是最初在大脑与身体同时发生的过敏性或情感反应的结果。使用 **NAET** 疗法的从业医师用一种被称作运动疗法（肌肉测验法）的方法，准确确定冒犯性变应原与附属的情感模式。然后，用特别的指压按摩法或针刺疗法，这些模式在身体上是清楚的。这些技术的哲学基础有很大意义，如果是由熟练的从业医师采用，我就推荐它。虽然他们常常不与正规医疗界结为一体，但是在美国与海外的每一个社区几乎都有整体上受重视的此类从业医师，正规医疗界一直对他们持怀疑态度并很少把病人推荐给他们。

治疗子宫肌瘤的计划

二十烷类平衡的营养全面的饮食：至少三个月不吃奶制品，饮食中绿叶蔬菜充足、多吃豆制品与十字花科蔬菜。

营养物质补充物：补充多种维生素矿物质，包括：**B** 类维生素亲脂性的蛋氨酸、胆碱与肌醇，每天大约各 **500** 到 **1000** 毫克。

含 2%孕激素的软膏：在月经期到来之前的两到三个星期内，每天一次或两次四分之一到二分之一茶匙，控制过量的雌性激素的影响。

增氧型健身运动：每周三次，每次 20 分钟。

按摩、太极拳、医疗、针灸：增强骨盆内的能量流动。

海狸香油包放在腹部下方：每周至少三次，注意在治疗过程中出现的想法、意象与情绪。

日记：记下生活中你愿创造的任何事情。看看你能搜集多少热情与能量，仅仅通过想象使你的创造才能或者秘密的“自我”充分展示会是什么样子。记下你在这过程中有障碍的地方。它们通常表现为“是，但是”的判断形式，如“是的，我喜欢定期做漂亮的衣服，但是我无法获得时间。”你不久就能区分正在阻碍你的创造性的限制性信仰是什么。

至少花三个月试一试这个计划，然后做必要的调整。每个女人的需求不一样，因此你必须将这个计划个性化。看看从你的身体中学到什么，你的身体对这一新的饮食起居制度有何反应。听取你身体的信息。

子宫肌瘤就像其他紊乱一样，不是无缘无故地长到你的子宫上的。当你愿意通过让子宫向你传达信息来与其相处时，你就迈出了治愈而不是掩饰或清除症状的第一步。你与子宫的信息保持联系后，你能选择对你最有效的治疗，不管它是外科手术、饮食疗法、针灸治疗法，还是这些方法的综合。

许多妇女能将子宫肌瘤的袭击与来自伙伴的口头谩骂、工作压力或与外界关系中的其他问题的袭击联系起来。内心活动对于发现解决这些有害的或限制性的情形的新方法常常是有用的。

肖丽：子宫肌瘤与创造性 肖丽是一个 45 岁左右的护士，在年检中被诊断出有一个小子宫肌瘤时，她已经经历了月经失调与经血过多。在此之前，肖丽已为饮食紊乱与依赖性治疗了一年，当我诊断出她的子宫肌瘤时，她正处于改变职业的关头，要决定是否离开令人窒息但赚钱的管理工作。

我建议她吃低脂肪、高纤维食品，并且用海狸香油包。我也让她想想确实想做什么，她发现什么真正让人高兴。当她思考这些问题时，她明白了，她的创造性已经在工作中窒息了。她问她的身体正告诉她什么，以及在梦里或冥想中向她展示什么。几个月后，她告诉我：“我学会供给自己治疗能量，喜欢使用海狸香油包、冥想与医疗。”

她用雷基疗法，这是一种类似于治疗触觉的能量疗法，包括用手治疗。在她与我见面后两个星期，她说：“我看见女按摩师从我的肚子里举起一个保龄球状的幻影。她让我画下它，我画下来的看起来像一个毛边，在树林里你会在你的袜子上见到的那种毛边。上面正好有 45 个穗。（肖丽 45 岁。）我的幻影、毛边，代表了我以及我怎样以不健康的方法坚持做事。它象征死守的工作与想尽力找到满足感的人们。从我的梦与冥想中，我懂得，我的子宫生长是我自己的创造性的物理表现形式。通过我的感情与物理治疗过程，我的子宫肌瘤减小，我被引到一个更富创造性、令人满意的直接关心病人的工作中。”紧接着的三个月后的检查显示她的子宫更小，我找不到子宫肌瘤。

玛莎：在社会生活中感到无助 玛莎，一位没有社会地位的按摩师，1986 年第一次来看病，当时她 41 岁，来为她的子宫肌瘤寻求第二种意见。虽然她的子宫只是中度扩大，达到怀孕 12 周那么大，她没有症状，但是她被告知应该做子宫切除术。她的母亲也有子宫肌瘤，并做了子宫切除术。玛莎想回避外科手术。玛莎已因吃得过多以及卷入与虐待性男人的有害的关系中而错过治疗。她流产三次，没有孩子。当她第一次来时，她已开始了一个长寿饮食疗法来阻止子宫肌瘤生长。

因为在超声波检查中其他情况都正常，所以我肯定了玛莎的用改变饮食治疗子宫肌瘤的选择，并建议她每隔三周去看一次她的妇科医生。考虑到她的悟性已变成她自己的行为模式，我认为她应该同时选择外科手术。在她的家乡，她遵守了治疗计划。

四年过后，她回来看我，因为她有过几次严重的流血，她的医生强烈建议做手术。玛莎正在按“莫名的性与爱成瘾者”十二步治疗计划进行治疗，她告诉我说她刚摆脱与一个男人的很不健康而又使人成瘾的四年之久的关系。虽然他们两人都同意结束关系，但她一直完全着迷于这种关系。她告诉我她已开始意识到“我对我从前的男朋友的所有气愤已成了回避依靠自己做事、我的感情与我的过去的一条理由”。现在她开始对自己的生活与情况负责，并进行自我治疗。通过她的恢复性工作，她发现了童年以来就存在的所有人际关系，有一个酒鬼父亲，有机能障碍。她承认她很擅长在生活中创造戏剧来填补内心的僵硬的感情空虚，来弥补与自己身体的沟通不足。

玛莎只是刚刚意识到她的人际关系与自我意识间意义深远的联系，以及它们在身体里如何表现。她知道不是子宫肌瘤的所有方面都与食物有关，但她还是用食物来覆盖感情。某一天的一段时间里，她的恢复逐渐把她与她的内心智慧联系起来。当我在 1992 年检查她时，她的子宫肌瘤大小稳定，她的月经期正常。她已进入治愈期，这对许多女人来说有时是必需的，尽管不是所有的：她认为需要从男人那里撤回来一段时间并主要是与女人在一起。我每次看她，她精神更集中、更积极并更坚强。她明白她的子宫肌瘤是一个信号，呼唤她回到自我与自己的生活里。

路易斯：孩子与损失 路易斯是一个在她的健康保护中愿意采取伙伴关系并不怕表达自己观点的女人，是一个广播电台的节目制作者。她来找我，寻求关于她的子宫肌瘤的外科手术的第二种观点。在她的第二个女儿决定离家去寄宿学校后，她的子宫肌瘤很快发展了。她来找过我之后，给她的曾建议做子宫切除术的妇科医生写了下面这封信。

亲爱的×××医生：

在你的推荐下，因为我的子宫肌瘤我去寻求关于子宫切除术的第二种意见。让我告诉你我的过程背后的故事，希望你能广泛合作，对那些将来患子宫肌瘤的其他妇女减少常规治疗法。

首先，对你的外科手术的提议我感到被无力地一击。突然间，我开始认为自己有病。但是我的心告诉我，“不，你没有事。”因此我听取了我的心声。我开始找我能读的关于子宫肌瘤的任何东西，尤其是介绍代替外科手术的方法的书与文章。我了解到在这个国家每年有多少不必要的子宫切除手术被实施，而且我了解到重大的、通常是长期的手术后的问题。

即使是关于子宫功能的很小的探索，尤其是绝经期后它对整个身体健康是不可分割的建议。化学激素不能代替女性器官的极好的功能。

于是我决定保留我的子宫——不仅仅是因为身体原因。你没有问我关于我的感情、关于我的家庭或生活方式、或者关于子宫切除术会怎样影响它的任何事情。

我的两个漂亮的女儿在一年之内都离开了家庭。我的 19 岁女儿上大学二年级，我的 15 岁女儿在她的坚决要求下已去了佛蒙特州的私立学校，虽然我支持她们，但是对于两个女儿在这么短的时间内同时离开家庭的母亲来说，同时也是一个主要的生活调整。我的孩子走了，她们是我的子宫的产物，然后你告诉我应该把子宫也切除掉。不，谢谢你。我将暂时保留它。我也希望永远保留它，如果我有致命的子宫疾病，我可能感觉不一样。

所有这些对你来说可能听起来古怪，但我深信，我们将疾病带进了身体，我们也能治愈它。我劝你花一点额外的时间听听你的病人的全部故事。如果我没有怀疑你告诉我的，我可能已成了那些不必要的子宫切除术的一个。可能它会容易地消除严重的月经期流血，但是它将以此为代价——花钱、失去工作、长期的激

素替代疗法以及长期的心理伤害。

请把所有的选择介绍给你的病人，并给她们考虑的时间。

你的忠诚的露易斯·T

露易斯的妇科医生是不寻常的。我们医生们没有接受听听病人的关于她们的疾病对她意味着什么的感情的培训。拉里·杜西医生，在他的《意义与医学》书中，讲述了富兰克的故事，他是一位胸部疼痛的病人，他承认他的冠状动脉需要细心保护。富兰克能够通过考虑他的胸痛对他意味着什么来随意改变心率。他告诉杜西医生，如果他让疼痛意味着心脏病，他马上焦虑地思考他受伤害的心脏、堵塞的血管、失业以及又一个心脏病的可能。但是如果他胸痛仅仅意味着肌肉痛或者消化不良，他感到缓解了而且心率下降。杜西发现富兰克的心脏监控器扮演了一个“意义表”的角色。对于子宫肌瘤也是一样。

在露易斯第一次来见我之后七个月，当我见到她时，她在另一个州找到了工作，在一个广播电台，在那里她的工作真正受到重视。她明白了两个女儿离开家庭的损失以及她在花时间为她伤心。当她在这个新城市采访时，她明白她与丈夫的关系多年没有履行——只是为了孩子们他们才真正待在一块。她清楚地看到了这一点并开始打算离婚。然后她遇到了一个新爱人，她从未梦见过的事情发生了，这种关系证明她非常性感而有意义。她对自己的饮食改变很大，而且停止吃奶制品。当我检查她时，子宫肌瘤几乎完全消失。她基本上改变了她的第一与第二能量中心的力量。

鲍拉：子宫肌瘤与流产 我偶尔看到妇女的子宫肌瘤会与一次流产或多次流产有关。当我说“有关”时，我不是说“被引起”。在反复研究中，流产与对身体不利的物理影响没有联系。流产后妇女有的任何问题，与在她们的生活里以及在她们生活的社会里的流产的意义有关。

鲍拉在 1987 年 36 岁时因年检来找我看病。她在十几岁与二十几岁时有过三次流产，没有孩子。除了关于这些我不知道她流产的具体情况。在她三十几岁的时候，她的子宫肌瘤病恶化了，她至少遭受了五年之久的下腹疼痛之苦。当我见到她，她感觉很好，很健康并感到她的康乐与下面的故事有关：“在经期和下腹痛之间我有越来越多的月经流血问题。由于我对外科手术或激素治疗的前景感到不乐观，所以我去找了一个土著医师。他告诉我应该释放出人性本质的精神，这种精神其实在我流产前就一直伴随着我。他对我施行了一种释放的仪式，使我确实清楚地看到并感觉到了一对白色的翅膀从较低盆腔中飞起，并且飞走了。我伤心地哭了好几个小时，感觉放松了许多。从那以后，我的月经期就正常了，从此再没有感觉到过一天的疼痛。”

对于治疗方面，鲍拉的故事是证明感情释放力量的戏剧性的例子。尽管我仍能感觉到，在她体内有大约八周大的扩大的子宫肌瘤，但对此并不需要给予超出常规检查的更多关注。她告诉我能把自己的故事讲给医生听是一种释放，尽管她确信大多数医生都会嘲笑她，认为她胡说。当然，这就是为什么医生们很少听信这类奇怪的故事并从中寻求治疗患者的方法的原因。这些故事很普通，然而由于专业医生的怀疑和无益的施惠，它们总是被当事人保密。真正的治疗，并不仅是治愈身体或抚慰我们的精神焦虑，还包括精力和意识领域的转换。在我刚才描述的女人当中，康复的部分原因是由于每个女人都能从她的子宫肌瘤、月经问题或其他症状中创造出新的意义。科学家们可以根据各自喜好争论我的建议是否可行，但对我而言，卷入这种争论意味着参与到了一个令人着迷的体系当中，它会对我们的治疗过程发挥无限的作用。

第七章 卵 巢

……她因对卵巢的理解而歌唱，一种发自躯体深处的理解，发自思想深处的理解，发自灵魂深处的理解。

——克拉里萨·平克拉·埃斯蒂斯

从能量医学的角度来看，女性的卵巢类似于男性的睾丸。因为它们实际上代表了世界上同样的东西，所以卵巢可以被认为是“女性球”。当一个男人到外面的世界去从事需要他花费一些气力的活动，或展现他支配外部世界的事物或人所需要的勇气时，人们会称他为“有勇气”。对于一个女性来说，走到外面的世界，尤其是一个由男性支配的世界，也需要“拿出勇气”，所不同的是她必须用她的卵巢所赋予她的能量。她不应该去模仿男人，否则的话，她与外部世界的关系就会影响她的卵巢及其能量场的正常工作。为了保持一个健康的身体，她需要知道怎样运用自己的“球”去提高生活的质量。

我们的卵巢智慧代表着我们最深层的创造力，如果条件成熟，这种创造力便从我们内部产生；也只有通过我们自己，通过我们独特的创造潜能——特别是当这一潜能和我们在外部世界创造出来的东西相联系的时候——这种创造力才能产生。从生理学角度讲，当女性排卵时，卵子向精子发出一个信号，从而把精子引向自身。卵子只是等着精子的到来，它并不主动去寻找精子。这种生物过程的结果是产生婴儿。婴儿自身的生命和意识与母体的生命和意识既连接又分离。她不能靠自己的意志使婴儿发展得更快，也不能靠自己的意愿决定婴儿的出生时间。一旦孩子出生，她必须承认它已经成了一个独立的生命个体，并且将保持下去——尽管它是由她的肉体 and 血液孕育产生的。

与此类似，出自我们自身深处，源于我们卵巢智慧的创造——不管是婴孩、书还是艺术作品——都有其自己的生命。我们有义务促使这种生命的产生，同时

也有义务允许它独立。为此，我们不能迫使我们最深层的创造力产生，而必须给予它时间和空间，使它的生长和发展与自己内在的节律相一致。像生理过程中的母体那样，作为女人，我们必须认识到创造及产生这种创造的能量和冲动的独特性，而不能试图强迫它们成为预期的形式。屈服于我们的创造力，承认我们不能通过我们的心智去控制它，这是理解卵巢力量的关键。我们允许这种力量在我们自身生存和发展。

社会试图通过规定期限（注意这一词汇的含义——有时时间因素简直可以扼杀我们的创造力）、限定配额、决定生产率等干预因素控制创造力。我的一位同事曾作为研究员助理在一个实验室里做科研工作（她一直坚持说有一对健康的卵巢）。实验室主任总会告诉她要做的具体内容。比如有一次，他想让她制成一个叫做类脂素的人造细胞。只要她根据预先的指导，试图通过她的意志和才智强行控制实验进程，实验就会失败，人造细胞不能使用。她感到很沮丧。后来，她的眼光超出了实验室主任的具体指导，她问自己：“在这种情况下我想了解的是什么呢？我怎样才能通过这一实验发现有关一种生命形式的更多东西呢？这一实验能教会我有关细胞的什么知识呢？”当问这些问题的时候，她联系到在实验中与此有关系的诸多可能性。这样，无论是在关于类脂类细胞实验还是在其他的实验中，她都能设计出一种比预期获得多得多的信息的实验模式。最终的实验结果从来不和主任要求的完全一致，但通常是更有价值，更充实。在类脂细胞实验中，我的同事最终创造的不仅仅是一个人造细胞模式，而且是一种富有潜力的、能被用来制造抗严重疾病的疫苗的实验设计。同时，实验室主任也为她的实验结果感到吃惊，最终允许她独立设计实验。她的科研工作做得很好。通过运用自己最深层的创造力，她使自己的实验具有创造性并使与此有关的每一个人都受益。这是女性创造力发挥最好的一个例子。在日常生活和学习中我们也能够做到这一点，只要我们总能考虑到一项任务和其他各项任务是怎样联系的，并且记住我们内部机制的关联，记清一个行为怎么样产生或促使另外一些行为的产生。

解 剖

卵巢是位于子宫两侧输卵管正下方的小长椭圆形的珍珠色器官，负责产生卵子。当女性在母体中还是仅 20 周的胚胎时，她卵巢中的卵子数量是其一生中最多的一一大约两千万个。从那一刻起，她的卵细胞就开始减少。甚至在出生前，我们的生殖生物钟就已经开始敲响了。

从大约十四五岁开始，卵巢大约每个月产生一次卵子，有时早一点儿，有时晚一点儿。女孩子第一次经期到来之后，过二三年时间月经才能归于正常，这就像在更年期一样，要等上数年月经才能完全停止。因为每次月经总会在卵巢内产生一个小囊肿，所以卵巢内有小囊肿区也很正常。这要么是新近制造卵细胞的结果，要么是月经之后所致。每个月卵子开始发育时，在它周围就会形成充满液体的滋养区，使它包在囊中或者和卵巢的其他部分隔开。这一充满液体的囊肿区的形成从生理学角度讲属完全正常的现象，但对此许多女性并不抱有好感。月经时，卵子被释放出来，并首先进入输卵管，囊肿的突然产生实际上是月经过程的一部分：囊肿周围我们称作卵泡汁的液体随着卵子一起流到盆腔内。

月经过后，在卵子存在过的地方，另一种被称作黄体素体的小囊肿区发育并开始分泌孕激素。黄体素体最终被卵巢重新吸收。新的卵细胞不断发育成熟，小囊肿不断形成，但在这一区域月经不会发生。在这种情况下，一个小囊肿会在卵巢的这一区域停留一段时间。正由于这种每月一次的卵子发育和囊肿形成过程，对于女性来说，在她的生殖系统发育成熟之后，卵巢内总会有小的充满液体的卵巢囊肿存在，这是完全正常的。实际上，卵巢中几乎常常存在着小囊肿。

当一个女性由于慢性下腹疼痛或长了纤维肌瘤或由于其他原因而对骨盆进行超声波检查时，在卵巢内就会发现这些囊肿。直径一到三厘米大小的囊肿几乎总是正常的，因为产生小的、有其形成和消失过程的生理囊肿是卵巢正常功能的一部分。卵巢产生小卵细胞、小囊肿——或者用能量内科学的术语讲，产生具有成熟潜力的初期能量。

在生命周期的全过程中，卵巢产生激素，包括雌性激素、孕激素和雄性激素

——虽然根据女性的年龄，这些激素的量也会发生变化（不一定减少）。雄性激素是一种和性欲的产生有联系的激素。过去这种激素一直被认为几乎完全是由肾上腺这一位于两肾上端的内分泌腺产生的。但是，在过去的 20 年中，不同的研究已经发现，更年期前后卵巢都会产生一定量的雄性激素——可能占身体全部供应量的 50%。

通常认为，当女性停经之后，卵巢从根本上来讲已不再起作用。但现在，卵巢在生命中第二阶段所起的作用正被重新评价。一些研究表明，卵巢不能实行外科切除，因为在停经之后的数十年里它一直保持产生类固醇激素的能力。当女性到 30 岁时，她卵巢的一些部分的确开始缩小，平均到 45 岁之后，其质量的确迅速失掉，但这些失去的并不是它们以往被认为的惰性纤维组织体。

当女性年龄增长时，她们的卵巢只有部分萎缩，这部分我们称作外皮。外皮是卵子得以生长发育、生理囊肿得以形成的卵巢的最外表。女性到中年时期外皮开始萎缩，但卵巢的最里面被称为内部间质的部分却在其生命中第一次变得十分活跃。换句话说，当一种功能趋于停止的时候，另一种功能也就开始发挥作用了。到现在为止，对这一过程的研究还远远不够。在生命的第二个阶段里，女性的卵巢仍然产生相当多的被称作雄素酮的激素，这是一种雄性激素。这种物质通常在我们体内的脂肪层中被转化成雌素酮（一种雌性激素）。研究表明，甚至在停经之后卵巢也能产生孕激素和雌二醇。这些激素对于预防骨质疏松，保持能量和性欲很重要。

直到最近，更年期疾病一直主要被当做“缺乏性疾病”（缺乏某种维生素所发生的病症）。因为人们对更年期所持的这种态度，科学家研究这一自然过程的目的只是去发现人身体内缺少了什么。如果去研究卵巢被认为仍起着积极作用的更年期之后的女性，随着研究的进展，我们很可能会发现卵巢在维持我们身体内部的正常机能方面起着越来越多的作用。我们应当觉察到，卵巢在我们一生中在维持正常的生理平衡方面，是我们身体产生智慧的官能器官，而不是在我们超过 40 岁时的一种无用的，甚至对于我们有潜在危害的东西。

一些古老的传统就已验证了这一观点。在道教文化中，人们认为卵巢内存有大量的能够不断产生性欲的生命力量。一个人可以学会用一种特殊的“卵巢呼吸”练习去释放由卵巢产生的生命力能量，而她同时可达到一种更高层次的意识状态。卵巢的性欲能量由此而转化为“气”（生命力能量）和“性”（完全的精神能量）。学会卵巢呼吸和其他的道教的深思方法要花费时间，还要受戒律的约束，但即使仅仅知道除了繁衍后代之外卵巢还有一种特殊的能量和功用，就能起到精神上的医治作用。

当一个女人由于对外部世界的恐惧和不安全感而注意不到自己深层的具有创造潜力的智能的时候，卵巢就会发生病变。这些病变可能发生在她认为自己被外部力量控制或非难的时候。外部世界中经济上的或物质上的威胁会影响到卵巢，尤其当该女性认为自己没有办法减轻威胁时更是如此。这样，一个女人如果被同伴冷落或者因工作感到压抑，若她觉得她不能摆脱这种处境，觉得“外部的”世界在妨碍她改变自己，她的卵巢就可能发生病变。生活上的压力可以导致子宫发生病变，它也同样可以导致卵巢发生病变。子宫病变和卵巢病变通常是密切联系着的，但它们之间也有区别。促使一个女人子宫发生病变的最初能量是她的内心深处的一种知觉：她认为自己不能或者不应该，或者不需要把她自己从限制她的境遇中摆脱出来或去找出一种能够帮助她的解决办法。子宫和第三能量中心及自尊密切相连。当一个女人身体上的或精神上的不安全感使她不能充分发挥自己创造力的时候，子宫就会发生病变。在这些情况下，她觉得自己缺乏发挥创造力的内在因素。换句话说，这种认识是她强加给自己的。

另一方面，子宫病变源于女性认为她外部的环境和人在阻碍她创造力发挥的这种知觉：外部的环境和人是使她产生这种认识的因素。多余的能量影响的只是她的卵巢，而不是子宫——这种能量来自报复的欲望和愤恨的情绪。第二能量中心是我们身体传统上携带刀枪这类的武器或钱包的部分。当一个女人动用自己的感情武器，沉溺于过分挑剔或报复的时候，受危害的是她的卵巢，而不是子宫。

卵巢的良性生长与癌变的区别之处也仅在于掺杂于其中的情感因素的程度。

一个女人卵巢的区域的癌变也和对男性权力认同的迫切需要相关联，这就像她最后才考虑自己的感情上的需要一样。一位因卵巢癌变而陷入绝望境地的女性可能感到她没有足够的经济上或者其他方面的力量去改变当前的悲惨境地。与可能潜伏几年的宫颈癌相比，卵巢癌可能由于突然引起的社会心理创伤——比如一个亲密友伴的离去——而迅速发展。

我有一个朋友，当她开始意识到自己的工作不如意，并且和丈夫之间的关系不能维持的时候，在她卵巢中长出了一个囊肿。在此期间，她丈夫也开始有外遇。治疗卵巢囊肿的时候，她开始意识到她日常生活中的问题才是她真正必须对付的问题。她精神上的种种不满足之处凝聚到她的身体上的一点。她身体上这一点所产生出来的智慧促使她把注意力放到自身。她需要呵护自己了。

我的一个病人比弗利有长期的子宫内膜异位症，我遇到她时，她的右侧卵巢已在四年前因为良性肿瘤的生长而切除。第一次来见我时，她不停地抱怨左侧卵巢引起她间歇疼痛。她担心这个卵巢也要被切除——她不愿意这样做。她才 32 岁，不想用人工合成激素代替自己体内产生的激素。她准备发挥自己最深层次的心理调解来医治。超声检查发现她卵巢里有一个小囊肿，这正好和卵巢子宫内膜异位相一致。凭着医生特有的直觉，凯瑟琳·米丝最后确诊说，为了满足家人的需要，比弗利一直在扼制自己的创造性的需求。她对自己享有很大权力的行政工作感到愤愤不满，这一工作占用了她每周大约 70 小时的时间。

凯瑟琳告诉比弗利，她每天至少留给自己一个小时做一些创造性的工作。在这段时间里，她要彻底放弃只求量的这种想法。她应该凭自己的创造力之源泉流淌。比弗利经常喜欢织些东西，在女红方面颇有成就。她开始每天坐下来做些看上去很不错的小洋娃娃，用她的话说，这些洋娃娃“每个都有自己的生命”。她告诉我这些洋娃娃会要求她把它们做成什么样子，给它们穿什么衣服。当她第一次带着几个她做的洋娃娃到我的办公室时，对她的创造我简直吃惊坏了，并欣然给我的女儿们买了几个作为圣诞礼物。由于她留给自己时间去做些创造性工作，她骨盆疼痛的症状最终消失了。而当她放弃自己的这些工作，忙于应付外界需要

的时候，这种阵痛就开始发作。她的卵巢成了她自身的一个晴雨表，通过不断发出“声音”，告诉她，其内在的创造力被发挥到了什么程度。她已开始改变自己全部的生活方式。她做出的洋娃娃也继续发展变化着。

卵巢囊肿

作为女人，我们就意味着在生命的全过程中要发挥我们的创造天赋。当我们自己生长发育的时候，我们所创造的东西也会变化、发展。我们的卵巢也总是在改变、组织和重新吸收着这些小的生理囊肿。只要我们发挥我们自身深处的创造之源泉，我们的卵巢就会保持正常。当我们的创造力被以某种方式抑制，不正常的大囊肿就会出现并保持下去。产生卵巢囊肿的能量阻塞可能源自紧张。这种紧张不一定是由消极因素产生的，比如说一个女人可能有一份她喜欢的工作，但可能有时因此而忽视了休息，囊肿就会由此而生。

身体的左侧代表的是女性、艺术、思考的一侧，而右侧则倾向于分析，属于男性的一侧。令人吃惊的是，这些区别在大脑中与卵巢相联系的区域反映了出来。每个女性可以自己决定其中的含义，但是我看到大多数卵巢囊肿是在左侧——我觉得这对于在我们这一文化中受到伤害的女性来说具有象征性。许多女性试图模仿男性在世界上的存在方式，这常常不适合她们的内心需要。当和凯瑟琳一起进行我的第一次能量诊断时她告诉我，如果待在以前的医疗组，我就会在第二年内长出非生理卵巢囊肿，这很可能需要医生诊治。它早在我体内能量场内开始形成了。一般来说，对于闭经前的女性，直径不超过 4 厘米的囊肿被认为是正常的。参与月经过程的胞囊被称为“官能性囊肿”。如果囊肿直径超过 4 厘米，我们可以观察几个月，看看它会不会消失。正常的囊肿可能含有液体、血液与由卵巢表皮或卵巢体组织组成的细胞碎片。

症状功能性卵巢囊肿

滤泡囊肿 许多囊肿长到直径超过 4 厘米，并且两三个月经周期后继续生长，这些囊肿实际上是官能性的。当滤泡这一卵子在其中生长的生理囊肿不再生长并且正常放出卵子时，这样的囊肿就形成了。这种现象发生时，卵巢囊肿的生长时间可能在月经时间之外。它有时会长到直径达 7—8 厘米并可能伴随着疼痛。通过超声观察会发现，这些囊肿是单胞、薄壁类，也就是说，它们是由包含在一个薄细胞膜中的单种液体聚集而成。它们通常自己消失，但也有一些会一直存在，并且需要能量。尽管一些医生开一些避孕药来抑制月经过程，使囊肿退化，但是新型的低剂量雌性激素避孕药不含有足够的激素（这些激素可以通过降低卵巢官能而影响胞囊）。

黄体囊肿 另一种官能囊肿是黄体素体。黄体素体或黄体囊肿是成熟的卵细胞在月经过程中从滤泡中流出时形成的。在卵子从卵巢释放出时，这一过程有时伴随着少量的血液流到卵被囊的月经区——有时也流进盆腔。

有些卵巢囊肿不表现出任何症状，而另外一些会导致疼痛。这种疼痛可能很剧烈，有时像刀割一样——比如说，如果囊肿胀裂，其内的物质流到盆腔中时。要么表现为疼痛不易觉察，只有当它变成慢性症状时，疼痛才能感觉到——就像卵巢内膜炎发作时。轻微的疼痛有时伴随着月经的发生，这是由于血液流入盆腔所致。这种疼痛称作“间痛”。血液流进囊肿腔或盆腔往往会因拉伸了卵巢被囊（卵巢表面的组织）而导致疼痛。这种疼痛可能持续几分钟，也可能持续几天。如果血液流进胞囊壁的时间超过几个小时，黄体就会变成我们所知道的出血体，意思是“流血的胞体”。出血体可能持续几个小时甚至几天，有时会导致异位（输卵管）妊娠。这也可能伴随着阴道流血。出血体通常自行消失，但它会导致几天的疼痛。在极少数的情况下会流血不止，这要求助于医疗手段——通常是通过剖腹镜——来解决。一般情况下通过这一措施会止住流血，而不必摘除卵巢。

大多数功能性囊肿是通过盆腔检查，然后再做超声波检查诊断出的。通过检查两侧卵巢并作比较来断定症状是由卵巢囊肿（而不是由其他的东西，比如说纤

维肌瘤)所致。

两种功能性卵巢囊肿——滤泡囊肿和黄体囊肿——都不会发生癌变。一些女性经常会有这两种囊肿导致的症状，而一些女性在一生可能只有一次。我们要记住的是，这些囊肿长出来只是几小时或几天的问题，因为我们的身体能够迅速地产生出卵巢囊肿。

良性新体素囊肿 因为卵巢含有能够长成人的细胞，它也同样含有能够长成多种胞囊和肿瘤的细胞，这反映了我们巨大的创造潜力。当我们的创造性潜力被抑制时，这一创造性能量就会通过我们身体某些方面的变化来引起我们的注意，并且在卵巢里以物质的方式表现出来，而不是毫无觉察地通过我们的身体逃逸到外部世界。传统医学教育认为，要么卵巢囊肿的成因是“官能的”多样化的表现，且与月经相联系；要么不为人知。

当不参与月经的卵巢细胞开始再生时，良性的、非官能性卵巢囊肿就会产生。“Neoplastic”常被用于描述这些或其他的新生物——包括良性的和恶性的。“Neoplasia”意思是“肿瘤的形成”？

其他囊肿 除了滤泡囊肿、黄体囊肿、出血体囊肿和良性新体素囊肿外，还有一些囊肿质地坚硬，两三个月经周期过后仍不消失，这种囊肿被认为是由于月经以外的原因所导致的卵巢肿瘤。它们还需要进一步研究。也许可以通过手术解决，因为医生只有切下一部分组织，放到显微镜下观察才能断定囊肿是否为良性。我曾有过这样的病人，她们的卵巢囊肿在盆腔检查时没有任何变化或产生任何症状。这些女性凭以往的感觉，认为不去看医生是在冒险。有一些人甘愿冒此危险而数年不去检查、诊治她的卵巢。尽管我所接受的医疗知识并不赞同这一方法，并且我也总是对病人提供一些传统疗法，但我对有足够的信息却不去求医的成年人的决定持欣赏的态度。

多囊卵巢

许多女性会出现多囊卵巢的情况。所谓多囊卵巢是激素疾病的一个信号。由于受女性感情、思想、饮食和个人历史的强烈影响，多囊卵巢是一种很复杂的疾病。

医生过去常把多囊卵巢称作“多囊卵巢疾病”，但目前认为，多囊卵巢不是一种疾病，而是一种不明显的内部失衡的症状。它是一系列复杂的激素之间微妙作用的最终结果。有一些病例是遗传性的，因而在家族中蔓延，但大多数病例与遗传无关。传统医学不能解释多囊卵巢为什么及怎么样产生的，不过我们知道它和体内脂肪过多有很大联系。腰臀部分比例过大（苹果状身体）的女性更容易患卵巢官能紊乱。

与多囊卵巢联系的一个重要问题是女性的卵巢因此而不产生卵子。她的体内产生了太多的被称为雄性激素的激素，这最终导致她经期的停止或变得非常没有规律。在男性和女性体内雄性激素的出现是很正常的，但患有多囊卵巢的女性经常由于参与体循环的胰岛素浓度高而导致多囊卵巢浓度高于正常水平。这是女性应当了解的极其重要的一个联系，因为这种联系和其他许多疾病有关。血液内胰岛素含量高，会使参与循环的雄性激素增加，这反过来会增加肥胖病、糖尿病、心脏病、高血压及多毛症（脸部毛发过多）等疾病的发病率。慢性的雄性激素含量过高也会影响卵巢内正常的卵子发育周期，因而抑制卵子的生长和发育，使其不能完全成熟。当一个女人的正常激素周期因雄性激素过多而被抑制时，她和她的卵巢都不会有与正常卵巢功能相联系的自然周期变化。她的激素水平保持一种静态。这样，该女人的卵巢里含有由发育不全的卵子转变成的小囊肿。用超声波观察发现，卵巢看上去变大了，其表皮下有多个小囊肿（多囊卵巢由此产生）。

无月经症中身体与大脑的联系

我们知道，无论何时，当一个女人有和月经过程一样复杂的问题的时候，在她大脑中的月经周期规律机制可能也有问题。视丘下部受感情和生理因素的影响，比如紧张、由于过去而带来的抑制性疼痛，这都能造成月经周期的紊乱。因为无月经症的大多数原因在本质上是视丘下部的——意思是，它们与我们了解甚少的脑缩胺酸含量的和谐变化有关——所以视丘下部可能与多囊卵巢有关。患有多囊卵巢的女性，大脑中视丘下部激素的周期释放与月经正常的女性相比变化了。这种变化是卵巢病变的结果还是原因，我们还不知道。尽管紧张与患有多囊卵巢的女性之间的关系还没有被研究，但与官能性无月经症相联系的紧张可以给我们提供一个线索，让我们去了解女性的感情和个人历史是可以怎样影响其月经周期和卵巢官能的。这些线索对于患有多囊卵巢的女性也很适合（可参阅第五章关于月经周期的论述）。

已发现的抑制卵巢和月经周期官能的紧张包括作为女性的消极情感和卑微低贱的感觉。我发现，当一个女人在成长过程中被告知女性很低贱时，在某种程度上她是不想作为或“长成”一个女人的。对一些女性，这些负面情感可以在体内起作用，从而使月经停止，使其变成“半男半女性的”。事实上，雌性猴子的研究已经表明，在社交中感觉处于卑下地位的女人经常会发生月经困难。

研究表明，不行经的女人可能会紧张、焦虑、更具独立性、比有月经的女人更少脑力方面的创造性。她也可能对其母亲抑制自己的愤怒。有些人会有负罪感，害怕自己需要父母之爱和保护，也怕失去这种保护。当她们长大后，这就可能表现为无月经症——一种抑制自己走向成熟的企图。

治 疗

由于一般医生不明白多囊卵巢产生的原因，治疗的目的只是缓和症状，因此在当前，大多数女性被给予避孕片及如螺旋内脂和孕激素之类的抗雄性激素药

物，促使月经周期的产生。尽管这可能是有助的，但这些治疗并不是使月经及大脑中激素归于正常的有效手段。避孕药和孕激素也会防止子宫体内激素过多。因此，这些手段增加了子宫癌（子宫癌可能是由于没有月经而导致子宫体内物质的多年积累所致）的发病率。尽管避孕药和其他的激素药物治疗可以防止与多囊肿卵巢有关的症状的发生，它们却掩盖了问题的实质，并且永远不能解释最根本的原因。

过去，患多囊肿卵巢的女性通常摘除该侧的卵巢，这被称为“楔型切除”。这有时会导致激素水平降低（通过切除或摘除卵巢，其产生的激素也会减少）。在一些情况下，周期官能会恢复，而在另外一些情况下，手术会留下疤痕或粘连。现在很少采用这一方法。

对于希望怀孕的妇女，可以通过吃药产生月经。最常用的药是克罗米得（Clomid）。

患有多囊肿卵巢的女人可通过以下方法恢复正常的月经功能。

仔细省察你的思想。也许你在压制一种潜能——这种潜能使你发育为成熟女性。发掘使你产生这一动机的儿时因素。务必使这些信息带到你的意识之中，以便使它们不再控制你的躯体和你的卵巢。我有一位病人，在我见到她时的前三年她就被诊断患上了多囊肿卵巢。在她的思想深处，她有一种认识：作为女人，她很微贱——她曾被其父强奸过。她一直在压抑这一感觉。她潜意识中在责怪她的母亲没能保护她，并因此视女人为弱者。当她意识到这些因素，不再服用避孕药，并且开始为其女性的本来面目而感到自豪时，她的月经及月经周期在大约 6 个月之后恢复了正常。（我还要告诉她，多囊肿卵巢不可能在她一生中表现为慢性疾病。）

重建周期感情流。允许自己对生活中的事情有充分的反应。尽量在一次旅行中记录这些反应，去寻找你的感情和情绪的自然节律。它们和季节、时日及其他

周期相联系吗？在日历上记下月亮的盈亏之日。月经周期受月亮盈亏的影响，这是广为人知的。如果你居住在大海附近，去观察海潮的涨落。如上所述，只要注意周期的环境暗示——包括光线、月亮、潮水——你就能使月经周期归于正常。

通过与光及自然界的联系重建周期性的月经。尽量走到自然光里去。自然光影响视丘下部和垂体，并从而影响月经。每月用 3 天时间亮灯休息。买一盏全光谱电灯放到你的卧室——尤其在秋冬月份——也许更有益。

通过摄取丰富而全面的营养来平衡体内的胰岛素。体内过多脂肪的丧失会增加胰岛素的浓度并使胰岛素分泌归于正常，这也会使血糖含量趋于正常，使过多的雄性激素减少。成年后患糖尿病的女性通常用此法改善身体状况。

多补充维生素。良好的饮食习惯也会帮助一个妇女调节自己的精神和直觉力。这有助于重建情感流并能帮助女性使激素水平恢复正常及减轻多囊卵巢。

用 2% 的孕激素乳按经前综合征一节的指导帮助减轻雌性激素过多的症状。

下面的几个故事是我的几位患者如何利用了她们的卵巢改善了自己生活的实例。这些故事表明，妇女们已经认识到了她们的身体传达给她们的信息，并以此来改变自己的生活。对我们来说，这种信息最鲜明之处在于，它让我们注意到自己不自觉地参与其中并恋恋不舍的一种系统，在这一系统中我们接受外在的主宰甚于听从自己内在的指导。

盖尔：明显的操劳过度 盖尔多年来一直是我的好朋友。1989 年，她第一次到我这里咨询时已经得了很长时间的卵巢囊肿，最后，在 30 岁时，她被迫做了手术。这里便是她的故事。

“1984 年，在例行的妇科检查中，一个女医生发现了我左侧卵巢有大的囊

肿。在纽约市区，这个漂亮的医生告诉我，这个囊肿是危险的，应该尽快做手术切除。她希望我彻底休息四至六周。她，当然愿意让我做手术。因为切除它仅需15分钟。

“我吓坏了，彻底崩溃了。当时，我不知道自己为什么那么害怕这一消息。按照我当时的生活方式，我用增加工作量和提高生活节奏的办法克服了恐惧。我在1984年这样做是很容易的，因为，我那时在指导有关世界和平的群众性倡议活动。这使我能一个月中去世界几大洲旅行。除了以投入实际活动的方式克服了恐惧心理外，我还有了一种强烈的直觉，即卵巢囊肿既不急迫，也不严重，不像医生说的那样。我没有做手术。

“几年过去了，我真的没有太在意囊肿。我沉浸在过度的奔忙中，改变世界和许多人的生活，然而却忽视了自己。尽管这些对我来说是正确的和有深刻意义的，我却失去了自身生活的平衡。

“1987年，我父亲去世了。尽管他已80多岁了，领略了生活的所有乐趣，我还是无法消除这件事对我的影响。我体验到了一种精神上的危机。考虑到我顾及体面，一位朋友建议我去看一位医生，也许他能帮助我。与这位很好的医生的会面改变了我的生活。通过精湛的技艺和至诚友善的态度，他让我认识和治疗自身，我过去是害怕正视这些的。对治疗至关重要，我了解到了，我过去一直在背叛女性生活方式而一直站在男性生活方式一边。我生活中很大一部分都源自于自己绝对忠实地相信行动胜过存在、思维胜过感觉、外在世界胜过内在世界。社会集体对女性的背叛巨大的损害了我们的环境，与此相同，对我来说，我上述的信条就是对自身的深刻背叛。

“我开始体会卵巢囊肿，它是我个性中男性成分的一个生理现象，它导致我一直终日忙碌。我称其为‘过度操劳’。我如此地背叛自身深层的女性一面。引起了我体内囊肿的扩大，它已长得如同大葡萄柚一样。

“尽管我开始对囊肿有了清醒的认识，我还是在生理方面与其展开了斗争。我从未感觉到它——我一点也不痛。然而，囊肿已经出现，它在告诉我，体内一些东西已失去平衡。”

1991 年秋，盖尔来看我。她的多数超声波结果显示囊肿已再次扩大，而且内部结构发生了变化，变得更坚硬、更稠密。囊肿变得进一步坚硬意味着它的液体部分已被更多的细胞所代替，这些细胞在它的内部生长。它正成为一个实际的物质存在。我觉得她已注意它很长时间了，而这些变化意味着这些潜存的细胞将成为早期癌细胞（如果不注意体内病变部位的实际增长，它会明显地提醒你它在增长，而且会越来越明显。因此，它的增长是迅速的，而且有症状。非生理性的卵巢囊肿在外界环境的作用下有能力迅速增大）。盖尔已感觉到了卵巢囊肿的压力。我建议她做手术，因为我觉得持续的和时时变化的囊正在消耗着她身体的能量。正如我们所见到的，不健康的组织简直是在抽去邻近健康组织的细胞在新陈代谢时所需的分子（见第十章）。

咨询凯洛琳·米斯的结果进一步证实了我的怀疑。她说，卵巢囊肿开始“醒来”，并且开始活跃。在合适的环境下，它有能力迅速增长。她觉得，它会在三个月之内变得明显。她进一步证实说，盖尔卵巢囊肿的扩大是与盖尔的内心需要和外部世界的要求存在着冲突。米斯说，盖尔与她丈夫处在能量的两极。只有丈夫（她工作的伙伴和人生伴侣）在外部世界得到认可并达到顶峰时，盖尔才趋向安静，反映出她女性的本来特性。她可以在这一认可中同丈夫共享此种欢乐——如果她希望这样的话。而她强烈地感觉到趋向自己内部世界的需要和外部世界所需要的成功要求存在着竞争。为了外部世界的要求，她已拼搏多年。如果她不加入外部世界成功者的行列，我们的环境就会对她做出评判，认为她正在放弃成功。不管她的内部世界和外部世界的冲突如何，盖尔的深层卵巢正在前所未有地吸引她更多地面向自己的体内。这是能量和体内需要间相互竞争的典型实例。其中她的体内需要是由卵巢告诉她的。

盖尔同意由我为她做手术，她相信我。作为术前准备的一部分，她首先接受

了一组精神上的训练。这一过程包括一种有针对性的冥想，想象中她体验着手术。想象中，她男性的一面站在她的病床后面，防止她暴露出女性的一面。她回忆说：“我男性的一面走过来轻抚我的前额。手术结束时，我女性的一面拿着卵巢囊肿递给了我男性的一面，我男性的一面接过囊肿深深地向我女性的一面鞠了一躬。这对我来说是一个绝妙的想象。当时我想，通过这一手术，我体内一些很古老、很本质的东西将恢复平衡。

“在与我的女性一面合作，改变自身的防护系统时，另一位朋友引导我通过了术前几天的冥想。我与卵巢囊肿对话，我把它设想成像高尔夫球里面的东西。我告诉它，我将把它从‘过度操劳’中解放出来。我准备平衡我外部的男性一面同内部女性一面失衡的状态。我确实渴望着这种平衡能治愈我。

“在这第二种想象中，我同意查瑞斯打开我的身体，切除囊肿。我想象着自己已被切除了囊肿。我体会到我的体内有了很大的空间，青绿色的加勒比海沐浴着我，洗刷着我。在无限的青绿色中，我家的女性排着长队出现了：姐姐、母亲、祖母，后面还有许多人。她们感谢我已找回了女性的一面，为自己，也为她们。”

随着这些带有治疗性质的想象已灌输到她的头脑和内心，盖尔制作了一个对她很有意义的药袋。里面有一些以前给她的水晶，一些从海边带来的她喜欢的石头，她母亲和祖母的相片和一些小孩玩具。她把药袋包好，动身来到缅因州，在我所在的医院里进行手术。后来，她说：“我丈夫和我两个最要好的朋友术前术后都和我在一起。他们的出现形成了一个平静的、充满爱意的欢乐的氛围，在这一氛围中我的手术开始了。

“手术时我只感到细微的疼痛，这是麻醉药物所起的作用。我对这次惊险的活动有良好的感觉。两天后我出院了。在这两天里，我的身体开始了非凡的自愈过程。

“我正在享受进一步治愈的时光。它是这样的短暂，以至于我不能全部明白

我体内什么已发生了变化或者被排出了。我所知道的只是我曾面对一个我十分害怕的魔鬼，为此，我成了一位强者和富有的人。我知道，当我害怕的时候，我可以叫我的朋友来帮助我。我知道，我已经改变和平衡了我自身的一种古老的关系，即外部男性世界的要求与内部女性世界的需要。”

像盖尔所患的囊肿那样，在很多情况下，卵巢囊肿都很大、很复杂。健康的卵巢组织几乎全部被囊肿所代替。没有一种方法可分辨出健康组织和非健康组织。因此，全部卵巢都需切除。不管怎么说，盖尔接下来一直做得很好。她与卵巢囊肿的沟通，她的入院治疗，以及她术后的关照都是使更多的女性因素、直觉因素和营养因素进入生活得很好实例，这也是她从自己左侧卵巢那儿学得的。

玛利·珍妮：嫁给了工作。玛利·珍妮是个分子生物学家。她把所有的工作都贡献给了男性统治的大学。在高中时，她想选择物理和高等数学。但是，她父亲——一位物理学教授告诉她应该选择打字作为自己的职业，原因是这对她更有益处。和他同一时代的男人一样，他觉得女儿只能结婚、生孩子，接受高等教育对她是一种浪费。不容否认的是，玛利·珍妮最终在科学领域取得了很大成就，她所发表的研究论文比她父亲多得多。她曾结婚，但又离婚了，并且有一个孩子，她的婚姻对她来说一开始就是不满意的。因而，她开始将自己嫁给了工作。

玛利·珍妮过去好多年一直是我的患者。她经常从别的州赶来，到我缅因州的诊室进行年度检查。在一次检查中，我感觉她左侧卵巢囊肿已达七厘米，超声波检查进一步证实了这一点。她有意识地带着自己体内的病状进行工作。我告诉她，这一现象在提醒她一些关于第二能量中心的问题，尤其是她的人际关系和她的创造力。我建议她与自己的卵巢进行对话，看看它会告诉她什么。我的计划是在三个月或更短的时间内使她重新估价自己。

由凯洛琳·米斯做的能量诊断揭示出，卵巢囊肿里充满着愤怒，这是反叛性的愤怒。它具有“致癌能量”。不能把它等同于生理上的癌症，但是，它正在向那个方向接近。凯洛琳认为，囊肿应该尽早切除为好。尽管现在不是癌症，但囊

肿内愤怒的能量是巨大的。

经过米斯的解读，玛利·珍妮开始了与自己卵巢的对话。按她说的那样：“我发现它充满着愤怒、绝望和忌妒，但也有爱意。尽管我偶尔能感觉到爱意，但我无法把它表达出来。我需要一个地方释放所有这一切，我的卵巢正是这一所在。”

玛利·珍妮请了一段时间假。这之前，她听了米斯的警告后决定做手术。我肯定了她的决定，并告诉她不应当把手术看成是一种对自我治疗能力的放弃。手术确实是一个很好的治疗选择，但是，它要求她更进一步在各个方面改变自己的生活态度。玛利·珍妮的个人治疗问题将意味着，她要努力处理好与父亲、与工作的关系。

玛利·珍妮做了手术，一切都很顺利。囊肿是良性的。术后那段时间里，她仔细地检查了造成自己深刻痛苦的过程，并改变对父亲的苛刻态度，这是她从前一直在想而不能做到的。她认识到，她在渴求父亲的认可，而这种认可从未得到实现。正是这一点造成了她与男人关系不令人满意，这也影响了她的工作和与同事的关系。她认识到，她应该让父亲从她的希望和要求中解放出来。她认识到，她过去在把研究工作当成获得同行认可的手段，而不是乐意于科学的发现。四个星期后她来做检查。她对自己的卵巢太好了，她感激它并向它展示了自己真实的生活。虽然这些并不像她的才智那样显赫。玛利·珍妮利用卵巢囊肿完成了一次改变自己的旅程。她重新把身体的规劝和生活、工作的乐趣联结在了一起。

康妮：限制自己的创造力以迎合外界的认可 康妮 38 岁时左侧卵巢出现了六厘米大的囊肿。手术切除了囊肿，保留了一些左侧卵巢的正常组织。她在有囊肿时曾考虑是否生个孩子。在给她做手术时，我们曾进行讨论，我问她是如何使囊肿长得这样大，并让她通过体会它的变化和增长来予以理解。她说，她的工作令她窒息。她很想去从事制陶业，事实上，她非常擅长这一行。她常常能卖掉自己空余制作的陶器。但是，她的工作具有很多的“好处”。我劝她权衡一下，是否值得为了“好处”而抹杀了自己。

手术后一年，康妮又来到我的诊室，她再次体验到了左侧的疼痛，那是曾经有卵巢囊肿的部位。这次没有囊肿，但是，疼痛却是相同的。她发现，一旦开始工作，疼痛就会发作，并且会越来越糟糕。这次是她的身体向她大声发话了。她已经做过一次手术，然而种种因素继续涌向从前有囊肿的部位，这是由于她体内的能量模式还没有得到改变。

康妮理智地意识到这种窘境，并认为有些东西需要改变。但是，在内心深处，每当她想离开目前的工作去寻求发展自己的爱好时，总能听到她父亲的声音，这声音仿佛就在耳边：“你真蠢，丢掉自己稳定的工作。制作艺术不是工作，那只是个爱好，是你工作之余所能做的。”她从孩童时期就相信父亲的话。因此，她让外部力量控制了自己天生的创造力。同时，她否认由于这一情况而引起的气愤和不满。

我让康妮想想，如果只有六个月生存时间，她将做什么。她想了好长时间。最后，她很疲倦、沮丧和痛苦，她说，她要请公司同意给她三个月假以安排一下优先处理的事情。痛苦几乎立刻就消失了。她的能量得以恢复，她的艺术才华也得以发挥。她的挑战在于平衡自己的创造需要与工作的关系。

当她第一次请假后回来工作时，她的公司给她安排了一个与从前不同的职位，在这一职位上她不必与公众直接打交道。相反，她要在幕后工作，处理日常的文书和发票。这一变化只短暂地适合了她的需要。这不是她满意的工作，她还得让自己生活的很多方面受控于来自父亲和老板的需要。在对其盆腔进行彻底的常规检查后三个月，她的左侧卵巢发展成了一个很大的早期癌症性肿瘤。肿瘤长得如此之快，她能从腹壁看到一个凸起物，而一周前还是看不到的。手术时，发现这是“边界肿瘤”，即处于良性和恶性之间的肿瘤。当时，肿瘤的增长只局限于左侧卵巢。因此，在咨询了妇科肿瘤专家后，只切除了左侧卵巢，保留了子宫和正常的右侧卵巢。

不管怎样，她现在深刻地明白了，她的创造力极想表现出来，而她的身体将

不满足于一切，除非服从于她体内深处的规劝。她辞去了工作，花大量的时间制作陶器。她计划回学校学习完整的医学理论。我最近见她时，看到过去三年一直蒙着她的沮丧的面纱被揭去了。别人从不理解她的创造力，但这并不意味着她不能与他们建立良好的关系。她还领悟到，不能让像她那样的女性对自己多年来一直选择剥夺自己的创造力的行为负责。她把自己卵巢的信息称作“心脏上的一脚”，认为那是确实需要的。她真让人高兴。

卵巢癌

很多美国妇科专家接受了这样一个训练，即妇女 40 岁后如果骨盆需要做任何手术，就将卵巢切掉。这样做的理由是防止卵巢癌。在美国，80 个妇女中有一个会受卵巢癌的影响。这就意味着我们国家成千上万个妇女正把正常的器官切除，以防止出现影响这些器官的条件。而这种影响是很小的。成千上万的妇女被剥夺了这些内分泌器官提供给她们的好处。事实上，过早地把卵巢切除会有引发骨质疏松症、心脏病和一系列的绝经症，还会使皮肤增厚，这会导致衰老，可能更容易受伤。

目前的医学依然急于为了防止可能的癌症而切除卵巢，而这样做会影响各种相关的因素。为防止癌症而切除卵巢主要是基于以下两种设想：（1）在子宫切除时预防性地切除卵巢会降低卵巢癌的发病率；（2）妇女自身的激素很容易被激素药物所取代。但是，研究表明，第一种设想经常是不正确的。在没有得卵巢疾病时，卵巢会在体内适当的部位。除非被确认有明显的卵巢疾病的危险。这种情况适用于某个妇女，她的一个或多个一级女性亲属得过卵巢癌。（参见关于遗传病的资料。）另外合成的激素不能够与正常的卵巢产生的雄性激素、孕激素及雌性激素的混合物相匹敌。一旦考虑给病人服用药物，必须把服药所引起的副作用以及那些阻止药物吸收，妨碍其发挥作用和不能使卵巢保留更长久的各种不良因素排除。

我们需要另一种无需牺牲我们卵巢的方法来防止癌症。明白了卵巢规劝就掌握了解决这一问题的钥匙。卵巢癌可能是由无法排解的气愤和怒火形成的能量引起的。这种能量在人体被编成密码。妇女可能还意识不到这种密码。当某位妇女的同事或老板时常对她发火，她也许愤愤不平，这时上述的能量就会出现。妇女可以在工作上愤愤不平，然而，这同样会影响她的卵巢。深陷于这种关系中的妇女由于害怕在生理上、感情上或者金钱上的崩溃，而不相信自己具有改变环境的内在能力。她缺乏对自己天生力量的了解。有时，她的身体会通过卵巢来提醒她，特别是当她因为环境而感到气愤、恼火或者责备别人时。（请记住，子宫比卵巢更具有消极的能量。）

尽管其他选择更适合她，而这种妇女更愿意相信，她在被迫违背自己的意愿而处在目前的关系中。她不自觉地受到了行为方式的控制。关于这一点，我曾在第四章讨论过。如果妇女处于这种愤怒不平的关系中，而且在这一关系中，她在不断地受感情或者生理上的污辱，用能量的术语来说，她在被消耗。不论是她，还是她愤愤不平的搭档，抑或是她愤愤不平的工作环境都不承认她天生的尊严和内在的创造力。因此，她的尊严被剥夺了。这种妇女经常对自己的怒火——一种能量感到无能为力。如果她的这种怒火得到承认或发泄会有助于她改变现状。还有一个无能为力的因素是，她相信，她的工作、她的丈夫或者其他外界力量在控制着她。最后，她的精神创伤在某种程度上本不该出现和起作用。然而，在很多愤愤不平的情况下，妇女们感到无能为力，丈夫、老板或其他外界权威很少对他们所进行的持续的虐待负责，他们也无法证实这种创伤。为了与这种环境妥协，妇女们在这种情况下经常责备自己，或者是将气愤和怒火深深地埋在自己心里。她们经常担心，如果她们的感觉被别人知道，那她们就完了。这种妇女可以开始听听她们身体的规劝。她们的内部指导系统会帮助她们改变现状，这在她们的生活里是十分必要的。

“金铐”综合征

很流行的看法是，把卵巢癌与很高的社会经济地位联系起来。处于较高社会经济地位的妇女经常受“金铐”综合征的困扰。这种妇女对自己的婚姻、工作不满意，甚至藐视自己的丈夫及他工作，然而，正是她的丈夫和他的工作给她提供了丰厚的钱财，使她能够度过奢华的假期，居住漂亮的房间，出入时髦的俱乐部。由于害怕一旦离开这一环境就会失去这些“好处”，她会留在这一环境中，同时把她的感情深藏于内，感觉到痛苦和某种程度的欺骗。

我见过一些患有卵巢癌的妇女，她们是由她们的丈夫陪伴着到我的诊室的。很显然那种责备的能量是源自于这些男人。他们的出现突然唤起了我那种脆弱、防范、抵御的感觉。虽然他们什么也没有说，我敢肯定，他们在无声地批评着我和我的诊室。有个男人临走同我握手时竟然没有看看我。这个男人和他的妻子走后，我对我的护士说：“一个女人怎么能一辈子和这样的男人生活在一起呢？他在场时我感觉像被痛打了一顿。”

卵巢癌的种类很多，对它们进行详尽的描述完全不在本书探讨的范围内。一般情况下，当某种卵细胞开始长出反常组织时癌症就会发生。卵巢癌会发展得很快。我知道的所有妇科专家几乎都有这样的经历，即看到一个妇女在进行正常盆腔检查后三至六个月卵巢癌已充满骨盆，卵巢癌发展的速度快、范围广。

可能的帮助

常规的医学知识还不清楚是什么导致了卵巢癌，尽管一些流行的看法认为它与高脂肪和奶制品的食用有关。一旦人体第二权轮出现能量障碍，这些环境因素就能阻塞系统，导致人体细胞的疾病。研究表明，卵巢癌患者比健康人多食用7%的黄油、牛奶、牛肉，她们食用更多的酸乳酪、家制奶酪和冰激凌。越高的社会经济地位，越丰富的食物，卵巢癌的发病率越高。瑞典、丹麦和瑞士等国家奶制品食用量大，因此，那里的卵巢癌发病率最高。日本、新加坡等国家奶制品食用量少，因而，那里的卵巢癌发病率也最低。奶制品在被消化过程中产生半乳糖，

而这种半乳糖物质与卵巢癌有关。家制奶酪和酸乳酪显然是导致卵巢毒素产生的最大元凶。原因是，这些食物中的奶糖被预先消化成半乳糖，而身体是不需要完成这一步的。同时，妇女们不能忍受乳糖，而这种不能忍受食用奶制品的习惯倒少了一份得卵巢癌的危险。

一些研究涉及了最常见的卵巢癌，即上皮癌，是由于外生殖器或卫生巾上敷用的滑石粉引起的。滑石粉可通过子宫和阴道进入骨盆腔，再进入输卵管。滑石等物质可能会刺激卵巢表皮，这也是导致癌症的危险因素。这一点已经得到实验的验证。例如，将碳粒放到阴道口的部位，在很短的时间时，这些碳粒便通过盆腔器官进入骨盆腔。还有一些因素与卵巢癌有关。

损害卵母细胞（卵巢卵）的各种毒素可能增加妇女得癌症的危险。

辐射、流行性腮腺炎、多环碳氢化合物（存在于烟卷、咖啡因和丹宁酸中）。

大量的促性腺激素可能导致卵巢癌，尽管不是所有的研究都能证实这一点。服用避孕药者得卵巢癌的危险小。这是因为它能减少促性腺激素，减轻对卵巢的刺激。因此，我们假定促性腺激素与卵巢癌有关。相反，生育药物促进促性腺激素的增长，因此，这些生育药物被预想为与卵巢癌有关。

长期大量的雄性激素雄烯二酮。发现它与卵巢癌有关的研究者在做研究时没有取得大量促性腺激素与卵巢癌之间的关系的任何结果，但是，他发现了雄性激素与卵巢癌的相对紧密的关系。

一些研究表明，通过输卵管结扎和子宫切除的方法，输卵管癌的危险已降低了 37%。这样做的解释是，外部生殖器到内部盆腔的通道被永久性地堵死了。

这些数据告诉我们，妇女们 35 岁以后促性腺激素开始增加时，由于担心得卵巢癌，可考虑避免或减少食用奶制品，尤其是酸乳酪和家制奶酪。这些数据没

有建议所有的妇女 40 岁后继续服用避孕药物，而如果不服用避孕药，也是危险的。

诊 断

对卵巢癌进行早期诊断的最大困难在于它很少有症状。模糊的腹部疼痛，例如消化不良常被人们作为引证。但不幸的是，很多问题都可引起这类疼痛。

卵巢癌大多在其晚期才被发现，而这时已经是不可治愈了。我们至今仍没有一种卵巢癌早期图像诊断方法，我们只能做到预防。许多妇女请求做超声像图像检查和 Ca—125 等血液检查。不幸的是，没有一种检查可以明白无误地回答是否已得了卵巢癌。这真是对卵巢癌图像检查的一种嘲弄。

一些身体正常的妇女会对高精度的 Ca—125 指数产生焦虑和恐惧。但是，高精度指数本身并不意味着是卵巢癌。子宫内膜异位、纤维瘤、肝病和其他一些不明因素也会产生高精度指数。手术进行腹腔镜检查和盆腔探查前，谁也不能保证一切都是正常的。当腹腔镜检查的结果不能与 Ca—125 指数相符时，妇女们又陷入了对这一不明来历的反常现象的焦虑和恐惧。

与此同时，如果妇女的 Ca—125 指数是正常的，也不能保证她没有患卵巢癌。（卵巢已切除的妇女，其中 10% 会继续在盆腔的腹膜内壁引发另一种形式的癌症。虽然，这种癌症不是发生在卵巢里，但它看上去和所起的作用恰恰像卵巢癌！）一句话，Ca—125 检查在大多数情况下是不可相信的，不可用于卵巢癌的图像检查。

卵巢癌真使妇女和医生们陷入了进退两难的窘境，它需要一种完全不同于我们已经应用了 40 年的诊断方法。正如一位我们医学中心的妇科癌症专家在一次会议上所说：“看起来，一切事物最初都是成功的，但是，没有什么能长久。当

它们过时的时候，请唤醒我吧！”在卵巢癌问题中，免疫系统因素、感情因素、营养因素和遗传因素的相互作用值得我们用创造性的方法做进一步的探究。

卵巢癌家族病史

一个妇女，如果她的母亲、姐妹以及表姐妹、姨母等患有卵巢癌，那么她得卵巢癌的危险性要比平常人大。家族性卵巢癌在吉尔达·拉德那故事中已引起了公众注意。一些有很强的卵巢癌家族病史的妇女采取了预防性的卵巢切除。然而，对有卵巢癌家族病史的妇女来说，预防性的卵巢切除并不能完全预防这类疾病。在卵巢切除后，卵巢癌的一些难以察觉的癌症因素会依然存在于骨盆腔腹膜内壁的细胞中。

我观察到，那些看到自己亲密的朋友死于卵巢癌的妇女，由于害怕，大多倾向于做卵巢切除，尽管这也许不科学，然而，我发现，我们生活中很多决定的做出都是基于我们的情感因素而非统计数字。

每当这种疾病在家族中产生，我们需要明白，我们不仅要从遗传学的角度来看待这一问题，各种生活的态度也在家族中起着作用。过去我曾很高兴地研究那些有卵巢癌家族病史但没有得卵巢癌的妇女。很多情况是这样的，那些打破家族模式和离开宗族的妇女虽有卵巢癌家族病史但却不染此症。

做其他骨盆手术时把卵巢切除

当妇女选择了做子宫切除或子宫纤维瘤切除时，她必须还得做出决定是否切除卵巢。我在给每位妇女做手术前都要先问她对卵巢癌的畏惧程度，并且检验一下她对自己卵巢的感觉。我告诉她，在手术前，我们不能辨别清楚卵巢的情况。手术时发现有问题，即刻做卵巢切除。

如果患者决定保留卵巢，她要知道，这会推迟我在手术时对其卵巢是否反常做出及时的判断。我的患者们知道，我是倾向于友好地对待卵巢的。偶尔，有些妇女希望在手术时保持清醒，我们可以当时讨论这一决定，这对我来说太好了。我拒绝替患者做出决定是否切除卵巢。我们每个人在做出切除身体某一部位的决定时，有很多因素，包括有意的和无意的都会起作用。

正如您想象的那样，很多患者在做子宫切除时保留她们的卵巢，因为她们和我一样珍视自己的女性器官。尽管我所接受的职业训练在引导我相信，妇女 35 岁就该做卵巢切除，我现在已经超过这一年龄，我珍视自己的卵巢，把它视为一生都会不断支持我的身体的一部分。我知道，它们是我内部指导系统的一部分，它们会告诉我是否需要为了它们的健康而对其进行调整。

大多数妇科专家在规模很大的大学中心接受培训，因为那里有特殊的条件。在那里一周诊治的卵巢癌患者比一般的开业妇科专家十年里见得还多。因此，妇科专家再也不会见到比培训期间更多的卵巢癌了。这一点容易使他们对卵巢癌有自己的偏见。卵巢癌很难发现，很难治疗。它经常表现为疼痛、周期性肠阻塞、腹内大量积液及各种极为不适的症状。一个见过死于卵巢癌患者的医生，在患者与卵巢癌的关系上更易有偏见，尽管大多数妇女将不会得卵巢癌。

我曾在一所医院，即我国的一个主要治疗中心工作过。在那里，妇科肿瘤专家可以见到很多卵巢癌患者。我们的一位病理学家说：“我害怕卵巢癌。我建议我妻子 40 岁时做卵巢切除，而且我想，她应该做预防性的乳房切除手术。”他说这些时语气不甚严肃。但是，正是这位医生在花大量的时间对所有东北部地区死于卵巢癌和乳癌的妇女做尸体解剖。每天目睹这些成了他工作的一部分。他切开肿瘤获取手术标本，在这些标本中妇女的子宫、输卵管甚至阴道、膀胱和直肠都被肿瘤代替了。他见到乳癌细胞已侵蚀到胸壁。他对自己的工作方式感到有些怀疑，但他对妇女做常规的卵巢切除的拥护是毫不怀疑的。

常规治疗

最近 40 年来，卵巢癌的死亡率没有明显的降低。它是一种很难治疗的疾病。常规的治疗为外科手术，有时辅以化学疗法和辐射疗法，还要看它扩散到何种程度。其诊断本身也是在做某种骨盆手术时才得以确定的。如果不看腹内和做活组织的检查，医生就没有办法区分卵巢肿瘤是良性还是恶性。

如果卵巢肿瘤长成恶性的，治疗通常为切除卵巢，切除输卵管，切除子宫，切除网膜（覆在肠上的脂肪），切除其他扩散到骨盆的肿瘤。也有一些例外，这不在本书讨论的范围内。在卵巢癌的早期，手术是有疗效的。

我的一位死于卵巢癌的患者，在她人生的最后一个月更多的是治疗处理自己生活上和感情上的问题，这是她从前不曾有过的。她做了大面积的手术，并且辅以营养治疗。她做了所有“正确”的事情，但是，肿瘤依然在扩大。物理疗法不是治疗她的合适方法，尽管她的治疗正在进入寻求物理治疗的阶段。我的一位医生朋友用冥想的方法治疗她的疼痛，在她处于放松状态时，我的朋友请她问问自己的身体，是什么在营养着她的肿瘤。她回答说：“是恐惧和悲伤。”我的朋友于是就请她回忆和重新体验她不曾恐惧和悲伤的情景。她又回到了自己 12 周时在母亲子宫里的情境。她母亲试图服红白药片做流产。在她的最后几天里，她能清楚地把这一信息告诉给她的母亲。她的母亲多年前也在这里接受过类似的治疗。我的病人最后在她母亲的怀里闭上了眼睛。

关心你的子宫、卵巢和骨盆空间

要知道，以你的卵巢为标志的内在创造力会时常光顾你，不管它们是否存在你体内存在具体的生理形式。

你是否在进行创造性的工作，使自己忘记了时间？

你是否沉浸在某种活动和过程中使自己忘记了吃饭？那么这些都是什么呢？

让自己每天都做些对自己有意义的具有创造性的事情，它使你时刻念念不忘。

你所创造的东西具有自己的生命吗？你会以做一个能尽情发挥创造力的女性而感到自豪吗？你希望和试图控制你所创造的东西吗？

外部世界强烈地需要你的创造力。当你全面地发挥它，而不是想控制和压抑它时，这种创造力会很好地为你和他人服务。要意识到你卵巢的力量——你女性的本领。

一手情感资源请加微信：kc58567 微信：tushu959